



Buku Ajar **KOMUNIKASI KEPERAWATAN**

M. Hasinuddin • Aini Alifatin • Aemilianus Mau • Wahyu Endang Setyowati

Editor: Prof. Dr. Hj. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes.



BUKU AJAR

KOMUNIKASI KEPERAWATAN

Penulis:

Prof. Dr. M. Hasinuddin, S.Kep., Ns., M.Kep.

Aini Alifatin, S.Kp., M.Kep.

Dr. Aemilianus Mau, S.Kep., Ns., M.Kep.

Dr. Wahyu Endang Setyowati, SKM., M.Kep.

Editor:

Prof. Dr. Hj. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes.

Buku Ajar Komunikasi Keperawatan

Penulis:

Prof. Dr. M. Hasinuddin. S. Kep. Ns. M. Kep.
Aini Alifatin, S.Kp., M. Kep
Dr. Aemilianus Mau., S.Kep., Ns., M.Kep
Dr. Wahyu Endang Setyowati, SKM., M.Kep

Editor:

Prof. Dr. Hj. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-7927-11-8

Cetakan Pertama: September, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Buku Ajar Komunikasi Keperawatan** ini dapat diselesaikan. Buku ini disusun sebagai referensi akademik yang membahas konsep dan penerapan komunikasi dalam praktik keperawatan secara sistematis, profesional, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Komunikasi merupakan salah satu kompetensi fundamental dalam keperawatan karena menjadi dasar dalam membangun hubungan terapeutik, memahami kebutuhan pasien, meningkatkan kepercayaan, serta mendukung keberhasilan intervensi keperawatan. Oleh karena itu, buku ini menghadirkan pembahasan mengenai berbagai situasi komunikasi yang kompleks dengan mempertimbangkan aspek klinis, psikologis, budaya, spiritual, dan etik dalam pelayanan kesehatan.

Buku ini terdiri atas empat bab yang membahas berbagai aspek penting dalam komunikasi keperawatan. Bab pertama menguraikan komunikasi dalam situasi sulit, seperti menghadapi pasien marah, cemas, menolak tindakan, dan mengalami agitasi. Pembahasan mencakup konsep dasar, tujuan, indikasi, kontraindikasi, persiapan, langkah komunikasi terapeutik, aspek keselamatan pasien, evaluasi, dokumentasi, hingga aktivitas penerapan komunikasi berbasis tingkat kompetensi. Bab kedua membahas komunikasi pada populasi khusus, meliputi anak, lansia, individu dengan gangguan jiwa, dan penyandang disabilitas. Materi mencakup landasan teori, pendekatan komunikasi dalam asuhan keperawatan, asesmen, serta identifikasi kondisi yang memerlukan perhatian khusus dalam komunikasi.

Selanjutnya, buku ini membahas komunikasi budaya dan spiritual transkultural yang menekankan pentingnya sensitivitas terhadap bahasa, nilai, keyakinan, serta keberagaman latar belakang pasien dalam pelayanan kesehatan. Bab terakhir menguraikan komunikasi dalam kondisi kedaruratan dan krisis, termasuk penyampaian kabar sulit (*breaking bad news*), penyelesaian konflik, komunikasi eskalasi, serta tantangan psikososial dalam situasi krisis. Dengan penyajian materi yang terstruktur dan berbasis praktik keperawatan, **Buku Ajar Komunikasi Keperawatan** diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa keperawatan, pendidik, perawat, dan tenaga kesehatan dalam mengembangkan kemampuan komunikasi terapeutik yang efektif, empatik, aman, serta sesuai dengan prinsip profesionalisme keperawatan.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB 1 KOMUNIKASI DALAM SITUASI SULIT: MARAH, CEMAS, MENOLAK TINDAKAN, DAN AGITASI	1
A. Defenisi	5
B. Tujuan.....	5
C. Indikasi	5
D. Kontraindikasi.....	6
E. Alat dan Bahan	6
F. Persiapan.....	6
G. Langkah Prosedur (Komunikasi Terapeutik dalam Situasi Sulit).....	6
H. Hal yang Harus Diperhatikan (Patient Safety)	7
I. Komplikasi (Jika Komunikasi Tidak Tepat)	7
J. Evaluasi Hasil.....	8
K. Dokumentasi.....	8
L. Aktivitas 1 — <i>Knows How</i>	9
M. Aktivitas 2 — <i>Shows How</i>	9
N. Rangkuman Materi	40
O. Tabel Red Flags & Eskalasi.....	36
P. Daftar Pustaka	40

BAB 2 KOMUNIKASI PADA POPULASI KHUSUS: ANAK, LANSIA, GANGGUAN JIWA, DAN DISABILITAS	43
A. Pendahuluan.....	46
B. Landasan teoretik.....	47
C. Asuhan keperawatan komunikasi pada populasi khusus	65
D. Asesmen	98
E. Rangkuman Materi	103
F. Redflag	102
G. Daftar Pustaka	103

BAB 3 KOMUNIKASI BUDAYA DAN SPIRITUAL TRANSKULTURAL, BAHASA, DAN SENSITIVITAS NILAI	117
A. Konsep Keperawatan Transkultural dan Strategi Komunikasi	119
B. Komunikasi Sensitif Bahasa dalam Pelayanan Kesehatan	131
C. Integrasi Spiritualitas dan Sensitivitas Nilai	132
D. Latihan Terstruktur.....	133
E. Ringkasan Bab	135
F. Daftar Pustaka	136

BAB 4 KOMUNIKASI DALAM KEDARURATAN DAN KRISIS: KABAR SULIT, KONFLIK, ESKALASI.....	137
A. Landasan Teoretis dan Etik Komunikasi Krisis	148
B. Komunikasi Kabar Sulit (<i>Breaking Bad News</i>).....	149
C. Komunikasi Kabar Konflik	153
D. Komunikasi Kabar Eskalasi (<i>Escalation Communication</i>).....	157
E. Tantangan Psikososial dan Penguatan Kompetensi Perawat dalam Komunikasi Kedaruratan dan Krisis	158
F. Aktivitas 1 — Knows How	161
G. Aktivitas 2 — Knows How	162
H. Daftar Pustaka	170

PROFIL PENULIS	Error! Bookmark not defined.
-----------------------------	-------------------------------------

BAB 1

KOMUNIKASI DALAM SITUASI SULIT: MARAH, CEMAS, MENOLAK TINDAKAN, DAN AGITASI

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep dasar komunikasi keperawatan, etika komunikasi profesional, dan dampaknya terhadap keselamatan pasien.	CPMK-1; CPMK-2
CPL-2	Mampu membangun hubungan terapeutik dan melakukan wawancara/pengkajian komunikasi secara empatik, terstruktur, dan berpusat pada pasien–keluarga.	CPMK-3; CPMK-4
CPL-3	Mampu menerapkan komunikasi nonverbal, validasi pesan, dan strategi menghadapi hambatan komunikasi untuk meningkatkan kualitas asuhan.	CPMK-2; CPMK-5
CPL-4	Mampu melakukan komunikasi interprofesional, kolaborasi, dan handover terstruktur untuk kesinambungan layanan yang aman.	CPMK-6; CPMK-7
CPL-5	Mampu berkomunikasi efektif pada situasi sulit/krisis serta populasi khusus dengan mempertimbangkan budaya, spiritual, dan keselamatan.	CPMK-5; CPMK-6
CPL-6	Mampu mendokumentasikan komunikasi klinis, memahami aspek legal, melakukan refleksi profesional, dan perbaikan praktik komunikasi berbasis evaluasi.	CPMK-7; CPMK-1

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-3	Menerapkan komunikasi terapeutik dan membangun hubungan perawat-klien sesuai fase, teknik, dan batas profesional.
CPMK-5	Menerapkan komunikasi nonverbal, validasi pesan, dan strategi komunikasi pada situasi sulit serta populasi khusus secara aman.
CPMK-6	Menerapkan komunikasi interprofesional, kolaborasi tim, negosiasi, dan eskalasi untuk koordinasi layanan yang efektif.

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 8. Komunikasi dalam Situasi Sulit: Marah, Cemas, Menolak Tindakan, dan Agitasi	8.1 Mengidentifikasi pemicu emosi dan kebutuhan pasien pada situasi sulit untuk menentukan strategi respons.	8.2 Melaksanakan de-eskalasi verbal dan negosiasi tindakan dengan menjaga keselamatan dan batas profesional.	CPMK-5	CPMK-6; CPMK-3

Tabel Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-3	OSCE komunikasi terapeutik + checklist	Persentase ketercapaian teknik fase hubungan, batas profesional, dan respons empatik (tanpa kesalahan kritis).	15	Checklist OSCE; rekaman
CPMK-5	Simulasi situasi sulit/populasi khusus + rubrik	Ketepatan de-eskalasi/validasi pesan dan keselamatan komunikasi (skor rubrik).	15	Video/rekaman; lembar rubrik

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-6	Simulasi komunikasi interprofesional & eskalasi + checklist	Kejelasan pesan klinis, kolaborasi, dan ketepatan eskalasi fokus risiko (checklist).	15	Checklist; catatan simulasi

Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4)

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Kinerja komunikasi terapeutik (checklist)	≤60% perilaku tercapai; hubungan tidak terbina	61–75% tercapai; hubungan terbina sebagian	76–90% tercapai; hubungan efektif	>90% tercapai; empatik, adaptif, profesional
3.2 Batas profesional & kontrak terapeutik	Tidak menjaga batas; risiko tinggi	Batas sebagian; kurang konsisten	Batas jelas; konsisten	Batas sangat jelas; konsisten dan aman

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Ketepatan de-eskalasi/validasi pesan	Tidak menurunkan eskalasi; memicu konflik	Menurunkan sebagian; teknik terbatas	Menurunkan eskalasi; teknik tepat	Sangat efektif; teknik komprehensif & aman
5.2 Keselamatan komunikasi pada populasi khusus/situasi sulit	Tidak adaptif; risiko tinggi	Adaptif sebagian; risiko masih ada	Adaptif; risiko minimal	Sangat adaptif; risiko terantisipasi dan mitigasi jelas

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Kejelasan pesan klinis & kolaborasi tim	Pesan tidak jelas; kolaborasi tidak terjadi	Pesan cukup; kolaborasi terbatas	Pesan jelas; kolaborasi efektif	Pesan sangat jelas; kolaborasi sangat efektif & proaktif
6.2 Ketepatan eskalasi fokus risiko	Tidak eskalasi/eskalasi keliru	Eskalasi ada; kurang runtut	Eskalasi runtut; fokus risiko jelas	Eskalasi sangat runtut; fokus risiko tajam + konfirmasi penerimaan

Uraian Materi

A. Defenisi

Komunikasi dalam situasi sulit adalah proses interaksi terapeutik antara perawat dengan pasien atau keluarga yang berada dalam kondisi emosi intens (marah, cemas, menolak tindakan, atau agitasi), yang bertujuan untuk membangun hubungan terapeutik, menurunkan ketegangan, serta memastikan keselamatan pasien melalui pendekatan empatik, terstruktur, dan profesional.

Menurut penelitian terbaru dalam bidang komunikasi klinik, situasi sulit sering kali muncul akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan emosional pasien dan respons tenaga kesehatan, sehingga memerlukan keterampilan komunikasi tingkat lanjut (de-eskalasi, validasi emosi, dan negosiasi terapeutik) (Back et al., 2020; Silverman et al., 2022).

Dalam praktik keperawatan anak, komunikasi tidak selalu berlangsung dalam kondisi ideal. Perawat sering dihadapkan pada situasi yang penuh tekanan, seperti pasien yang marah, keluarga yang cemas, atau anak yang menolak tindakan medis. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik, menghambat asuhan keperawatan, bahkan meningkatkan risiko keselamatan pasien.

Komunikasi dalam situasi sulit menjadi kompetensi inti yang harus dimiliki oleh perawat profesional. Kemampuan ini mencakup keterampilan memahami emosi, melakukan de-eskalasi, serta membangun hubungan terapeutik dalam kondisi yang penuh tekanan.

B. Tujuan

Tujuan komunikasi dalam situasi sulit meliputi:

- 1 Menurunkan ketegangan emosional pasien dan keluarga
- 2 Membangun hubungan terapeutik yang saling percaya
- 3 Mengidentifikasi kebutuhan dan masalah pasien secara tepat
- 4 Mencegah konflik dan perilaku agresif
- 5 Mendukung keberhasilan tindakan keperawatan
- 6 Menjamin keselamatan pasien (patient safety)

C. Indikasi

Komunikasi dalam situasi sulit dilakukan pada kondisi:

- 1 Pasien/keluarga menunjukkan kemarahan
- 2 Pasien mengalami kecemasan tinggi

- 3 Pasien menolak tindakan medis
- 4 Pasien mengalami agitasi atau gelisah
- 5 Terjadi konflik antara pasien/keluarga dengan tenaga kesehatan
- 6 Situasi dengan risiko keselamatan pasien

D. Kontraindikasi

Tidak ada kontraindikasi absolut, namun perlu kewaspadaan pada:

- 1 Pasien dengan gangguan kesadaran berat
- 2 Pasien dengan perilaku agresif fisik yang mengancam keselamatan
- 3 Kondisi kegawatdaruratan yang memerlukan tindakan segera

Pada kondisi ini, komunikasi tetap dilakukan tetapi dengan prioritas keselamatan dan kolaborasi tim.

E. Alat dan Bahan

Komunikasi dalam situasi sulit tidak selalu membutuhkan alat medis, namun memerlukan:

- 1 Lingkungan yang tenang dan aman
- 2 Kursi/ruang komunikasi yang nyaman
- 3 Alat distraksi anak (mainan, buku, video)
- 4 Media edukasi (gambar sederhana, leaflet)
- 5 APD bila diperlukan

F. Persiapan

- 1 Persiapan Perawat
 - a. Memahami kondisi pasien
 - b. Mengontrol emosi diri
 - c. Menguasai teknik komunikasi terapeutik
 - d. Bersikap empatik dan tidak defensif
- 2 Persiapan Pasien
 - a. Pastikan pasien dalam kondisi aman
 - b. Identifikasi kebutuhan emosional
 - c. Sesuaikan pendekatan dengan usia (anak)
- 3 Persiapan Lingkungan
 - a. Lingkungan tenang
 - b. Minim stimulus berlebihan
 - c. Privasi terjaga

G. Langkah Prosedur (Komunikasi Terapeutik dalam Situasi Sulit)

- 1 Tahap 1: Orientasi
 - a. Perkenalan diri
 - b. Menjelaskan tujuan
 - c. Membangun rasa aman
- 2 Tahap 2: Pengkajian Emosi
 - a. Identifikasi emosi (marah, cemas, takut, agitasi)
 - b. Identifikasi penyebab
- 3 Tahap 3: Komunikasi Terapeutik
 - a. Active listening
 - b. Validasi emosi
 - c. Gunakan bahasa sederhana
- 4 Tahap 4: De-eskalasi
 - a. Nada suara tenang
 - b. Hindari konfrontasi
 - c. Jaga jarak aman
- 5 Tahap 5: Edukasi dan Negosiasi
 - a. Jelaskan tindakan secara sederhana
 - b. Libatkan keluarga
 - c. Negosiasi tanpa memaksa
- 6 Tahap 6: Evaluasi
 - a. Nilai respons pasien
 - b. Pastikan pemahaman

H. Hal yang Harus Diperhatikan (Patient Safety)

- 1 Tidak memaksakan tindakan
- 2 Mengenali red flags (agitasi, agresi)
- 3 Menjaga keselamatan pasien dan tenaga kesehatan
- 4 Menghindari komunikasi yang memicu konflik
- 5 Melakukan eskalasi bila diperlukan

WHO (2021) menegaskan bahwa komunikasi efektif merupakan salah satu pilar utama keselamatan pasien.

I. Komplikasi (Jika Komunikasi Tidak Tepat)

- 1 Konflik dengan pasien/keluarga
- 2 Penolakan tindakan
- 3 Trauma psikologis pada anak
- 4 Risiko cedera akibat agitasi
- 5 Kesalahan tindakan medis

J. Evaluasi Hasil

Komunikasi dianggap berhasil jika:

- 1 Emosi pasien/keluarga menurun
- 2 Pasien lebih kooperatif
- 3 Tidak terjadi konflik
- 4 Tindakan dapat dilakukan dengan aman
- 5 Pasien/keluarga memahami informasi

K. Dokumentasi

Dokumentasi meliputi:

- 1 Kondisi emosional pasien/keluarga
- 2 Proses komunikasi yang dilakukan
- 3 Respon pasien/keluarga
- 4 Edukasi yang diberikan
- 5 Tindak lanjut

L. Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Contoh:

Anak usia 5 tahun menolak pemasangan infus, menangis, dan berteriak. Ibu tampak cemas.

Tugas:

1. Analisis masalah komunikasi
2. Tentukan strategi
3. Buat respon terapeutik

M. Aktivitas 2 — *Shows How*

Simulasi:

1. Komunikasi anak
2. Edukasi keluarga
3. De-eskalasi

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Deskripsi	Implementasi pada Bab
Knows	Pengetahuan	Teori komunikasi situasi sulit
Knows How	Analisis	Mini case
Shows How	Demonstrasi keterampilan	Simulasi komunikasi situasi sulit (OSCE)
Does	Praktik nyata	DOPS di klinik

OSCE Ringkas + Critical Items

Judul:

Komunikasi pada Anak Menolak Tindakan

Kompetensi:

1. Komunikasi terapeutik
2. Negosiasi
3. Profesionalisme

Critical Items:

1. Empati
2. Keselamatan pasien
3. Tidak memaksa

Cuplikan Rubrik

Kriteria	4	3	2	1
Keselamatan pasien	Aman & konsisten	Minor	Risiko kecil	Tidak aman
Asesmen & keputusan	Tepat & jelas	Cukup	Ragu	Keliru
Komunikasi	Empatik & jelas	Baik	Kurang	Buruk

Catatan untuk penulis:

- Nilai tinggi tidak menutup kegagalan keselamatan

DOPS

Penilaian praktik nyata:

- Interaksi dengan pasien sulit
- Komunikasi keluarga
- Manajemen konflik

PORTOFOLIO

Isi:

- Video simulasi
- Refleksi
- Feedback

REFLEKSI

Contoh:

“Saya belajar bahwa komunikasi empatik dapat menurunkan resistensi pasien dan meningkatkan keselamatan tindakan.”

RINGKASAN

- Situasi sulit adalah hal umum
- Komunikasi adalah kunci
- De-eskalasi lebih efektif
- Anak butuh pendekatan khusus
- Keselamatan pasien prioritas

EVALUASI

1. Jelaskan komunikasi situasi sulit
2. Strategi menghadapi pasien marah
3. Teknik de-eskalasi
4. Peran komunikasi dalam patient safety

Contoh:

TEMPLATE SOAL OSCE KEPERAWATAN

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	 (Dikosongkan)
2	Judul station	Komunikasi Terapeutik pada Anak Menolak Tindakan dan Orang Tua Cemas
3	Waktu yang dibutuhkan	10–12 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan komunikasi terapeutik pada situasi sulit, meliputi identifikasi emosi pasien dan keluarga, de-eskalasi, edukasi, dan negosiasi tindakan secara aman.
5	Kompetensi	1. Komunikasi terapeutik 2. Identifikasi emosi pasien/keluarga 3. Edukasi dan konseling 4. Negosiasi tindakan 5. Keselamatan pasien 6. Perilaku profesional
6	Kategori	1. Psikososial 2. Aman dan nyaman 3. Komunikasi terapeutik 4. Perilaku pasien 5. Patient safety
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang anak laki-laki usia 5 tahun dirawat di ruang anak dan akan dilakukan pemasangan infus. Anak tampak menangis keras, menolak tindakan, dan berusaha menarik tangannya. Ibu tampak cemas dan berkata, "Anak saya takut, jangan dipaksa!" TUGAS: 1. Lakukan komunikasi terapeutik pada anak dan ibu pasien. 2. Identifikasi emosi pasien dan keluarga. 3. Lakukan de-eskalasi situasi. 4. Lakukan edukasi sederhana terkait tindakan yang akan dilakukan. 5. Lakukan negosiasi agar tindakan dapat dilakukan secara aman.

No.	Komponen	Isi
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Seorang anak laki-laki usia 5 tahun dirawat di ruang anak dan akan dilakukan pemasangan infus. Anak tampak menangis keras, menolak tindakan, dan berusaha menarik tangannya. Ibu tampak cemas dan berkata, "Anak saya takut, jangan dipaksa!" INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai kemampuan peserta dalam mengidentifikasi emosi anak dan ibu (takut, cemas). 2. Menilai kemampuan komunikasi empatik (verbal dan nonverbal). 3. Menilai kemampuan peserta dalam melakukan de-eskalasi (nada suara, pendekatan, bahasa). 4. Menilai kemampuan edukasi dengan bahasa sederhana dan sesuai usia anak. 5. Menilai kemampuan negosiasi tindakan tanpa memaksa pasien. 6. Menilai aspek keselamatan pasien (tidak memaksa, menjaga kondisi aman). 7. Menilai perilaku profesional peserta. 8. Penguji tidak diperbolehkan menginterupsi peserta.
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya: 1. Identitas pasien: anak laki-laki usia 5 tahun, KS berperan sebagai ibu. 2. Anak tampak menangis keras, takut, dan menolak disentuh. 3. Ibu tampak cemas, sering mengatakan "anak saya takut disuntik". 4. Bila peserta bersikap kasar → ibu menjadi defensif. 5. Bila peserta empatik → ibu menjadi lebih kooperatif. 6. Anak akan lebih tenang jika diajak bicara lembut atau didistraksi. 7. Harapan ibu: anak tidak trauma dan tindakan bisa dilakukan dengan aman.

No.	Komponen	Isi
10	Setting station	Ruang rawat anak - Tempat tidur pasien - Manekin anak - KS sebagai ibu - Penguji - Laboran Tata letak: 1. Tempat tidur pasien 2. Kursi ibu (KS) 3. Meja penguji 4. Troli alat 5. Wastafel/handrub
11	Peralatan yang dibutuhkan	1. Handrub/hand sanitizer 2. Sarung tangan (opsional) 3. Tisu 4. Mainan/distraksi anak 5. Lembar jawaban peserta Peran laboran: menyiapkan alat dan memastikan kesiapan station
12	Penulis	
13	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) WHO Patient Safety Curriculum

**Sop Edukasi Dan Demonstrasi Pada Komunikasi Dalam Situasi Sulit
(Marah, Cemas, Menolak Tindakan, Dan Agitasi)**

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A. Tahap Pra Interaksi					
1	Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan terkait kondisi pasien dan riwayat perilaku	☐	☐	☐	☐
2	Menyiapkan alat dan lingkungan komunikasi: a) Handrub/sabun cuci tangan b) Tisu c) Alat distraksi anak (mainan/buku) d) Kursi/ruang nyaman e) APD bila diperlukan	☐	☐	☐	☐
3	Mencuci tangan sesuai prosedur	☐	☐	☐	☐

Tahap Orientasi

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
4	Menyampaikan salam terapeutik	☐	☐	☐	☐

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
5	Menyampaikan nama dan peran perawat	☐	☐	☐	☐
6	Mengidentifikasi pasien (nama anak dan umur) secara aktif	☐	☐	☐	☐
7	Menjelaskan tujuan komunikasi dan tindakan yang akan dilakukan	☐	☐	☐	☐
8	Memberi kesempatan pasien/keluarga bertanya	☐	☐	☐	☐
9	Memulai komunikasi dengan pendekatan empatik	☐	☐	☐	☐
10	Menjaga privasi, kenyamanan, dan rasa aman pasien serta keluarga	☐	☐	☐	☐

Tahap Kerja (Sistematis)

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
11	Melakukan hand hygiene sebelum interaksi	☐	☐	☐	☐
12	Mengidentifikasi emosi pasien dan keluarga (marah, cemas, takut, agitasi)	☐	☐	☐	☐
13	Mendengarkan secara aktif tanpa menyela (active listening)	☐	☐	☐	☐
14	Melakukan validasi emosi (misal: "Saya memahami Ibu merasa khawatir")	☐	☐	☐	☐
15	Menggunakan nada suara tenang dan bahasa sederhana	☐	☐	☐	☐

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
16	Menghindari sikap defensif atau menyalahkan	☐	☐	☐	☐
17	Melakukan teknik de-eskalasi verbal untuk menurunkan ketegangan	☐	☐	☐	☐
18	Menggunakan distraksi sesuai usia anak (mainan, cerita, dll)	☐	☐	☐	☐
19	Menjelaskan tindakan/prosedur dengan bahasa yang mudah dipahami	☐	☐	☐	☐
20	Melibatkan keluarga dalam komunikasi dan pengambilan keputusan	☐	☐	☐	☐
21	Melakukan negosiasi tindakan tanpa memaksa pasien	☐	☐	☐	☐
22	Mengidentifikasi red flags (agitasi, agresi, penolakan berat)	☐	☐	☐	☐
23	Menjaga keselamatan pasien selama interaksi	☐	☐	☐	☐
24	Memberikan kesempatan pasien/keluarga mengungkapkan perasaan	☐	☐	☐	☐
25	Memastikan pemahaman dengan metode teach-back	☐	☐	☐	☐
26	Meminta pasien/keluarga mengulang informasi yang telah diberikan	☐	☐	☐	☐
27	Mengatur kembali kondisi pasien agar nyaman dan tenang	☐	☐	☐	☐

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
28	Melakukan kebersihan tangan setelah tindakan	☐	☐	☐	☐

Tahap Terminasi

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
29	Menyimpulkan hasil komunikasi	☐	☐	☐	☐
30	Mengevaluasi respons pasien dan keluarga (emosi dan perilaku)	☐	☐	☐	☐
31	Memberikan reinforcement positif	☐	☐	☐	☐
32	Membuat kontrak tindak lanjut (jika diperlukan)	☐	☐	☐	☐
33	Mengakhiri komunikasi dengan baik	☐	☐	☐	☐

Tahap Dokumentasi

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
34	Mencatat waktu, hasil pengkajian emosi, proses komunikasi, respons pasien/keluarga, dan tindak lanjut	☐	☐	☐	☐

Penampilan Profesional

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
35	Menunjukkan sikap profesional: empatik, sabar, aman, responsif, dan tidak menghakimi	☐	☐	☐	☐

Form Penilaian Osce Keperawatan

Station: Komunikasi Dalam Situasi Sulit (Marah, Cemas, Menolak Tindakan, Dan Agitasi)

1 Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Pengkajian komunikasi & emosi	Mengidentifikasi emosi pasien/keluarga (marah, cemas, takut, agitasi) dan faktor penyebabnya	☐	☐	☐	☐	2	
2	Analisis & perencanaan komunikasi	Menentukan pendekatan komunikasi yang tepat (empati, validasi, de-eskalasi, negosiasi)	☐	☐	☐	☐	2	
3	Implementasi komunikasi terapeutik	Melakukan komunikasi empatik, active listening, validasi emosi, dan penggunaan bahasa sederhana	☐	☐	☐	☐	3	
4	Implementasi de-eskalasi & negosiasi	Melakukan teknik de-eskalasi verbal, distraksi pada anak, serta negosiasi tindakan tanpa memaksa	☐	☐	☐	☐	3	
5	Edukasi pasien/keluarga	Menjelaskan prosedur/tindakan secara	☐	☐	☐	☐	2	

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
		jelas, sederhana, dan sesuai kondisi pasien/keluarga						
6	Keselamatan pasien	Menjaga keselamatan pasien, tidak memaksa tindakan, mengenali red flags, dan melakukan tindakan aman	☐	☐	☐	☐	4	
7	Perilaku profesional	Komunikasi terapeutik, menjaga privasi, sikap empatik, tenang, sistematis, dan responsif	☐	☐	☐	☐	2	
	Jumlah						18	

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN

STATION: KOMUNIKASI DALAM SITUASI SULIT (MARAH, CEMAS, MENOLAK TINDAKAN, DAN AGITASI)

1. Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Pengkajian komunikasi & emosi Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam mengidentifikasi	Tidak melakukan pengkajian atau tidak relevan	Pengkajian sangat terbatas, tidak sistematis	Pengkajian cukup baik namun belum lengkap	Pengkajian lengkap, sistematis, dan tepat	2	

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
si emosi pasien/keluarga (marah, cemas, takut, agitasi), faktor penyebab, serta respons perilaku pasien dan keluarga. Peserta diharapkan mampu melakukan pengkajian secara sistematis dan memahami makna klinis dari emosi yang muncul.						
2. Analisis & perencanaan komunikasi Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam menentukan strategi komunikasi yang tepat berdasarkan kondisi pasien/keluarga, seperti	Tidak mampu menentukan strategi	Strategi kurang tepat atau tidak sesuai	Strategi cukup tepat namun belum optimal	Strategi tepat, jelas, dan operasional	2	

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
empati, validasi, de-eskalasi, dan negosiasi tindakan.						
3. Implementasi komunikasi terapeutik Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam melakukan komunikasi empatik, active listening, validasi emosi, penggunaan bahasa sederhana, serta menjaga hubungan terapeutik secara efektif.	Tidak empatik, komunikasi buruk	Komunikasi terbatas, tidak konsisten	Komunikasi cukup baik namun belum optimal	Komunikasi sangat empatik, efektif, dan adaptif	3	
4. Implementasi de-eskalasi & negosiasi Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam menurunkan ketegangan	Tidak mampu menurunkan eskalasi	Menurunkan sebagian, teknik terbatas	De-eskalasi cukup berhasil	De-eskalasi sangat efektif dan aman	3	

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
situasi, mengelola konflik, menggunakan distraksi pada anak, serta melakukan negosiasi tindakan tanpa memaksa pasien.						
5. Edukasi pasien/keluarga Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam menjelaskan tindakan atau prosedur secara jelas, sederhana, dan sesuai dengan kondisi pasien dan keluarga.	Tidak menjelaskan / tidak jelas	Penjelasan terbatas dan membingu ngkan	Penjelasan cukup jelas	Penjelasan sangat jelas, sistematis, dan mudah dipahami	2	
6. Keselamatan pasien (Patient Safety) Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam menjaga keselamatan pasien, mengenali red	Berisiko / membahay akan pasien	Kurang aman, masih ada risiko	Aman dengan sedikit kekurangan	Sangat aman, risiko terantisipasi	4	

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
flags, tidak memaksakan tindakan, serta memastikan kondisi aman selama interaksi.						
7. Perilaku Profesional Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam menunjukkan profesionalisme, termasuk memperkenalkan diri, komunikasi terapeutik, menjaga privasi, sikap empatik, tenang, teliti, dan responsif.	Tidak profesional	Kurang profesional	Cukup profesional	Sangat profesional dan konsisten	2	
					Jumlah = 18	

2. Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Pengkajian komunikasi & emosi	Tidak melakukan pengkajian emosi pasien/keluarga, atau pengkajian tidak relevan dengan situasi.	Melakukan pengkajian sangat terbatas, tidak sistematis, dan tidak mampu mengidentifikasi emosi utama (marah, cemas, takut, agitasi) secara tepat.	Melakukan pengkajian cukup baik, mampu mengidentifikasi sebagian emosi dan faktor penyebab, namun masih ada data yang terlewat atau interpretasi belum lengkap.	Melakukan pengkajian secara lengkap, sistematis, dan relevan, mampu mengidentifikasi emosi pasien/keluarga, faktor penyebab, serta respons perilaku secara tepat.
2. Analisis & perencanaan komunikasi	Tidak mampu menentukan strategi komunikasi, atau strategi tidak sesuai dengan kondisi pasien/keluarga.	Menentukan strategi komunikasi tetapi tidak tepat atau tidak sesuai prioritas (misal tidak menggunakan empati atau de-eskalasi).	Menentukan strategi komunikasi yang cukup tepat (empati, validasi, de-eskalasi), namun belum optimal atau kurang spesifik.	Menentukan strategi komunikasi secara tepat, sistematis, dan operasional, meliputi empati, validasi, de-eskalasi, dan negosiasi tindakan sesuai kondisi pasien/keluarga.
3. Implementasi komunikasi terapeutik	Tidak melakukan komunikasi empatik, komunikasi tidak efektif, atau memperburuk	Melakukan komunikasi secara terbatas, kurang empatik, tidak konsisten, dan penggunaan bahasa kurang tepat.	Melakukan komunikasi terapeutik dengan cukup baik, menunjukkan empati dan active listening, namun masih	Melakukan komunikasi terapeutik secara op

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
	kondisi pasien/keluarga.		kurang konsisten atau kurang mendalam.	

3. Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

4. Global Performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = $\frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$

(Kota),

.....

Penguji :

DOPS (Does)**DOPS di Lahan Praktik**

Observasi langsung pada Komunikasi dalam Situasi Sulit (Marah, Cemas, Menolak Tindakan, dan Agitasi)

- Checklist + umpan balik singkat
- Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Catatan untuk penulis:

- Dari simulasi → praktik nyata
- Bukti performa sesungguhnya

Tabel. Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Komunikasi dalam Situasi Sulit (Marah, Cemas, Menolak Tindakan, dan Agitasi)

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Komunikasi Situasi Sulit
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa klinik mahasiswa dalam melakukan keterampilan komunikasi terapeutik pada situasi nyata di lahan praktik.	Pembimbing mengamati secara langsung interaksi mahasiswa saat menghadapi anak yang menolak tindakan pemasangan infus dan ibu yang tampak cemas di ruang perawatan anak.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengenalan emosi pasien/keluarga, komunikasi terapeutik, de-eskalasi, edukasi, serta profesionalisme dalam satu encounter klinik.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pemahaman konsep komunikasi, tetapi juga dari kemampuannya menenangkan anak, merespon kecemasan ibu, dan menjelaskan tindakan secara empatik dan aman.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan sesuai dengan capaian pembelajaran komunikasi klinik.	Seorang anak usia 5 tahun akan dilakukan pemasangan infus, menangis keras dan menolak, sementara ibu tampak cemas dan khawatir terhadap prosedur yang akan dilakukan.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan encounter klinik secara utuh sejak awal interaksi hingga penjelasan dan negosiasi tindakan.	Mahasiswa memperkenalkan diri, mengidentifikasi emosi anak dan ibu, menggunakan komunikasi empatik, melakukan distraksi pada anak, menjelaskan prosedur dengan bahasa sederhana, serta melakukan negosiasi agar tindakan dapat dilakukan secara aman.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Komunikasi Situasi Sulit
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi komunikasi terapeutik, identifikasi emosi, kemampuan de-eskalasi, negosiasi tindakan, edukasi keluarga, profesionalisme, dan keselamatan pasien.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu mengenali kecemasan ibu, menenangkan anak, menggunakan bahasa sesuai usia, tidak memaksa tindakan, serta menjaga keselamatan pasien selama proses komunikasi.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas performa mahasiswa secara langsung menggunakan format DOPS yang terstruktur dan berfokus pada perilaku nyata di lapangan.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu menurunkan ketegangan situasi, membangun hubungan terapeutik, serta memastikan tindakan dilakukan secara aman dan diterima oleh pasien/keluarga.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, bersifat spesifik, singkat, dan berorientasi pada perbaikan performa mahasiswa.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi empatik, tetapi perlu meningkatkan teknik distraksi pada anak dan memperjelas penjelasan prosedur kepada orang tua.
Keputusan penilaian	Hasil DOPS digunakan untuk menentukan tingkat performa mahasiswa dalam praktik komunikasi klinik.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan komunikasi secara empatik, menurunkan resistensi pasien, serta menjaga keselamatan. Mahasiswa perlu supervisi jika masih kurang dalam de-eskalasi. Mahasiswa remedial jika komunikasi memicu konflik atau berisiko terhadap pasien.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan	Pada kasus komunikasi situasi sulit, mahasiswa dinilai tidak hanya memahami teori komunikasi, tetapi mampu menerapkannya secara

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Komunikasi Situasi Sulit
	capaian pembelajaran pada level <i>does</i> (praktik nyata).	langsung dalam menghadapi pasien dan keluarga secara aman, efektif, dan profesional.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel. Portofolio pada Komunikasi dalam Situasi Sulit (Marah, Cemas, Menolak Tindakan, dan Agitasi)

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Komunikasi Situasi Sulit
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa klinik mahasiswa dalam melakukan keterampilan komunikasi terapeutik di situasi nyata layanan kesehatan.	Pembimbing mengamati secara langsung interaksi mahasiswa saat menghadapi anak yang menolak tindakan dan orang tua yang tampak cemas di ruang perawatan anak.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan komunikasi terapeutik, pengenalan emosi pasien/keluarga, de-eskalasi, edukasi, dan profesionalisme dalam satu encounter klinik.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang komunikasi, tetapi juga dari kemampuannya menenangkan anak, merespon kecemasan orang tua, serta menjelaskan tindakan secara empatik dan aman.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan relevan dengan capaian pembelajaran komunikasi klinik.	Seorang anak usia 5 tahun akan dilakukan pemasangan infus, menangis keras dan menolak, sementara ibu tampak cemas dan berkata bahwa anaknya takut disuntik.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan encounter klinik secara utuh mulai dari awal interaksi, pengenalan emosi, komunikasi terapeutik, hingga negosiasi tindakan dan edukasi.	Mahasiswa memperkenalkan diri, mengidentifikasi emosi anak dan ibu, menggunakan komunikasi empatik, melakukan distraksi pada anak, menjelaskan prosedur dengan bahasa sederhana, serta melakukan negosiasi agar tindakan dapat dilakukan dengan aman.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi komunikasi terapeutik, identifikasi emosi,	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu mengenali kecemasan ibu, menenangkan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Komunikasi Situasi Sulit
	kemampuan de-eskalasi, negosiasi tindakan, edukasi keluarga, profesionalisme, dan keselamatan pasien.	anak, menggunakan bahasa yang sesuai usia, tidak memaksa tindakan, serta menjaga keselamatan pasien selama proses komunikasi.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas performa mahasiswa secara langsung menggunakan format DOPS yang terstruktur dan berfokus pada perilaku nyata.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu menurunkan ketegangan situasi, menjaga komunikasi tetap empatik, serta memastikan tindakan dilakukan secara aman dan diterima oleh pasien/keluarga.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, bersifat spesifik, konstruktif, dan berorientasi pada perbaikan performa.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam membangun komunikasi empatik, tetapi perlu meningkatkan teknik distraksi pada anak dan memperjelas penjelasan prosedur kepada orang tua.
Keputusan penilaian	Hasil DOPS digunakan untuk menentukan tingkat kompetensi mahasiswa dalam praktik komunikasi klinik.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan komunikasi secara empatik, menurunkan resistensi pasien, serta menjaga keselamatan. Mahasiswa perlu supervisi jika masih kurang dalam de-eskalasi. Mahasiswa remedial jika komunikasi memicu konflik atau berisiko terhadap pasien.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik capaian pembelajaran pada level <i>does</i> , yaitu kemampuan	Pada kasus komunikasi situasi sulit, mahasiswa dinilai tidak hanya memahami teori komunikasi, tetapi mampu menerapkannya

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Komunikasi Situasi Sulit
	mahasiswa dalam praktik nyata.	secara langsung dalam menghadapi pasien dan keluarga secara aman, efektif, dan profesional.

Tabel. Case Report pada Komunikasi dalam Situasi Sulit

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Komunikasi Situasi Sulit
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang anak usia 5 tahun yang menolak pemasangan infus, menangis keras, dan tampak gelisah, sementara ibu terlihat cemas dan khawatir terhadap prosedur yang akan dilakukan.
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengkajian, analisis masalah komunikasi, perencanaan strategi komunikasi, implementasi, dan evaluasi hasil interaksi klinik.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan kondisi anak dan keluarga, tetapi juga menjelaskan penyebab kecemasan dan penolakan, strategi komunikasi yang digunakan, serta perubahan respons anak dan ibu setelah dilakukan pendekatan terapeutik.
Isi laporan	Isi case report mencakup identitas pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif (emosi dan perilaku), analisis masalah komunikasi, diagnosis keperawatan, rencana intervensi komunikasi, implementasi,	Mahasiswa menuliskan perilaku anak yang menangis dan menolak tindakan, kecemasan ibu, diagnosis seperti ansietas dan ketidakpatuhan, intervensi berupa komunikasi empatik, distraksi, dan edukasi, serta

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Komunikasi Situasi Sulit
	evaluasi, dan refleksi pembelajaran.	evaluasi berupa penurunan kecemasan dan meningkatnya kooperatif pasien.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan identifikasi emosi, relevansi analisis masalah komunikasi, logika penalaran klinik, ketepatan strategi komunikasi, serta kemampuan mengevaluasi hasil interaksi.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan kecemasan ibu dengan penolakan anak, memilih teknik komunikasi yang tepat (empati, distraksi, negosiasi), dan menilai perubahan perilaku pasien setelah intervensi.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan clinical reasoning dalam komunikasi, keterampilan dokumentasi, serta refleksi praktik klinik secara sistematis.	Dari kasus ini, mahasiswa belajar bahwa komunikasi empatik dan keterlibatan keluarga sangat penting dalam menurunkan resistensi pasien anak terhadap tindakan medis.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori komunikasi ke dalam praktik nyata secara sistematis, reflektif, dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep komunikasi dalam situasi sulit, tetapi juga mampu mengelola emosi pasien dan keluarga secara efektif dalam praktik klinik nyata.

Tabel Refleksi Patient Safety pada Komunikasi dalam Situasi Sulit (Marah, Cemas, Menolak Tindakan, dan Agitasi)

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Komunikasi Situasi Sulit
Hakikat refleksi	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan	Pada kasus anak yang menolak tindakan dan ibu yang cemas, mahasiswa merefleksikan bahwa

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Komunikasi Situasi Sulit
patient safety	kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah komunikasi, dan merencanakan tindakan pencegahan.	komunikasi yang tidak tepat dapat meningkatkan ketakutan anak, memperburuk resistensi, dan berisiko menyebabkan tindakan tidak aman.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa komunikasi merupakan bagian penting dari keselamatan pasien dalam praktik keperawatan.	Mahasiswa memahami bahwa sikap terburu-buru, komunikasi yang tidak empatik, atau memaksa tindakan dapat meningkatkan risiko trauma pada anak dan konflik dengan keluarga.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko komunikasi, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama dalam kasus ini adalah penolakan tindakan, meningkatnya kecemasan ibu, serta kemungkinan cedera jika anak meronta saat tindakan dilakukan.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi komunikasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang diidentifikasi antara lain kegagalan tindakan medis, cedera akibat agitasi anak, trauma psikologis, meningkatnya kecemasan keluarga, serta miskomunikasi antara perawat dan keluarga.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret untuk mengurangi risiko keselamatan pasien melalui komunikasi yang tepat.	Mahasiswa menuliskan pentingnya komunikasi empatik, penggunaan distraksi pada anak, penjelasan prosedur dengan bahasa sederhana, melibatkan orang tua,

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Komunikasi Situasi Sulit
		serta menunda tindakan sementara hingga kondisi anak lebih tenang.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal tersebut memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa komunikasi yang tenang, empatik, dan melibatkan keluarga dapat menurunkan resistensi pasien serta meningkatkan keberhasilan tindakan dan keselamatan pasien.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan komunikasi, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko, memperbaiki pendekatan, dan meningkatkan kualitas praktik keperawatan secara berkelanjutan.

N. Tabel Red Flags & Eskalasi

Komunikasi dalam Situasi Sulit

(Marah, Cemas, Menolak Tindakan, dan Agitasi)

Red Flags (Tanda Bahaya Komunikasi/Perilaku)	Makna Klinis	Tindakan Eskalasi Perawat
Pasien/keluarga berbicara dengan nada tinggi, membentak	Emosi tidak terkendali (marah/frustrasi)	Tetap tenang, validasi emosi, hindari konfrontasi, panggil bantuan bila meningkat
Pasien/keluarga menolak tindakan secara tegas	Ketakutan, kurang pemahaman, mistrust	Lakukan edukasi ulang, gunakan bahasa sederhana, libatkan keluarga inti
Pasien menangis histeris / tidak terkendali	Distres emosional tinggi (anak)	Hentikan tindakan sementara, lakukan distraksi, libatkan orang tua
Pasien gelisah, tidak bisa diam (agitasi)	Risiko cedera / kondisi neurologis / nyeri	Pastikan keselamatan lingkungan, kurangi stimulus, laporkan ke tim medis
Pasien mencoba melepas alat medis (infus, O2)	Penolakan / agitasi berat	Amankan alat, supervisi ketat, eskalasi ke dokter/perawat senior
Orang tua tampak panik berlebihan	Kecemasan tinggi, kurang informasi	Berikan informasi bertahap, reassurance, libatkan dalam perawatan
Pasien tidak respons terhadap komunikasi	Gangguan kesadaran / overload emosi	Evaluasi kondisi klinis, segera laporkan ke tim medis
Pasien/keluarga menunjukkan perilaku agresif (verbal/fisik)	Risiko kekerasan	Jaga jarak aman, aktifkan sistem keamanan, kolaborasi tim

Red Flags (Tanda Bahaya Komunikasi/Perilaku)	Makna Klinis	Tindakan Eskalasi Perawat
Pasien anak menolak semua interaksi	Trauma / ketakutan ekstrem	Gunakan pendekatan bermain, bertahap, jangan memaksa
Komunikasi tidak efektif berulang (misunderstanding terus terjadi)	Hambatan komunikasi serius (bahasa, budaya, kognitif)	Gunakan media bantu (visual/interpreter), ulangi dengan metode teach-back
Keluarga menyalahkan tenaga kesehatan	Kurangnya kepercayaan	Klarifikasi dengan empatik, hindari defensif, eskalasi ke atasan bila konflik
Pasien tampak sangat lemah/menurun saat situasi konflik	Risiko kondisi klinis memburuk	Prioritaskan penilaian klinis, hentikan konflik, segera eskalasi medis

Form Checklist "Saya sudah bisa..."

Komunikasi dalam Situasi Sulit (Marah, Cemas, Menolak Tindakan, dan Agitasi)

Nama Mahasiswa :

NIM :

Tanggal :

Tempat Praktik :

Identifikasi Situasi & Emosi

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa mengidentifikasi pasien/keluarga yang marah	☐	☐	
2	Saya sudah bisa mengenali tanda kecemasan pasien/keluarga	☐	☐	
3	Saya sudah bisa mengidentifikasi penolakan tindakan	☐	☐	
4	Saya sudah bisa mengenali tanda agitasi pada pasien	☐	☐	

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
5	Saya sudah bisa memahami bahwa emosi adalah bentuk kebutuhan pasien	☐	☐	

Komunikasi Terapeutik

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
6	Saya sudah bisa berkomunikasi dengan empatik	☐	☐	
7	Saya sudah bisa mendengarkan secara aktif (active listening)	☐	☐	
8	Saya sudah bisa melakukan validasi emosi pasien/keluarga	☐	☐	
9	Saya sudah bisa menghindari sikap defensif	☐	☐	
10	Saya sudah bisa menggunakan bahasa sederhana dan jelas	☐	☐	

De-Eskalasi & Negosiasi

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
11	Saya sudah bisa menenangkan pasien/keluarga dengan komunikasi verbal	☐	☐	
12	Saya sudah bisa menggunakan nada suara yang tenang	☐	☐	
13	Saya sudah bisa melakukan negosiasi tindakan dengan pasien/keluarga	☐	☐	
14	Saya sudah bisa menghindari konflik dalam komunikasi	☐	☐	
15	Saya sudah bisa mengelola situasi komunikasi yang tegang	☐	☐	

Komunikasi pada Anak

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
16	Saya sudah bisa berkomunikasi sesuai tahap perkembangan anak	☐	☐	
17	Saya sudah bisa menggunakan distraksi (mainan/cerita)	☐	☐	
18	Saya sudah bisa melibatkan orang tua dalam komunikasi	☐	☐	
19	Saya sudah bisa membuat anak merasa lebih tenang	☐	☐	

Keselamatan Pasien

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
20	Saya sudah bisa menjaga keselamatan pasien saat komunikasi sulit	☐	☐	
21	Saya sudah tidak memaksakan tindakan dalam kondisi tidak aman	☐	☐	
22	Saya sudah bisa mengenali red flags komunikasi	☐	☐	
23	Saya sudah bisa melakukan eskalasi jika diperlukan	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

O. Rangkuman Materi

Komunikasi dalam Situasi Sulit

Komunikasi dalam situasi sulit merupakan kompetensi esensial dalam praktik keperawatan, khususnya pada keperawatan anak yang melibatkan dinamika emosi pasien dan keluarga. Situasi sulit ditandai oleh munculnya respon emosional seperti marah, cemas, penolakan terhadap tindakan, hingga agitasi yang dapat menghambat proses asuhan keperawatan serta meningkatkan risiko terhadap keselamatan pasien. Dalam konteks ini, perawat dituntut tidak hanya mampu menyampaikan informasi, tetapi juga memahami makna di balik emosi pasien, karena pada dasarnya emosi merupakan bentuk komunikasi yang mencerminkan kebutuhan, ketakutan, atau ketidakpastian yang dirasakan oleh pasien maupun keluarga.

Respon marah umumnya merupakan manifestasi dari ketakutan atau ketidakpuasan, sedangkan kecemasan muncul akibat ketidakpastian terhadap kondisi kesehatan. Penolakan tindakan sering kali berkaitan dengan perasaan kehilangan kontrol atau pengalaman traumatis sebelumnya, sementara agitasi menunjukkan kondisi distres yang lebih berat dan berpotensi membahayakan keselamatan pasien. Oleh karena itu, pendekatan komunikasi yang digunakan harus bersifat terapeutik, yaitu mengedepankan empati, validasi emosi, mendengarkan secara aktif, serta menghindari sikap defensif. Perawat perlu mampu mengelola interaksi secara profesional dengan tetap menjaga batasan terapeutik dan fokus pada keselamatan pasien sebagai prioritas utama.

Strategi komunikasi dalam menghadapi situasi sulit meliputi kemampuan melakukan de-eskalasi verbal, yaitu upaya menurunkan ketegangan melalui penggunaan nada suara yang tenang, kalimat yang sederhana, serta pendekatan yang tidak menghakimi. Selain itu, perawat perlu memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami, melakukan negosiasi tindakan secara bijaksana, serta melibatkan keluarga sebagai bagian penting dalam proses pengambilan keputusan, terutama pada pasien anak. Komunikasi pada anak juga memerlukan pendekatan khusus yang disesuaikan dengan tahap perkembangan, seperti penggunaan distraksi, permainan terapeutik, dan keterlibatan orang tua untuk menciptakan rasa aman.

Dalam kerangka keselamatan pasien, komunikasi memiliki peran yang sangat krusial karena komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan kesalahan tindakan, penolakan terapi, hingga terjadinya cedera pada pasien. Oleh sebab itu, kemampuan komunikasi dalam situasi sulit harus dilatih secara sistematis melalui pendekatan Outcome-Based Education (OBE), yang menekankan pada pencapaian kompetensi nyata mahasiswa. Asesmen dilakukan secara bertahap melalui

piramida Miller, mulai dari penguasaan konsep (knows), kemampuan analisis (knows how), demonstrasi keterampilan melalui simulasi atau OSCE (shows how), hingga praktik langsung di lahan klinik (does).

Secara keseluruhan, bab ini menegaskan bahwa keberhasilan komunikasi dalam situasi sulit tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh sikap empatik, kesadaran akan keselamatan pasien, serta kemampuan membangun hubungan terapeutik yang efektif. Perawat yang mampu berkomunikasi dengan baik dalam kondisi penuh tekanan akan lebih mampu menurunkan resistensi pasien, meningkatkan kepercayaan keluarga, serta memastikan asuhan keperawatan berjalan secara aman, efektif, dan bermutu tinggi.

P. Daftar Pustaka

- Potter, P. A., & Perry, A. G. (2021). *Fundamentals of Nursing*.
Stuart, G. W. (2020). *Psychiatric Nursing*.
Stuart, G. W. (2020). *Principles and Practice of Psychiatric Nursing*.
WHO. (2021). *Patient Safety Curriculum*.
PPNI. (2017–2021). *SDKI, SIKI, SLKI*.
Back, A. L., Arnold, R. M., & Tulskey, J. A. (2020). *Mastering communication with seriously ill patients*. Cambridge University Press.
Silverman, J., Kurtz, S., & Draper, J. (2022). *Skills for communicating with patients*. CRC Press.
Price, O., Baker, J., Bee, P., & Lovell, K. (2018). Learning and performance outcomes of mental health staff training in de-escalation techniques. *International Journal of Nursing Studies*, 78, 94–101.
Richmond, J. S., et al. (2012). Verbal de-escalation of the agitated patient. *Western Journal of Emergency Medicine*, 13(1), 17–25.
Stubbs, B., et al. (2018). De-escalation techniques in healthcare settings. *Journal of Clinical Nursing*, 27(5–6), e128–e140.

BAB 2

KOMUNIKASI PADA POPULASI KHUSUS: ANAK, LANSIA, GANGGUAN JIWA, DAN DISABILITAS

Capaian Pembelajaran (OBE)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu menjelaskan peran, tujuan dan dampaknya terhadap keselamatan pasien diberbagai tatanan pelayanan kesehatan.

CPL-CPMK-SUB CPMK

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-5	Mampu berkomunikasi efektif pada situasi sulit/krisis serta populasi khusus dengan mempertimbangkan budaya, spiritual, dan keselamatan.	CPMK-5; CPMK-6

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-5	Menerapkan komunikasi nonverbal, validasi pesan, dan strategi komunikasi pada situasi sulit serta populasi khusus secara aman.

Peta Konsep

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 10. Komunikasi pada Populasi Khusus: Anak, Lansia, Gangguan Jiwa, dan Disabilitas	10.1 Menyesuaikan strategi komunikasi berdasarkan perkembangan, kognisi, dan kebutuhan aksesibilitas.	10.2 Menerapkan komunikasi aman pada kondisi perilaku/psikologis khusus dengan fokus keselamatan.	CPMK-5	CPMK-3; CPMK-6

Tabel Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-3	OSCE komunikasi terapeutik + checklist	Persentase ketercapaian teknik fase hubungan, batas profesional, dan respons empatik (tanpa kesalahan kritis).	15	Checklist OSCE; rekaman
CPMK-5	Simulasi situasi sulit/populasi khusus + rubrik	Ketepatan de-eskalasi/validasi pesan dan keselamatan komunikasi (skor rubrik).	15	Video/rekaman; lembar rubrik
CPMK-6	Simulasi komunikasi interprofesional & eskalasi + checklist	Kejelasan pesan klinis, kolaborasi, dan ketepatan eskalasi fokus risiko (checklist).	15	Checklist; catatan simulasi

Tabel Rubrik CMPK (Skala 1-4)**Rubrik CPMK-3**

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Kinerja komunikasi terapeutik (checklist)	≤60% perilaku tercapai; hubungan tidak terbina	61–75% tercapai; hubungan terbina sebagian	76–90% tercapai; hubungan efektif	>90% tercapai; empatik, adaptif, profesional
3.2 Batas profesional & kontrak terapeutik	Tidak menjaga batas; risiko tinggi	Batas sebagian; kurang konsisten	Batas jelas; konsisten	Batas sangat jelas; konsisten dan aman

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Ketepatan de-eskalasi/validasi pesan	Tidak menurunkan eskalasi; memicu konflik	Menurunkan sebagian; teknik terbatas	Menurunkan eskalasi; teknik tepat	Sangat efektif; teknik komprehensif & aman
5.2 Keselamatan komunikasi pada populasi khusus/situasi sulit	Tidak adaptif; risiko tinggi	Adaptif sebagian; risiko masih ada	Adaptif; risiko minimal	Sangat adaptif; risiko terantisipasi dan mitigasi jelas

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Kejelasan pesan klinis & kolaborasi tim	Pesan tidak jelas; kolaborasi tidak terjadi	Pesan cukup; kolaborasi terbatas	Pesan jelas; kolaborasi efektif	Pesan sangat jelas; kolaborasi sangat efektif & proaktif
6.2 Ketepatan eskalasi fokus risiko	Tidak eskalasi/eskalasi keliru	Eskalasi ada; kurang runtut	Eskalasi runtut; fokus risiko jelas	Eskalasi sangat runtut; fokus risiko tajam + konfirmasi penerimaan

A. Pendahuluan

Komunikasi dalam pelayanan kesehatan tidak hanya bertujuan untuk pertukaran informasi, tetapi juga untuk membangun rasa aman, kepercayaan, dan kenyamanan pasien. Pasien harus merasa dihargai, tidak diintimidasi, dan memiliki ruang untuk menyampaikan pengalaman pribadi, termasuk pengalaman traumatis. Hal ini menjadi dasar dalam membangun hubungan terapeutik yang efektif dan berkelanjutan.

Dalam praktik nyata, sebagian besar tindakan keperawatan tidak dapat dipisahkan dari proses komunikasi, baik dalam bentuk pengkajian, edukasi, maupun kolaborasi interprofesional. Namun demikian, efektivitas komunikasi tidak bersifat universal, melainkan sangat bergantung pada karakteristik individu baik pada aspek perkembangan, fungsi kognitif, kondisi psikologis, dan kemampuan sensorik, terutama pada populasi khusus.

Populasi khusus, yang meliputi anak, lansia, individu dengan gangguan jiwa, dan penyandang disabilitas, memiliki karakteristik unik yang memengaruhi cara mereka menerima, memproses, dan merespons informasi. Anak, misalnya, masih berada dalam tahap perkembangan kognitif yang konkret sehingga memiliki keterbatasan dalam memahami konsep abstrak. Lansia sering mengalami penurunan fungsi sensorik dan kognitif yang dapat menghambat pemahaman pesan. Sementara itu, pasien dengan gangguan jiwa dapat mengalami distorsi persepsi realitas, dan individu dengan disabilitas mungkin menghadapi hambatan akses komunikasi baik secara fisik maupun kognitif.

Kondisi tersebut menjadikan komunikasi pada populasi khusus sebagai proses yang kompleks dan berisiko tinggi. Miskomunikasi pada kelompok ini tidak hanya menyebabkan kesalahpahaman, tetapi juga dapat berdampak serius terhadap keselamatan pasien, seperti kesalahan pemberian terapi, ketidakpatuhan terhadap pengobatan, hingga peningkatan kecemasan atau perilaku agresif. Kesalahan komunikasi merupakan salah satu penyebab utama *adverse events* dalam pelayanan kesehatan. Laporan dari *The Joint Commission* (AMA, 2022) menunjukkan bahwa lebih dari 60% *sentinel events* berkaitan dengan kegagalan komunikasi. Hal ini menjadi lebih signifikan pada populasi khusus, di mana keterbatasan pasien meningkatkan risiko miskomunikasi.

Penelitian oleh Street et al. (Street, Makoul, Arora, & Epstein, 2009) menunjukkan bahwa komunikasi yang berpusat pada pasien (*patient-centered*)

communication) berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan terapi, kepuasan pasien, serta luaran klinis yang lebih baik. Namun, pada populasi khusus, pendekatan komunikasi harus disesuaikan secara spesifik untuk mengakomodasi kebutuhan individu. Oleh karena itu, komunikasi pada populasi khusus harus dilakukan secara adaptif, sistematis, dan berbasis prinsip keselamatan pasien.

Dalam konteks pendidikan keperawatan berbasis *Outcome-Based Education (OBE)*, kemampuan komunikasi tidak cukup hanya dipahami secara teoritis, tetapi harus dapat didemonstrasikan dalam praktik klinik. Mahasiswa dituntut untuk mampu menyesuaikan strategi komunikasi berdasarkan kondisi pasien, mengidentifikasi hambatan komunikasi, melakukan validasi pemahaman, serta mengambil keputusan untuk melakukan eskalasi bila terdapat risiko. Dengan demikian, pembelajaran komunikasi pada populasi khusus tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, tetapi juga pada performa klinis yang terukur.

B. Landasan teoretik

1. Konsep Dasar Komunikasi pada Populasi Khusus

Menurut Arnold dan Boggs (Arnold & Boggs, 2020), komunikasi dalam pelayanan kesehatan merupakan proses dinamis yang melibatkan pertukaran informasi, pembentukan makna, dan pengambilan keputusan klinis baik dengan penggunaan teknik verbal maupun nonverbal untuk membangun hubungan terapeutik yang efektif antara tenaga kesehatan dan pasien. Dalam keperawatan, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai intervensi terapeutik yang berkontribusi terhadap keselamatan pasien dan luaran klinis. Sementara itu, penelitian oleh McCabe dan Timmins (2013) menekankan bahwa komunikasi terapeutik harus bersifat individual, kontekstual, dan adaptif terhadap kebutuhan pasien.

Pada populasi khusus: anak, lansia, individu dengan gangguan jiwa, dan penyandang disabilitas, komunikasi harus disesuaikan dengan karakteristik perkembangan, kognitif, emosional, dan sensorik pasien. Ketidaksesuaian strategi komunikasi dengan karakteristik tersebut dapat menyebabkan miskomunikasi, penurunan kepatuhan terapi, serta peningkatan risiko kejadian tidak diinginkan (Street, 2013).

Secara konseptual, komunikasi terapeutik pada populasi khusus adalah proses interaksi interpersonal yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan pasien melalui adaptasi strategi komunikasi berdasarkan kondisi individu. Pendekatan ini menempatkan komunikasi sebagai proses yang tidak hanya mentransfer informasi, tetapi juga membangun hubungan terapeutik yang mendukung penyembuhan.

Komunikasi terapeutik pada populasi khusus adalah proses interaksi interpersonal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pasien dengan menyesuaikan strategi komunikasi berdasarkan kondisi perkembangan, kognitif, psikologis, dan kemampuan sensorik individu.

Sebagai contoh klinis, seorang anak usia prasekolah yang akan menjalani tindakan invasif sering kali menunjukkan kecemasan karena keterbatasan pemahaman terhadap prosedur. Jika perawat menggunakan bahasa medis yang abstrak, anak akan semakin cemas. Sebaliknya, penggunaan bahasa konkret dan media visual dapat meningkatkan pemahaman dan menurunkan kecemasan (Coyne, Hallström, & Söderbäck, 2016)

2. Prinsip Komunikasi pada Populasi Khusus

Komunikasi pada populasi khusus harus didasarkan pada prinsip yang menjamin efektivitas sekaligus keselamatan pasien. Prinsip pertama adalah *patient-centered communication*, yaitu komunikasi yang berfokus pada kebutuhan, nilai, dan preferensi pasien. Pendekatan ini terbukti meningkatkan kepuasan, kepatuhan, dan luaran kesehatan pasien (Street et al., 2009).

Prinsip kedua adalah *developmentally appropriate communication*, yang menekankan kesesuaian komunikasi dengan tahap perkembangan dan kapasitas kognitif pasien. Pada anak, penggunaan bahasa konkret dan visual sangat penting, sedangkan pada lansia diperlukan pengulangan informasi dan penyesuaian kecepatan komunikasi (Coyne et al., 2016).

Prinsip ketiga adalah *safety-oriented communication*, yaitu komunikasi yang berorientasi pada pencegahan kesalahan klinis. WHO menekankan bahwa komunikasi efektif merupakan komponen utama keselamatan pasien, terutama dalam pemberian instruksi terapi (WHO, 2017).

Prinsip keempat adalah *accessible communication*, yaitu komunikasi yang dapat diakses oleh semua pasien, termasuk individu dengan disabilitas. Penggunaan media alternatif seperti visual, tulisan, atau alat bantu komunikasi menjadi penting dalam konteks ini (Finke et al., 2017).

3. Komunikasi Efektif dalam Keperawatan

Komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu menyampaikan pesan secara jelas, akurat, lengkap, dan bermakna sehingga dapat dipahami oleh pasien serta menghasilkan kesamaan makna antara pengirim dan penerima pesan. Dalam konteks pelayanan kesehatan, komunikasi efektif tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi, tetapi juga berperan dalam mencegah kesalahan, meningkatkan keselamatan pasien, serta menentukan

kualitas pelayanan yang diberikan (Parrales-Choez, Jaqueline-Beatriz, Menéndez-Pin, & Ramos-Arce, 2022).

Komunikasi efektif dalam pelayanan kesehatan ditandai oleh kemampuan menyampaikan informasi secara tepat, jelas, dan dapat dipahami oleh pasien, sehingga tercapai kesamaan makna dan tujuan dalam proses perawatan. Dalam praktik klinis, komunikasi yang efektif harus bersifat akurat, lengkap, jelas, tidak ambigu, dan dapat dipahami oleh penerima, karena karakteristik tersebut terbukti berperan dalam menurunkan kesalahan dan meningkatkan keselamatan pasien (Cenedesi, Moura-Ferreira, Almeida, & Júnior, 2024). Selain itu, komunikasi yang efektif juga harus mempertimbangkan konteks interpersonal dan relasional, termasuk aspek budaya, emosi, serta kebutuhan individu pasien sebagai bagian dari pelayanan yang berpusat pada pasien (Tatiana et al., 2020).

Secara lebih spesifik, karakteristik komunikasi efektif dalam konteks keperawatan dapat diidentifikasi sebagai *factual*, *practical*, *clear and concise*, serta *persuasive*.

a. *Factual*,

Komunikasi yang *factual* menekankan penyampaian informasi berdasarkan bukti ilmiah dan data yang akurat, sehingga meningkatkan kepercayaan pasien terhadap tenaga kesehatan.

b. *Practical*,

Komunikasi yang *practical* berfokus pada relevansi pesan dengan kondisi nyata pasien, sehingga membantu pasien memahami tindakan yang harus dilakukan secara realistis.

c. *Clear and concise*,

komunikasi yang *clear and concise* memastikan pesan disampaikan secara jelas, terstruktur, dan tidak bertele-tele, sehingga memudahkan pemahaman serta memungkinkan terjadinya umpan balik.

d. *Persuasive*,

komunikasi yang *persuasive* berperan dalam mendorong perubahan perilaku pasien secara positif, khususnya dalam meningkatkan kepatuhan terhadap terapi dan tindakan kesehatan (NMC, 2025; OpenStax, 2024)

Karakteristik tersebut sejalan dengan temuan lain yang menekankan bahwa komunikasi efektif harus bersifat jelas, ringkas, dan mudah dipahami, serta didukung oleh proses interaksi dua arah yang memungkinkan klarifikasi dan umpan balik. Selain itu, komunikasi efektif juga tidak hanya bergantung pada isi pesan, tetapi juga pada kemampuan tenaga kesehatan dalam membangun hubungan interpersonal, menunjukkan empati, serta

menggunakan komunikasi verbal dan nonverbal secara terpadu, seperti kontak mata, sentuhan, dan ekspresi wajah (Cenedesi et al., 2024; Lacerda et al., 2021; NMC, 2025; Sibiya, 2018).

Dengan demikian, karakteristik komunikasi efektif dalam keperawatan tidak hanya mencakup aspek teknis penyampaian informasi (kejelasan, keakuratan, dan kelengkapan), tetapi juga aspek relasional dan persuasif yang mendukung keterlibatan pasien. Integrasi antara ketepatan informasi, kejelasan pesan, relevansi praktis, serta kemampuan memengaruhi perilaku menjadikan komunikasi sebagai komponen kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan, keselamatan pasien, dan keberhasilan intervensi kesehatan.

Selain itu, komunikasi efektif juga ditentukan oleh keterampilan interpersonal seperti kemampuan memahami perspektif pasien, melakukan *active listening*, memberikan umpan balik, serta menyesuaikan pesan dengan latar belakang dan kerangka referensi pasien (AACN, 2021; Sibiya, 2018). Dalam praktik klinis, komunikasi yang tidak hanya informatif tetapi juga empatik dan responsif terbukti meningkatkan keterlibatan pasien dalam proses perawatan.

Pendekatan *motivational interviewing (MI)* merupakan strategi komunikasi berbasis *patient-centered* yang terbukti efektif dalam mendorong perubahan perilaku, khususnya pada penyakit kronis. Pendekatan ini menekankan eksplorasi motivasi internal pasien, penggunaan pertanyaan terbuka, refleksi, dan dukungan terhadap otonomi pasien, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan terapi dan hasil kesehatan secara keseluruhan. Secara teoretis, MI bekerja melalui dua komponen utama, yaitu komponen relasional (empati, kolaborasi, dan penghargaan terhadap otonomi pasien) serta komponen teknis (menggali dan memperkuat *change talk* pasien) yang secara langsung memengaruhi komitmen dan perubahan perilaku (W. R. Miller & Rose, 2009). Bukti empiris menunjukkan bahwa munculnya *change talk* dan peningkatan komitmen pasien selama proses komunikasi berkorelasi dengan perubahan perilaku kesehatan yang lebih baik, sehingga MI menjadi pendekatan yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan terapi dan hasil klinis.

4. Emotional Intelligence dalam Komunikasi Keperawatan pada Populasi Khusus

Emotional Intelligence (EI) merupakan kemampuan individu untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri serta orang lain dalam konteks interaksi sosial. EI mencakup kemampuan intrapersonal dan interpersonal yang memungkinkan individu menggunakan emosi secara adaptif dalam pengambilan keputusan dan hubungan sosial (Panguluri &

Mohan, 2018). Dalam praktik keperawatan, EI menjadi kompetensi inti karena perawat bekerja dalam lingkungan yang sarat tekanan emosional, interaksi kompleks, dan tuntutan hubungan terapeutik yang berkelanjutan (McQueen, 2004).

Komunikasi dalam keperawatan tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga emosional dan relasional. Perawat tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga merespons kondisi emosional pasien, seperti kecemasan, ketakutan, atau distress. Oleh karena itu, keberhasilan komunikasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan perawat dalam mengelola emosi dan membangun hubungan interpersonal yang terapeutik. Bukti empiris menunjukkan bahwa EI memiliki hubungan signifikan dengan keterampilan komunikasi perawat dan kualitas interaksi dengan pasien (Ghrayeb et al., 2025; Raeissi et al., 2019).

Secara konseptual, EI terdiri dari empat komponen utama, yaitu *self-awareness*, *self-management*, *social awareness*, dan *relationship management*. Keempat komponen ini membentuk kerangka kemampuan emosional yang saling terintegrasi dalam mendukung komunikasi efektif. Model ini juga digunakan secara luas dalam penelitian keperawatan untuk menjelaskan bagaimana kemampuan emosional memengaruhi praktik klinis dan interaksi profesional (Ghrayeb et al., 2025; Raeissi et al., 2019).

Self-awareness merupakan kemampuan perawat untuk mengenali emosi, pikiran, dan respons diri sendiri dalam situasi klinis. Kemampuan ini penting untuk mengidentifikasi bias, reaksi emosional, dan potensi konflik dalam interaksi. Perawat dengan *self-awareness* yang baik cenderung lebih mampu mengontrol respons impulsif dan memberikan respons yang lebih reflektif dalam situasi klinis yang menantang (Gamage & Sudusinghe, 2024).

Self-management berkaitan dengan kemampuan mengendalikan emosi dan menjaga stabilitas perilaku dalam situasi stres. Dalam praktik keperawatan yang penuh tekanan, kemampuan ini memungkinkan perawat tetap tenang, profesional, dan tidak reaktif terhadap perilaku pasien. Regulasi emosi yang baik juga berkontribusi terhadap pengambilan keputusan yang lebih tepat dan mengurangi kesalahan klinis (McQueen, 2004).

Social awareness mencakup empati, yaitu kemampuan memahami kondisi emosional dan perspektif pasien. Empati merupakan komponen kunci dalam komunikasi terapeutik karena memungkinkan perawat melakukan validasi perasaan pasien dan membangun hubungan yang suportif. Pendekatan empatik terbukti meningkatkan kepuasan pasien, menurunkan kecemasan, serta memperbaiki *outcome* klinis (McQueen, 2004).

Relationship management merupakan kemampuan membangun, mempertahankan, dan mengelola hubungan interpersonal secara efektif. Dalam konteks keperawatan, kemampuan ini berperan dalam membangun kepercayaan, meningkatkan kolaborasi, serta menciptakan komunikasi yang terbuka dan aman antara perawat dan pasien. EI memungkinkan perawat menciptakan hubungan yang tidak hanya informatif, tetapi juga terapeutik dan berpusat pada pasien (Gamage & Sudusinghe, 2024).

Dalam praktik klinis, EI memiliki peran penting dalam berbagai situasi komunikasi pada populasi khusus. Pada anak, EI membantu perawat memahami ekspresi emosional yang terbatas dan menyesuaikan pendekatan komunikasi secara sensitif. Pada lansia, EI mendukung sikap sabar, empatik, dan menghargai keterbatasan fisik maupun kognitif. Pada pasien dengan gangguan jiwa, EI menjadi kunci dalam mengelola emosi, melakukan de-eskalasi, serta menjaga stabilitas hubungan terapeutik. Sementara itu, pada pasien dengan disabilitas, EI memungkinkan komunikasi yang lebih inklusif, adaptif, dan menghargai martabat individu. Kemampuan ini sangat penting karena komunikasi dalam keperawatan sering terjadi dalam kondisi emosional yang kompleks dan penuh tekanan (Ghrayeb et al., 2025).

Selain itu, EI juga berperan dalam menjaga keselamatan komunikasi (*communication safety*). Perawat dengan tingkat EI yang tinggi cenderung memiliki kemampuan lebih baik dalam menghindari konflik, mengelola stres, serta menjaga kejelasan dan empati dalam komunikasi. Hal ini berkontribusi terhadap penurunan miskomunikasi dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Studi menunjukkan bahwa EI berhubungan langsung dengan peningkatan kualitas komunikasi, kepuasan pasien, dan *outcome* pelayanan (Ghrayeb et al., 2025; Mariati, Jakri, & Djerubu, 2022).

Dengan demikian, pengembangan *emotional intelligence* bukan sekadar kompetensi tambahan, tetapi merupakan fondasi dalam praktik komunikasi keperawatan. EI memungkinkan integrasi aspek kognitif dan emosional dalam komunikasi, sehingga menghasilkan interaksi yang lebih efektif, aman, dan terapeutik. Dalam konteks pelayanan kesehatan modern yang kompleks, EI menjadi elemen kunci dalam mewujudkan pelayanan yang berpusat pada pasien (*patient-centered care*) dan berkualitas tinggi (Gamage & Sudusinghe, 2024).

5. Komunikasi Terapeutik pada populasi khusus

Komunikasi terapeutik merupakan komunikasi profesional yang bertujuan membangun hubungan terapeutik dan mendukung penyembuhan

pasien. Teknik seperti *active listening*, empati, refleksi, dan klarifikasi memungkinkan pasien mengekspresikan perasaan, meningkatkan kepercayaan, serta membantu pasien memahami kondisi dan masalah kesehatannya secara lebih mendalam melalui proses pertukaran informasi yang bermakna antara perawat dan pasien. Melalui pendekatan ini, perawat tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga menggali dimensi emosional pasien, sehingga tercipta hubungan yang didasarkan pada rasa saling menghargai, keterlibatan aktif, dan keamanan psikologis yang mendukung proses pemulihan (Arnold & Boggs, 2020).

Sebaliknya, komunikasi nonterapeutik seperti menghakimi, mengabaikan perasaan pasien, atau memberikan nasihat tanpa eksplorasi dapat merusak hubungan terapeutik karena menghambat keterbukaan dan menurunkan kepercayaan pasien. Pola komunikasi yang tidak berfokus pada kebutuhan dan pengalaman pasien juga berpotensi menyebabkan hubungan yang bersifat superfisial, sehingga mengurangi efektivitas interaksi dan berdampak pada rendahnya kepuasan serta kualitas hasil perawatan.

a. Definisi Komunikasi Terapeutik pada Populasi Khusus

Komunikasi terapeutik pada populasi khusus adalah proses interaksi interpersonal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pasien dengan menyesuaikan strategi komunikasi berdasarkan kondisi perkembangan, kognitif, psikologis, dan kemampuan sensorik individu.

Menurut Arnold dan Boggs (Arnold & Boggs, 2020), komunikasi terapeutik merupakan proses dinamis yang melibatkan penggunaan teknik verbal dan nonverbal untuk membangun hubungan terapeutik yang efektif. Sementara itu, penelitian oleh McCabe dan Timmins (2013) menekankan bahwa komunikasi terapeutik harus bersifat individual, kontekstual, dan adaptif terhadap kebutuhan pasien. Komunikasi terapeutik merupakan bentuk komunikasi profesional yang bertujuan untuk membangun hubungan terapeutik antara perawat dan pasien guna mendukung proses penyembuhan. Konsep ini berkembang dari teori hubungan interpersonal Hildegard Peplau yang menekankan pentingnya interaksi dalam proses keperawatan (Alligood, 2018; Perry & Potter, 2012).

b. Prinsip Komunikasi pada Populasi Khusus

1) *Patient-Centered Communication*

Komunikasi berpusat pada pasien menekankan pemahaman terhadap kebutuhan, nilai, preferensi, serta pengalaman subjektif pasien dalam proses perawatan. Pendekatan ini menempatkan pasien sebagai mitra aktif dalam pengambilan keputusan dan membangun

hubungan kolaboratif antara tenaga kesehatan dan pasien. Komunikasi yang berfokus pada pasien terbukti meningkatkan pemahaman, keterlibatan, kepatuhan terhadap terapi, serta outcome klinis secara keseluruhan (Street, 2013; Street et al., 2009). Selain itu, pendekatan ini juga diperkuat oleh konsep *relationship-centered care* yang menekankan bahwa kualitas hubungan interpersonal menjadi medium utama dalam pelayanan kesehatan dan berpengaruh langsung terhadap kualitas perawatan (Rider, 2011).

2) *Developmentally Appropriate Communication*

Komunikasi harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif, emosional, dan sosial individu, terutama pada populasi anak. Penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangan dapat meningkatkan kecemasan, kebingungan, serta resistensi terhadap tindakan medis (Coyne et al., 2016). Oleh karena itu, informasi perlu disampaikan dengan cara yang sederhana, konkret, dan sesuai dengan tingkat pemahaman anak, serta melibatkan keluarga sebagai bagian dari proses komunikasi. Selain itu, komunikasi yang mempertimbangkan *health literacy* dan tahap perkembangan terbukti meningkatkan keterlibatan anak dalam perawatan serta kepatuhan terhadap terapi (Bell & Condren, 2018).

3) *Safety-Oriented Communication*

Komunikasi dalam pelayanan kesehatan harus berorientasi pada keselamatan pasien dengan memastikan informasi disampaikan secara jelas, akurat, dan tidak ambigu. Komunikasi yang tidak efektif merupakan salah satu penyebab utama kesalahan medis, sehingga organisasi seperti WHO menekankan pentingnya komunikasi sebagai komponen kunci dalam *patient safety* (WHO, 2017). Selain itu, kualitas komunikasi yang baik berhubungan langsung dengan peningkatan *outcome* klinis, penurunan kesalahan, serta peningkatan kepuasan pasien. Bukti juga menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk sering menjadi faktor utama dalam terjadinya kesalahan dan keluhan pasien terhadap pelayanan kesehatan (Rider, 2011).

4) *Accessible Communication*

Komunikasi harus dapat diakses oleh seluruh pasien, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus seperti disabilitas, gangguan komunikasi, atau keterbatasan bahasa (Finke et al., 2017). Hambatan komunikasi pada populasi ini dapat menyebabkan kesalahpahaman, keterlambatan diagnosis, serta peningkatan risiko outcome yang

buruk. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu menyesuaikan strategi komunikasi dengan kemampuan pasien, termasuk penggunaan bahasa sederhana, alat bantu komunikasi, serta melibatkan keluarga atau caregiver bila diperlukan. Variasi kemampuan komunikasi pada pasien dengan kebutuhan khusus menuntut pendekatan yang fleksibel dan individual untuk memastikan pesan dapat diterima dan dipahami dengan baik (Espinoza & Heaton, 2016). Selain itu, faktor budaya dan bahasa juga memengaruhi interpretasi pesan, sehingga diperlukan kompetensi komunikasi lintas budaya untuk mencegah miskomunikasi dan meningkatkan kualitas pelayanan (O'Toole, Alvarado-Little, & Ledford, 2019).

c. Teknik Komunikasi Terapeutik

Teknik komunikasi terapeutik merupakan keterampilan inti yang digunakan tenaga kesehatan untuk membangun hubungan terapeutik, memahami pengalaman pasien, serta memfasilitasi proses penyembuhan secara holistik. Teknik utama yang meliputi *active listening*, klarifikasi, refleksi, empati, *silence*, dan *offering self* (Arnold & Boggs, 2020; Perry & Potter, 2012) tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi sebagai intervensi terapeutik yang secara langsung memengaruhi kualitas hubungan dan hasil klinis pasien (Allan, Henderson, & Hay-Higgins, 2024; Do Nascimento et al., 2020).

1) **Active listening (mendengarkan aktif)**

Merupakan fondasi utama komunikasi terapeutik. Teknik ini memungkinkan tenaga kesehatan memahami secara mendalam pengalaman subjektif pasien, termasuk aspek emosional dan psikologis yang sering tidak diungkapkan secara eksplisit. *Therapeutic listening* terbukti membantu mengidentifikasi penderitaan psikologis pasien secara lebih akurat serta memperkuat hubungan profesional-pasien-keluarga, sehingga meningkatkan kualitas asuhan dan refleksi diri pasien (Do Nascimento et al., 2020).

2) **Klarifikasi dan refleksi.**

Klarifikasi dan refleksi berperan dalam memastikan kesamaan makna antara tenaga kesehatan dan pasien. Klarifikasi membantu menghindari kesalahan interpretasi, sedangkan refleksi memungkinkan pasien menyadari kembali perasaan dan pikirannya. Dalam model komunikasi klinis modern, proses ini merupakan bagian dari *interactive communication* yang menekankan umpan balik dan

pembangunan makna secara bersama (Silverman, Kurtz, & Draper, 2016).

3) **Empati.**

Empati menjadi komponen kunci dalam membangun hubungan terapeutik yang efektif. Empati memungkinkan tenaga kesehatan memahami perspektif pasien secara emosional dan kognitif, sehingga menciptakan hubungan yang didasarkan pada kepercayaan, rasa aman, dan keterlibatan aktif pasien. Hubungan terapeutik yang dibangun melalui empati, kejujuran, dan keterbukaan terbukti menjadi *backbone* dalam praktik keperawatan, karena mendukung otonomi pasien dan pengambilan keputusan bersama (Allan et al., 2024).

4) ***Silence (diam terapeutik).***

Merupakan teknik yang sering diabaikan tetapi memiliki makna penting. Keheningan memberikan ruang bagi pasien untuk berpikir, merasakan, dan mengekspresikan diri tanpa tekanan, serta menunjukkan kehadiran penuh tenaga kesehatan. Teknik ini mendukung proses refleksi internal pasien dan memperdalam eksplorasi pengalaman emosional (Arnold & Boggs, 2020; Perry & Potter, 2012).

5) ***Offering self***

Mencerminkan kehadiran terapeutik (*therapeutic presence*), di mana tenaga kesehatan secara sadar menyediakan diri secara emosional dan profesional untuk pasien. Kehadiran ini memperkuat hubungan interpersonal dan menciptakan rasa diterima serta dihargai, yang menjadi dasar terbentuknya hubungan terapeutik yang efektif (Rider, 2011).

Lebih lanjut, efektivitas teknik-teknik komunikasi terapeutik juga didukung oleh bukti empiris yang menunjukkan bahwa komunikasi yang positif, empatik, dan suportif dapat menurunkan kecemasan serta persepsi nyeri pasien, sedangkan komunikasi negatif justru dapat meningkatkan ketidaknyamanan (*nocebo effect*) (Schmutz, Le Terrier, Ribordy, Iglesias, & Guechi, 2023). Hal ini menegaskan bahwa teknik komunikasi bukan hanya alat interaksi, tetapi merupakan bagian dari intervensi klinis yang berdampak langsung pada kondisi pasien.

Dengan demikian, teknik komunikasi terapeutik tidak dapat dipahami secara terpisah sebagai keterampilan individual, tetapi harus dilihat sebagai sistem keterampilan yang saling terintegrasi, mencakup

aspek kognitif, emosional, dan relasional. Integrasi antara mendengarkan aktif, empati, refleksi, klarifikasi, keheningan, dan kehadiran terapeutik menjadi kunci dalam membangun hubungan yang efektif, meningkatkan keterlibatan pasien, serta mendukung keberhasilan asuhan keperawatan secara menyeluruh.

d. Evaluasi Komunikasi Terapeutik

Evaluasi komunikasi terapeutik merupakan proses sistematis untuk menilai sejauh mana komunikasi yang dilakukan perawat mampu mencapai tujuan terapeutik, membangun hubungan yang efektif, serta mendukung *outcome* pasien. Evaluasi ini tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga pada kualitas hubungan interpersonal, keterlibatan pasien, serta dampaknya terhadap perilaku dan kondisi pasien (Pontes, Leitão, & Ramos, 2008).

Efektivitas komunikasi terapeutik dapat dinilai melalui beberapa indikator utama, yaitu:

1) *Feedback pasien*

Feedback ini mencerminkan persepsi pasien terhadap kualitas komunikasi, termasuk rasa dipahami, dihargai, dan didukung. Kepuasan pasien sering digunakan sebagai indikator evaluasi karena komunikasi terapeutik yang baik terbukti memiliki hubungan signifikan dengan tingkat kepuasan terhadap pelayanan keperawatan (L Gaol & Mestiana Br. Karo, 2025).

2) Kemampuan pasien mengulang atau menjelaskan kembali informasi,

Aspek ini menunjukkan tingkat pemahaman pasien terhadap informasi yang diberikan. Pemahaman yang baik berkontribusi pada keterlibatan pasien dalam perawatan serta meningkatkan kepatuhan terhadap terapi (Pontes et al., 2008).

3) Pencapaian tujuan komunikasi

Tercapainya tujuan komunikasi akan memberikan manfaat seperti peningkatan kerja sama pasien, penurunan kecemasan, atau perubahan perilaku kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi terapeutik yang efektif memiliki hubungan signifikan dengan peningkatan kerja sama pasien selama proses perawatan (Astuti, Novianti, Santos, Pinto, & Azhar, 2025).

Selain itu, evaluasi komunikasi juga dapat dilihat dari kualitas hubungan terapeutik yang terbentuk, termasuk adanya kepercayaan, keterbukaan, dan partisipasi aktif pasien dalam proses perawatan. Hubungan terapeutik yang baik menjadi indikator bahwa komunikasi telah berjalan secara efektif dan bermakna (Mountford, 1997).

Apabila komunikasi dinilai belum efektif, perawat perlu melakukan penyesuaian strategi komunikasi melalui penyederhanaan pesan, penggunaan berbagai bentuk komunikasi (verbal dan nonverbal), serta pengulangan dan klarifikasi informasi untuk memastikan pemahaman pasien (Arda, Menga, & Yuriatson, 2023; Pontes et al., 2008). Tindakan yang dapat dilakukan meliputi:

4) Merevisi pesan

Dengan menyederhanakan bahasa, menyesuaikan dengan tingkat pemahaman pasien, serta memperjelas informasi yang ambigu (Pontes et al., 2008).

5) Menggunakan metode alternatif

Dapat dilakukan dengan pendekatan nonverbal, penggunaan media bantu, atau melibatkan keluarga/*caregiver* untuk meningkatkan pemahaman pasien (Arda et al., 2023).

6) Mengulangi proses komunikasi,

Dapat disertai dengan klarifikasi dan umpan balik untuk memastikan kesamaan makna antara perawat dan pasien (Allan et al., 2024).

Evaluasi yang berkelanjutan penting karena komunikasi terapeutik bersifat dinamis dan kontekstual, dipengaruhi oleh kondisi pasien, lingkungan, serta interaksi interpersonal yang terus berkembang. Kegagalan dalam komunikasi tidak hanya berdampak pada hubungan terapeutik, tetapi juga dapat menurunkan kualitas pelayanan, meningkatkan risiko kesalahan, serta menghambat proses penyembuhan pasien (Astuti et al., 2025). Oleh karena itu, evaluasi komunikasi harus menjadi bagian integral dari praktik keperawatan untuk menjamin keselamatan pasien dan keberhasilan asuhan secara menyeluruh.

6. Hambatan dan Mekanisme Gangguan Komunikasi

a. Hambatan komunikasi

Hambatan komunikasi dalam pelayanan kesehatan merupakan fenomena kompleks yang melibatkan interaksi faktor individu, profesional, dan sistem. Bukti terbaru menunjukkan bahwa kegagalan komunikasi

berkontribusi signifikan terhadap insiden keselamatan pasien, bahkan mencapai >60% kejadian *adverse events* di fasilitas Kesehatan (Keshtkar et al., 2025). Selain itu, kesenjangan komunikasi (*communication gaps*) dapat menyebabkan kesalahan diagnosis, ketidakpatuhan terapi, hingga keterlambatan penanganan (Leotin, 2025). Hambatan ini semakin kompleks pada populasi khusus karena adanya keterbatasan perkembangan, kognitif, sosial, maupun budaya.

1) Hambatan Komunikasi pada Anak

Hambatan komunikasi pada anak terutama dipengaruhi oleh keterbatasan perkembangan bahasa, kognitif, dan emosional. Anak cenderung memiliki pola komunikasi yang belum matang, seperti komunikasi yang kaku, terbatas, atau kurang inisiatif, terutama pada kondisi kecemasan atau gangguan psikologis (Lichtwarck-Aschoff & van Rooij, 2019).

Selain itu, ketimpangan relasi antara tenaga kesehatan dan anak dapat menurunkan *sense of agency*, sehingga anak kurang terlibat dalam komunikasi dan cenderung pasif atau tidak mengekspresikan kebutuhan secara optimal (Bergen et al., 2022). Hambatan lain mencakup:

- a) keterbatasan kosakata dan pemahaman konsep abstrak
- b) kecenderungan mengekspresikan emosi melalui perilaku, bukan verbal
- c) ketergantungan pada orang tua sebagai mediator komunikasi

Secara klinis, hambatan ini dapat menyebabkan miskomunikasi terkait keluhan, ketidakakuratan pengkajian, serta menurunkan efektivitas intervensi terapeutik.

2) Hambatan Komunikasi pada Lansia

Pada lansia, hambatan komunikasi bersifat multidimensional, meliputi perubahan fisiologis, neurologis, dan sosial. Gangguan seperti penurunan pendengaran, gangguan penglihatan, serta gangguan neurologis (misalnya afasia) secara langsung memengaruhi kemampuan memahami dan menyampaikan pesan (Groher, 1981).

Selain faktor biologis, terdapat hambatan interpersonal dan sistemik, antara lain:

- a) stereotip negatif (*ageism*) yang memengaruhi kualitas interaksi tenaga kesehatan
- b) keterbatasan keterlibatan keluarga/caregiver dalam komunikasi

- c) kompleksitas kondisi penyakit kronis yang membutuhkan komunikasi lebih intensif (Huang, Morgan, Peck, & Khoury, 2021).

Komunikasi nonverbal menjadi semakin penting pada lansia, terutama ketika komunikasi verbal terganggu. Ketidakmampuan tenaga kesehatan dalam memanfaatkan ekspresi nonverbal (kontak mata, sentuhan, gesture) dapat menghambat pembentukan hubungan terapeutik (Caris-Verhallen, Kerkstra, & Bensing, 1999).

Selain itu, faktor sistem seperti *health literacy* yang rendah juga memperburuk pemahaman informasi kesehatan, sehingga lansia lebih rentan mengalami kesalahan dalam mengikuti instruksi medis (Leotin, 2025).

3) Hambatan Komunikasi pada Pasien dengan Gangguan Jiwa

Pada pasien dengan gangguan jiwa, hambatan komunikasi berkaitan erat dengan gangguan proses pikir, emosi, dan persepsi. Pasien dapat mengalami disorganisasi komunikasi, distorsi realitas, atau kesulitan memahami informasi yang diberikan.

Selain aspek klinis, hambatan utama juga berasal dari faktor relasional dan sosial, yaitu:

- a) stigma terhadap gangguan jiwa
- b) ketidakseimbangan kekuasaan antara tenaga kesehatan dan pasien
- c) invalidasi pengalaman pasien

Kondisi ini dapat menurunkan *sense of agency* pasien dan menyebabkan mereka enggan berpartisipasi aktif dalam komunikasi (Bergen et al., 2022).

Dalam praktik, pendekatan komunikasi yang terlalu berorientasi pada aspek biomedis tanpa validasi pengalaman subjektif pasien juga menjadi hambatan signifikan karena mengurangi kualitas hubungan terapeutik.

4) Hambatan Komunikasi pada Disabilitas

Pada pasien dengan disabilitas, hambatan komunikasi dapat bersifat sensorik, kognitif, maupun linguistik. Salah satu hambatan paling signifikan adalah **perbedaan bahasa**, yang terbukti meningkatkan risiko kesalahan klinis, termasuk kesalahan diagnosis, kesalahan pemberian obat, dan kegagalan memahami instruksi medis (Orujlu & Adigozalova, 2026).

Hambatan utama meliputi:

- a) keterbatasan kemampuan berbicara atau memahami bahasa
- b) rendahnya health literacy
- c) penggunaan istilah medis yang kompleks
- d) kurangnya alat bantu komunikasi (misalnya interpreter atau media visual)

Selain itu, penggunaan penerjemah tidak terlatih (misalnya keluarga) dapat menyebabkan distorsi informasi dan menurunkan akurasi komunikasi klinis (Orujlu & Adigozalova, 2026).

Faktor budaya juga memperkuat hambatan ini. Perbedaan nilai, kepercayaan, dan gaya komunikasi dapat menyebabkan miskomunikasi, rendahnya kepatuhan terapi, serta ketidakpuasan pasien (Alharazi et al., 2025; Alkhamees & Alasqah, 2023).

5) Hambatan Sistemik dan Profesional (Penguatan Baru).

Tambahan dari artikel terbaru menunjukkan bahwa hambatan komunikasi tidak hanya berasal dari pasien, tetapi juga dari sistem dan tenaga kesehatan, meliputi:

- a) **perbedaan bahasa dan budaya** antara tenaga kesehatan dan pasien
- b) **beban kerja tinggi dan keterbatasan waktu**
- c) **kurangnya pelatihan komunikasi**
- d) **hierarki profesional dan kurangnya kolaborasi tim** (Alharazi et al., 2025; Katantha, Strametz, Baluwa, Mapulanga, & Chirwa, 2025)

Selain itu, kegagalan komunikasi antar tenaga kesehatan (misalnya *nurse-physician*) dapat menyebabkan keterlambatan diagnosis, kesalahan pengobatan, dan buruknya koordinasi perawatan (Aseeri et al., 2024).

Hambatan sistemik ini memperburuk kondisi pada populasi khusus karena mereka membutuhkan komunikasi yang lebih adaptif, intensif, dan individual.

b. Mekanisme gangguan komunikasi

Berbagai hambatan komunikasi yang muncul dalam praktik keperawatan sesungguhnya merupakan manifestasi dari gangguan pada proses komunikasi itu sendiri. Untuk memahami secara komprehensif bagaimana hambatan tersebut terjadi, diperlukan penelaahan terhadap mekanisme gangguan komunikasi yang berlangsung pada berbagai tahapan, mulai dari persepsi, pemrosesan, hingga ekspresi informasi.

Gangguan komunikasi merupakan hasil dari disfungsi pada berbagai tahap pemrosesan informasi, yang secara umum meliputi tahap persepsi, pemrosesan (*processing*), dan ekspresi. Ketiga tahap ini saling terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan secara kaku, karena komunikasi merupakan proses kompleks yang melibatkan interaksi antara sistem sensorik, kognitif, dan motorik. Gangguan pada salah satu tahap akan berdampak pada keseluruhan proses komunikasi (Martino, Espay, Asano, & Morgante, 2016).

1) Tahap Persepsi (*Perception*)

Tahap persepsi merupakan proses awal dalam komunikasi yang melibatkan penerimaan dan pengenalan stimulus, baik dalam bentuk auditori maupun visual. Pada tahap ini, individu harus mampu menangkap sinyal bahasa, seperti suara, intonasi, dan simbol visual, sebelum informasi tersebut dapat dipahami lebih lanjut. Proses ini melibatkan sistem sensorik, terutama sistem pendengaran dan penglihatan, serta kemampuan *speech perception* dan *auditory processing*.

Gangguan pada tahap persepsi sering terjadi akibat penurunan fungsi sensorik maupun neurologis. Pada lansia, misalnya, penurunan kemampuan pendengaran (*presbycusis*) dapat mengganggu identifikasi kata dan pemahaman pesan, terutama dalam kondisi lingkungan yang bising atau kompleks (Thornton & Light, 2006). Selain itu, gangguan dalam *speech perception* dapat menyebabkan kesulitan membedakan fonem atau suara yang mirip, sehingga meningkatkan risiko kesalahan interpretasi pesan.

Lebih lanjut, pada tingkat neurologis, persepsi bahasa bergantung pada integrasi antara sistem sensorik dan korteks otak. Gangguan pada sistem ini, seperti pada kondisi neurologis atau gangguan perkembangan, dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam mengenali stimulus komunikasi secara akurat. Proses persepsi ini juga menjadi dasar bagi pemahaman bahasa, karena tanpa pengenalan stimulus yang tepat, informasi tidak dapat diproses lebih lanjut (S. J. Lee, Lee, Song, & Kim, 2014).

Implikasi klinis: gangguan persepsi sering tampak sebagai pasien yang “tidak memahami” instruksi, padahal masalah utamanya adalah kegagalan dalam menangkap stimulus secara akurat.

2) Tahap Pemrosesan (*Processing*)

Tahap pemrosesan merupakan proses kognitif yang melibatkan interpretasi, integrasi, dan penyimpanan informasi yang telah diterima. Pada tahap ini, individu menghubungkan stimulus yang diterima dengan pengetahuan sebelumnya untuk membentuk makna. Proses ini melibatkan berbagai komponen kognitif, seperti memori kerja, perhatian, fungsi eksekutif, serta sistem bahasa (fonologi, sintaksis, dan semantik).

Dalam konteks komunikasi, pemrosesan bahasa merupakan proses kompleks yang melibatkan interaksi antara berbagai level informasi, termasuk suara, makna, dan konteks. Pemahaman bahasa tidak hanya bergantung pada input sensorik, tetapi juga pada kemampuan individu dalam mengintegrasikan informasi secara *top-down dan bottom-up* (Thornton & Light, 2006).

Gangguan pada tahap ini sering ditemukan pada individu dengan penurunan fungsi kognitif, seperti *mild cognitive impairment* (MCI) atau gangguan neurologis lainnya. Pada lansia, misalnya, pemrosesan bahasa yang kompleks, seperti memahami kalimat panjang atau struktur sintaksis yang rumit, cenderung mengalami penurunan, meskipun pemahaman kata sederhana masih relatif baik (S. J. Lee et al., 2014). Hal ini menunjukkan bahwa gangguan tidak selalu terjadi pada tingkat dasar bahasa, tetapi lebih pada integrasi informasi yang lebih kompleks.

Selain itu, gangguan pemrosesan juga dapat terjadi pada anak dengan gangguan komunikasi, di mana keterbatasan dalam memahami makna atau konteks sosial dapat berdampak pada interaksi sosial dan perkembangan emosional. Gangguan ini sering berkaitan dengan kesulitan dalam menghubungkan informasi linguistik dengan konteks sosial yang relevan (Xue, Gong, Pill, & Han, 2025).

Implikasi klinis: pasien mungkin mampu mendengar dan mengulang informasi, tetapi tidak mampu memahami atau menginterpretasikan makna secara tepat.

3) Tahap Ekspresi (*Expression/Production*).

Tahap ekspresi merupakan proses akhir dalam komunikasi, di mana individu menyampaikan pesan melalui bahasa verbal maupun nonverbal. Proses ini melibatkan perencanaan bahasa (*linguistic planning*), pemrograman motorik, serta koordinasi sistem neuromuskular untuk menghasilkan ujaran yang dapat dipahami.

Produksi bahasa dimulai dari aktivasi representasi linguistik (seperti fonem dan kata), yang kemudian diubah menjadi program motorik untuk menghasilkan suara. Proses ini melibatkan berbagai area otak, termasuk korteks frontal, premotor, serta sistem saraf perifer yang mengontrol otot-otot bicara (Martino et al., 2016). Gangguan pada salah satu komponen ini dapat menyebabkan gangguan ekspresi, seperti disartria atau afasia.

Gangguan ekspresi juga dapat terjadi akibat faktor psikologis dan sosial. Individu dengan gangguan komunikasi, terutama pada anak, sering mengalami kesulitan mengekspresikan kebutuhan dan emosi, yang dapat berujung pada frustrasi, masalah perilaku, dan gangguan hubungan sosial (Xue et al., 2025). Selain itu, gangguan mental seperti kecemasan atau depresi juga dapat memengaruhi kemampuan individu dalam mengekspresikan pikiran secara efektif (Shahi & Sharma, 2024).

Secara klinis, gangguan ekspresi dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari kesulitan menemukan kata, gangguan artikulasi, hingga ketidakmampuan menyusun kalimat yang koheren. Kondisi seperti afasia, misalnya, menunjukkan gangguan dalam kemampuan memahami dan mengekspresikan bahasa akibat kerusakan sistem saraf pusat (Groher, 1981).

Implikasi klinis: pasien memahami pesan, tetapi tidak mampu mengungkapkan kembali secara jelas atau tepat.

Faktor biologis, psikologis, dan sosial berkontribusi terhadap gangguan ini (Casey & Kelly, 2024). Hal ini menggarisbawahi pentingnya mengatasi gangguan komunikasi untuk meningkatkan hasil kesehatan mental dan membina hubungan interpersonal yang lebih sehat (Koegel & Ashbaugh, 2017). Mengatasi gangguan ini melalui strategi komunikasi yang efektif dapat meningkatkan kesejahteraan emosional dan memperkuat koneksi sosial, yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan hasil kesehatan mental (Shahi & Sharma, 2024). Meningkatkan keterampilan komunikasi sangat penting untuk membina pemahaman dan dukungan, yang dapat secara signifikan mengurangi tantangan kesehatan mental yang dihadapi individu. Komunikasi yang efektif tidak hanya memfasilitasi hubungan yang lebih baik tetapi juga memberdayakan individu untuk mengekspresikan kebutuhan kesehatan mental mereka dan mencari dukungan yang tepat.

C. Asuhan keperawatan komunikasi pada populasi khusus

1. Asuhan Keperawatan dalam Komunikasi Anak

a. Pendahuluan

Komunikasi pada anak merupakan proses yang kompleks karena sangat dipengaruhi oleh tahap perkembangan, kemampuan kognitif, pengalaman, serta lingkungan sosial anak. Anak memproses informasi secara berbeda dibandingkan orang dewasa karena keterbatasan kemampuan kognitif dan komunikasi, sehingga membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan tahap perkembangannya (Desai & Pandya, 2013). Selain itu, komunikasi merupakan kebutuhan dasar manusia yang telah dimulai sejak awal kehidupan dan berperan dalam membantu individu memahami diri dan lingkungannya (Doğan & Çamurcu, 2025). Hal ini sejalan dengan konsep perkembangan anak yang menyatakan bahwa kemampuan komunikasi berkembang secara bertahap sesuai dengan maturasi kognitif dan sosial anak (Hurlock, 1979).

Dalam praktik keperawatan, komunikasi bukan hanya sebagai alat pertukaran informasi, tetapi juga sebagai sarana membangun hubungan terapeutik yang mendukung proses penyembuhan. Komunikasi yang efektif berkontribusi terhadap kesejahteraan psikologis, kepercayaan, serta hasil kesehatan anak dan keluarga (Sisk, Friedrich, Mozersky, Walsh, & DuBois, 2020). Hubungan ini menjadi sangat penting pada anak karena mereka berada dalam kondisi rentan dan sering mengalami stres selama proses perawatan atau hospitalisasi (Desai & Pandya, 2013). Perawat memiliki peran penting dalam membangun hubungan terapeutik melalui komunikasi yang sesuai dengan perkembangan anak (Kyle & Carman, 2013).

Selain itu, komunikasi dalam keperawatan anak bersifat khas karena melibatkan interaksi antara perawat, anak, dan keluarga. Pendekatan ini menuntut keterlibatan aktif keluarga dalam proses komunikasi dan pengambilan keputusan (Sisk et al., 2020). Pendekatan ini dikenal sebagai *family-centered care*, di mana keluarga menjadi bagian integral dalam asuhan keperawatan anak (Ball, J. W., 2011).

Komunikasi dalam keperawatan anak juga tidak terbatas pada penyampaian informasi secara verbal, tetapi mencakup aspek nonverbal, emosional, dan relasional yang membentuk makna dalam interaksi. Dalam praktiknya, komunikasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses

asuhan keperawatan dan berkontribusi langsung terhadap kualitas pelayanan (Martinez, Tocantins, & de Souza, 2013).

Namun demikian, anak belum sepenuhnya mampu mengekspresikan kebutuhan, perasaan, maupun pengalaman sakit secara verbal karena keterbatasan perkembangan bahasa dan kognitif, sehingga perawat dituntut memiliki kemampuan khusus dalam melakukan pengkajian komunikasi secara komprehensif (Axton & Fugate, 2009; Kyle & Carman, 2013).

b. Landasan Teori Komunikasi dalam Keperawatan Anak

Komunikasi dalam keperawatan anak tidak hanya dipahami sebagai proses pertukaran informasi, tetapi juga sebagai proses terapeutik yang berlandaskan teori keperawatan dan pendekatan berbasis keluarga.

Teori hubungan interpersonal yang dikemukakan oleh Peplau menekankan bahwa komunikasi merupakan inti dari hubungan terapeutik antara perawat dan pasien. Dalam konteks keperawatan anak, perawat berperan sebagai fasilitator, edukator, dan pendukung emosional dalam membantu anak memahami kondisi kesehatannya serta mengurangi kecemasan (Kyle & Carman, 2013), 2012).

Pendekatan *family-centered care* menekankan pentingnya kolaborasi antara tenaga kesehatan dan keluarga dalam proses komunikasi. Keterlibatan keluarga terbukti meningkatkan efektivitas komunikasi dan membantu anak dalam memahami kondisi kesehatannya (Ball, J. W., 2011; Lind, Wigert, Jenholt Nolbris, & Patriksson, 2024).

Selain itu, pendekatan *child-centered care* menempatkan anak sebagai individu yang memiliki hak untuk didengar dan dilibatkan dalam komunikasi terkait kesehatannya. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu menggunakan strategi komunikasi yang sesuai dengan tahap perkembangan anak (Desai & Pandya, 2013).

Dalam konteks kesehatan mental, komunikasi yang menghargai pengalaman anak dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan *sense of agency* anak, yaitu kemampuan anak untuk merasa memiliki kontrol terhadap situasinya (Bergen et al., 2022).

c. Pengkajian Komunikasi pada Anak

Pengkajian komunikasi merupakan tahap awal dalam proses keperawatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan, hambatan, serta kebutuhan komunikasi anak. Pengkajian ini penting karena komunikasi yang tidak efektif dapat berdampak pada keselamatan pasien, kepatuhan terapi, serta kualitas perawatan (Bell & Condren, 2018).

Pengkajian komunikasi menjadi dasar dalam menentukan strategi komunikasi yang tepat dan efektif dalam asuhan keperawatan (Axton & Fugate, 2009).

1) Pengkajian Karakteristik Perkembangan Anak

Kemampuan komunikasi anak sangat dipengaruhi oleh tahap perkembangan. Oleh karena itu, perawat perlu mengkaji:

- a) usia dan tahap perkembangan
- b) kemampuan bahasa (verbal dan nonverbal)
- c) tingkat pemahaman terhadap instruksi

Perbedaan tahap perkembangan memengaruhi cara anak memahami pengalaman kesehatan, termasuk munculnya ketakutan dan respons emosional terhadap tindakan medis (Desai & Pandya, 2013). Selain itu, perkembangan komunikasi juga dipengaruhi oleh interaksi sosial dan lingkungan anak (Doğan & Çamurcu, 2025; Hurlock, 1979).

Anak pada usia dini lebih banyak menggunakan komunikasi nonverbal seperti ekspresi wajah, tangisan, dan gerakan tubuh, sedangkan anak usia sekolah mulai mampu menggunakan bahasa verbal secara lebih kompleks (Kyle & Carman, 2013). Ketidaksesuaian antara pendekatan komunikasi dengan tahap perkembangan dapat menyebabkan kecemasan dan hambatan komunikasi pada anak (Desai & Pandya, 2013).

2) Pengkajian Kemampuan Verbal dan Nonverbal

Pengkajian komunikasi tidak hanya berfokus pada kemampuan berbicara, tetapi juga mencakup:

- a) kemampuan memahami bahasa (reseptif)
- b) kemampuan mengekspresikan bahasa (ekspresif)
- c) penggunaan komunikasi nonverbal

Dalam konteks klinis, komunikasi nonverbal memiliki makna penting karena anak sering mengekspresikan perasaan melalui perilaku. Bahkan diam atau tangisan tetap merupakan bentuk komunikasi yang menyampaikan pesan (Díaz-Pérez, Yáñez-Torregroza, Gómez, Carrillo-Suárez, & Mora, 2018). Kemampuan komunikasi anak berkembang seiring dengan perkembangan bahasa dan interaksi sosial yang dialaminya (Doğan & Çamurcu, 2025).

3) Pengkajian Respons Emosional dan Perilaku

Kondisi emosional sangat memengaruhi kemampuan komunikasi anak. Pengkajian meliputi:

- a) tingkat kecemasan atau ketakutan
- b) respons terhadap lingkungan rumah sakit
- c) perilaku kooperatif atau resistensi

Anak yang berada dalam kondisi stres atau hospitalisasi cenderung mengalami kesulitan dalam memproses informasi dan berkomunikasi secara efektif (Desai & Pandya, 2013). Pada kondisi tertentu, seperti gangguan kecemasan, anak dapat menunjukkan pola komunikasi yang kaku dan terbatas dalam interaksi sosial (Lichtwarck-Aschoff & van Rooij, 2019). Lingkungan yang asing, prosedur medis, dan perpisahan dengan orang tua dapat memperburuk kondisi emosional anak (Kyle & Carman, 2013).

4) Pengkajian Interaksi Anak dengan Orang Tua/Keluarga

Komunikasi anak tidak dapat dipisahkan dari konteks keluarga. Perawat perlu mengkaji:

- a) pola komunikasi dalam keluarga
- b) peran orang tua dalam komunikasi
- c) tingkat keterlibatan keluarga

Keluarga memiliki peran penting dalam perkembangan komunikasi anak karena interaksi dalam keluarga memengaruhi kemampuan anak dalam mengekspresikan diri dan memahami lingkungan (Doğan & Çamurcu, 2025). Keterlibatan keluarga dalam komunikasi juga membantu meningkatkan efektivitas interaksi dengan anak serta mendukung proses perawatan (Ball, J. W., 2011; Lind et al., 2024).

5) Pengkajian Faktor Lingkungan dan Situasional

Lingkungan pelayanan kesehatan dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat komunikasi. Hal yang perlu dikaji meliputi:

- a) suasana ruang
- b) keberadaan alat medis
- c) kondisi saat komunikasi dilakukan

Lingkungan yang tidak kondusif dapat meningkatkan stres pada anak dan menghambat komunikasi (Desai & Pandya, 2013). Lingkungan yang ramah anak dan nyaman dapat meningkatkan keterlibatan anak dalam komunikasi serta membantu mereka merasa aman selama perawatan (Kyle & Carman, 2013).

6) Pengkajian Hambatan Komunikasi Spesifik

Perawat juga perlu mengidentifikasi hambatan khusus seperti:

- a) gangguan perkembangan Bahasa
- b) gangguan kognitif
- c) kondisi medis

Komunikasi yang tidak efektif dapat berdampak pada keselamatan pasien dan kualitas perawatan (Bell & Condren, 2018). Selain itu, hambatan komunikasi juga dapat dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman informasi kesehatan pada anak dan keluarga (Bell & Condren, 2018). Identifikasi dini terhadap hambatan ini penting untuk menentukan intervensi komunikasi yang tepat (Axton & Fugate, 2009).

d. Diagnosa Keperawatan Komunikasi Anak

Diagnosa keperawatan pada masalah komunikasi anak berfokus pada gangguan kemampuan anak dalam menerima, memproses, atau mengekspresikan informasi secara efektif. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh faktor perkembangan, kondisi emosional, lingkungan, maupun gangguan kesehatan tertentu. Diagnosa yang umum adalah:

1) Gangguan Komunikasi Verbal pada Anak

Definisi: Ketidakmampuan atau keterbatasan anak dalam menerima, memproses, atau mengekspresikan pesan secara verbal sesuai tahap perkembangan.

Karakteristik (data subjektif & objektif):

- a) Kesulitan mengungkapkan kebutuhan
- b) Respons terbatas terhadap komunikasi
- c) Penggunaan bahasa tidak sesuai usia
- d) Menunjukkan perilaku nonverbal (menangis, menarik diri, agresif)

Keterbatasan komunikasi ini sering terjadi pada anak dengan keterlambatan perkembangan bahasa maupun kondisi klinis tertentu, di mana anak tidak mampu menyampaikan pesan secara efektif dibandingkan dengan anak seusianya (Putri, Nugraheni, & Winarni, 2024).

Selain itu, gangguan komunikasi juga dapat menyebabkan frustrasi, kecemasan, serta perilaku maladaptif akibat ketidakmampuan anak dalam mengekspresikan kebutuhan dan perasaannya (Voss, 2019).

2) Kecemasan Berhubungan dengan Hambatan Komunikasi

Definisi: Perasaan tidak nyaman atau takut pada anak yang berkaitan dengan ketidakmampuan memahami atau menyampaikan informasi selama perawatan.

Karakteristik:

- a) Menangis, gelisah
- b) Menolak tindakan
- c) Tidak kooperatif

Lingkungan klinis yang asing serta kurangnya komunikasi yang sesuai perkembangan dapat meningkatkan kecemasan pada anak dan menghambat interaksi terapeutik (Boztepe & Cinar Ozbay, 2023).

3) Kesiapan Peningkatan Komunikasi (Readiness for Enhanced Communication)

Definisi: Keadaan di mana anak menunjukkan potensi untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dengan dukungan yang tepat.

Karakteristik:

- a) Mulai merespons komunikasi
- b) Menunjukkan minat berinteraksi
- c) Mampu mengikuti instruksi sederhana

Pendekatan komunikasi yang tepat dapat meningkatkan keterlibatan anak dan membantu mereka menjadi partisipan aktif dalam perawatan (Davison, Conn, Kelly, Thompson, & Dornan, 2023).

e. Intervensi Keperawatan Komunikasi Anak

Intervensi komunikasi pada anak bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam memahami dan mengekspresikan informasi, serta membangun hubungan terapeutik antara perawat, anak, dan keluarga.

**Tabel 2.1: Intervensi Komunikasi Anak Berbasis Perkembangan
(Evidence-Based & Klinis)**

<u>Usia</u>	<u>Tahap Piaget</u>	<u>Tahap Erikson</u>	<u>Karakteristik Perkembangan</u>	<u>Intervensi Komunikasi</u>	<u>Peran Keluarga</u>	<u>Contoh Praktik Klinis</u>	<u>Rasional Ilmiah</u>
<u>Bayi (0–1 th)</u>	Sensorimotor	Trust vs Mistrust	Nonverbal, sensorimotor, <u>bergantung</u> pada caregiver	- Sentuhan terapeutik - Kontak mata - Nada suara lembut - Respons cepat terhadap tangisan	<u>Memberi</u> rasa <u>aman</u> , bonding	Menggendong saat tindakan, bicara lembut saat injeksi	Komunikasi nonverbal merupakan bentuk utama komunikasi pada bayi dan berperan dalam membangun rasa aman dan kepercayaan (Díaz-Pérez et al., 2018; Kyle, T., & Carman, 2012).
<u>Toddler (1–3 th)</u>	Sensorimotor akhir → <u>Praoperasional awal</u>	Autonomy vs Shame	Bahasa terbatas, egosentris, butuh kontrol	- Gunakan kalimat sederhana - Beri pilihan terbatas - Gunakan distraksi (mainan)	<u>Mendampingi</u> , <u>memberi</u> rasa <u>kontrol</u>	"Pilih tangan kanan/kiri untuk diperiksa"	Anak usia toddler memahami komunikasi konkret dan sederhana, serta membutuhkan kontrol untuk mengurangi kecemasan (Ball, J. W., 2011; Kyle & Carman, 2013).
<u>Usia</u>	<u>Tahap Piaget</u>	<u>Tahap Erikson</u>	<u>Karakteristik Perkembangan</u>	<u>Intervensi Komunikasi</u>	<u>Peran Keluarga</u>	<u>Contoh Praktik Klinis</u>	<u>Rasional Ilmiah</u>
<u>Prasekolah (3–6 th)</u>	<u>Praoperasional</u>	Initiative vs Guilt	<u>Imajinatif</u> , <u>simbolik</u> , <u>berpikir magis</u>	- Storytelling - <u>Bermain peran</u> (play therapy) - <u>Gunakan gambar/alat peraga</u>	<u>Menjelaskan</u> <u>dengan</u> <u>bahasa</u> <u>sederhana</u>	<u>Boneka</u> <u>untuk</u> <u>simulasi</u> <u>tindakan</u>	Metode bermain membantu anak memahami prosedur dan mengekspresikan emosi secara efektif (Anggraini, Alifatin, Aini, & Pradita, 2022; Doğan & Çamurcu, 2025);
<u>Usia sekolah (6–12 th)</u>	Concrete operational	Industry vs Inferiority	Logis konkret, ingin tahu, kooperatif	- Penjelasan rasional sederhana - Libatkan dalam diskusi - Gunakan media visual	Mendukung pemahaman & motivasi	Menjelaskan prosedur step-by-step	Anak usia sekolah mampu memahami hubungan sebab-akibat sehingga komunikasi rasional meningkatkan kerja sama (Bell & Condren, 2018)
<u>Remaja (12–18 th)</u>	Formal operational	Identity vs Role confusion	Abstrak, kritis, butuh identitas & privasi	- Komunikasi terbuka - Hormati privasi - Libatkan dalam pengambilan keputusan	<u>Memberi</u> <u>dukungan</u> <u>tanpa</u> <u>dominasi</u>	<u>Edukasi</u> <u>langsung</u> , <u>diskusi</u> <u>mandiri</u>	<u>Keterlibatan aktif</u> <u>meningkatkan</u> <u>sense of</u> <u>autonomy</u> <u>dan</u> <u>partisipasi</u> <u>dalam</u> <u>perawatan</u> (Bergen et al., 2022).

Pada tabel 1, Intervensi komunikasi pada anak harus dilakukan secara individual dan *developmentally appropriate*, yaitu disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif, bahasa, dan psikososial anak. Komunikasi yang efektif tidak hanya melibatkan penyampaian informasi, tetapi juga mencakup aspek emosional dan hubungan terapeutik antara perawat, anak, dan keluarga.

Pada bayi dan toddler, komunikasi lebih banyak dilakukan melalui pendekatan nonverbal karena keterbatasan kemampuan bahasa. Oleh karena itu, sentuhan, ekspresi wajah, dan nada suara menjadi komponen penting dalam membangun hubungan terapeutik (Díaz-Pérez et al., 2018).

Pada usia prasekolah, penggunaan metode bermain dan *storytelling* menjadi strategi efektif dalam membantu anak memahami prosedur kesehatan dan mengekspresikan emosi (Doğan & Çamurcu, 2025).

Anak usia sekolah membutuhkan komunikasi yang logis dan konkret, sedangkan remaja memerlukan pendekatan komunikasi yang menghargai otonomi, privasi, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan (Bell & Condren, 2018).

Pendekatan komunikasi yang berpusat pada anak (*child-centered communication*) menekankan pentingnya melibatkan anak secara aktif dalam interaksi, mendengarkan perspektif anak, serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami (Davison et al., 2023). Selain itu, keterlibatan keluarga menjadi faktor penting dalam komunikasi, karena keluarga berperan sebagai mediator yang membantu anak memahami informasi serta memberikan rasa aman selama proses perawatan (Lind et al., 2024).

Teknik bermain (*play therapy*) juga terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan komunikasi, terutama pada anak dengan gangguan perkembangan seperti autisme, karena dapat membantu anak mengekspresikan emosi dan meningkatkan kemampuan sosial (Anggraini et al., 2022). Pada anak dengan gangguan komunikasi, penggunaan strategi seperti *augmentative and alternative communication (AAC)*, media visual, serta pendekatan berbasis teknologi dapat membantu meningkatkan kemampuan komunikasi secara signifikan (Gilbert, 2019).

Dengan demikian, komunikasi yang disesuaikan dengan tahap perkembangan tidak hanya meningkatkan pemahaman anak, tetapi juga berperan dalam menurunkan kecemasan, meningkatkan kerja sama, serta memperkuat hubungan terapeutik antara perawat, anak, dan keluarga.

Tabel 2.2: Hambatan & Pendekatan Komunikasi Anak

Usia	Hambatan Umum	Intervensi Spesifik
Bayi	Tidak bisa verbal	Observasi perilaku, respon cepat
Toddler	Tantrum, negativisme	Pilihan terbatas, distraksi
Prasekolah	Takut, fantasi	Klarifikasi sederhana + bermain
Sekolah	Takut nyeri	Edukasi + reassurance
Remaja	Menarik diri	Validasi + komunikasi terbuka

Hambatan komunikasi pada anak bervariasi sesuai dengan tahap perkembangan, sehingga memerlukan pendekatan yang spesifik dan disesuaikan dengan karakteristik usia. Setiap tahap perkembangan memiliki tantangan komunikasi yang unik, baik dari aspek kognitif, emosional, maupun kemampuan bahasa. Oleh karena itu, identifikasi hambatan komunikasi menjadi langkah penting dalam menentukan intervensi yang tepat dalam asuhan keperawatan.

Pada bayi, hambatan utama terletak pada ketidakmampuan berkomunikasi secara verbal, sehingga seluruh ekspresi kebutuhan disampaikan melalui perilaku nonverbal seperti tangisan, gerakan tubuh, dan ekspresi wajah. Dalam kondisi ini, perawat perlu memiliki kemampuan observasi yang baik serta memberikan respons yang cepat dan tepat untuk memenuhi kebutuhan bayi. Pendekatan ini penting untuk membangun rasa aman dan kepercayaan sebagai dasar hubungan terapeutik (Díaz-Pérez et al., 2018).

Pada *toddler*, hambatan komunikasi sering muncul dalam bentuk perilaku negativisme, seperti penolakan atau tantrum, yang berkaitan dengan kebutuhan anak untuk mempertahankan otonomi. Oleh karena itu, pemberian pilihan terbatas dan penggunaan teknik distraksi menjadi strategi efektif untuk mengurangi resistensi dan meningkatkan kerja sama anak (Kyle & Carman, 2013).

Pada anak usia prasekolah, hambatan komunikasi sering berkaitan dengan ketakutan dan fantasi yang berkembang akibat kemampuan berpikir simbolik. Anak dapat menginterpretasikan prosedur medis secara keliru, misalnya sebagai bentuk hukuman. Oleh karena itu, penggunaan klarifikasi sederhana, pendekatan bermain, dan media visual menjadi penting untuk membantu anak memahami situasi secara realistis (Doğan & Çamurcu, 2025).

Pada anak usia sekolah, hambatan komunikasi umumnya berkaitan dengan ketakutan terhadap nyeri atau kegagalan. Anak pada tahap ini telah mampu berpikir logis konkret, sehingga membutuhkan penjelasan yang rasional dan sistematis. Edukasi yang jelas dan pemberian *reassurance* dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kerja sama anak selama perawatan (Bell & Condren, 2018).

Sementara itu, pada remaja, hambatan komunikasi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor psikososial, seperti kebutuhan akan identitas diri, privasi, dan kemandirian. Remaja cenderung menarik diri atau menunjukkan resistensi jika merasa tidak dihargai. Oleh karena itu, komunikasi yang bersifat terbuka, empatik, serta menghargai privasi dan otonomi sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan partisipasi dalam perawatan (Bergen et al., 2022).

Dengan demikian, pemahaman terhadap hambatan komunikasi berdasarkan tahap perkembangan memungkinkan perawat untuk memilih strategi komunikasi yang lebih efektif, sehingga dapat meningkatkan kualitas interaksi terapeutik serta keberhasilan asuhan keperawatan pada anak.

f. Evaluasi Keperawatan Komunikasi Anak

Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas intervensi komunikasi yang telah diberikan.

Kriteria hasil yang diharapkan:

- 1) Anak mampu mengekspresikan kebutuhan secara verbal/nonverbal
- 2) Anak menunjukkan peningkatan respons terhadap komunikasi
- 3) Anak tampak lebih kooperatif selama perawatan
- 4) Tingkat kecemasan anak menurun
- 5) Anak terlibat dalam interaksi dengan perawat dan keluarga

Evaluasi juga mencakup kemampuan anak dalam memahami informasi serta partisipasi aktif dalam proses perawatan. Komunikasi yang

efektif terbukti meningkatkan keterlibatan anak dan keluarga serta memperbaiki kualitas asuhan keperawatan (Rasmita, Suza, & Arruum, 2026). Selain itu, keberhasilan komunikasi juga dapat dilihat dari peningkatan hubungan terapeutik serta kepuasan anak dan keluarga terhadap pelayanan kesehatan (Osei Appiah et al., 2022).

2. Asuhan Keperawatan pada Komunikasi Lansia

Komunikasi pada lansia merupakan proses dinamis yang melibatkan pertukaran informasi, emosi, dan makna antara perawat dan pasien, yang dipengaruhi oleh kondisi fisiologis, kognitif, psikologis, serta lingkungan. Dalam konteks keperawatan, komunikasi menjadi kompetensi inti karena menentukan keberhasilan hubungan terapeutik, pengambilan keputusan, serta kualitas asuhan yang diberikan.

Komunikasi yang efektif terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan, kepuasan pasien, serta *outcome* kesehatan pada lansia (elzeni, soliman, & Boughdady, 2023). Selain itu, komunikasi juga merupakan komponen fundamental dalam praktik keperawatan yang berorientasi pada *person-centered care* (Daly, 2017).

a. Landasan Teori Komunikasi dalam Keperawatan Lansia

Dalam perspektif keperawatan, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai pertukaran informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun hubungan terapeutik, mengidentifikasi kebutuhan pasien, mendukung pengambilan Keputusan, meningkatkan kesejahteraan psikologis. Literatur menunjukkan bahwa komunikasi merupakan prasyarat utama dalam memberikan asuhan yang sesuai dengan kebutuhan individual lansia (Caris-Verhallen, Kerkstra, & Bensing, 1997).

Secara teoritis, komunikasi dalam keperawatan lansia dapat dipahami melalui model interaksi, seperti *Theory of Goal Attainment* dari King, yang menekankan bahwa komunikasi merupakan proses interaksi antara perawat dan pasien untuk menetapkan tujuan dan mencapai hasil kesehatan secara bersama-sama (Verhallen, M.C.M., Kerkstra, Van Der Heijden, & Bensing, 1998).

1) Faktor yang Mempengaruhi Komunikasi Lansia

Komunikasi pada lansia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, meliputi faktor pasien, perawat, dan lingkungan.

a) Faktor Pasien

Lansia mengalami perubahan fisiologis seperti penurunan pendengaran, penglihatan, serta fungsi neurologis yang memengaruhi kemampuan komunikasi. Selain itu, gangguan kognitif seperti *mild cognitive impairment* dan demensia dapat menyebabkan gangguan dalam memahami maupun mengekspresikan pesan (NICE, 2023).

Lansia mengalami berbagai perubahan fisiologis seperti penurunan pendengaran (*presbycusis*), gangguan penglihatan, serta penurunan kecepatan pemrosesan informasi. Kondisi ini menyebabkan lansia membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami pesan dan merespons komunikasi. Selain itu, penggunaan alat bantu seperti kacamata atau alat bantu dengar cukup tinggi pada lansia, yang menunjukkan adanya keterbatasan sensorik dalam komunikasi (elzeni et al., 2023).

Penurunan fungsi kognitif, terutama dalam pemahaman informasi kompleks dan memori jangka pendek, cenderung menyebabkan lansia mengalami kesulitan dalam memahami kalimat panjang atau kompleks dibandingkan dengan kalimat sederhana (S. J. Lee et al., 2014).

Pada kondisi tertentu seperti *mild cognitive impairment* hingga demensia, gangguan komunikasi dapat menjadi lebih signifikan dan memengaruhi kemampuan menerima maupun mengekspresikan pesan (Mishari & Ali, 2025).

Secara psikologis, lansia juga dapat mengalami kecemasan, kesepian, atau penurunan motivasi komunikasi yang berdampak pada interaksi dengan tenaga Kesehatan serta resiko kecemasan dan deoresi (Minarti et al., 2022). Komunikasi terapeutik terbukti berperan dalam menurunkan tingkat kecemasan lansia serta meningkatkan kenyamanan selama perawatan (Deviantony et al., 2024).

b) Faktor Perawat

Karakteristik perawat seperti tingkat pendidikan, pengalaman, sikap terhadap lansia, serta kepuasan kerja berpengaruh terhadap kualitas komunikasi yang dilakukan.

Perawat dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung menggunakan komunikasi yang lebih suportif, informatif, dan berorientasi pada pasien (Caris-Verhallen, De Gruijter, Kerkstra, & Bensing, 1999).

Selain itu, keterampilan komunikasi terapeutik menjadi faktor penting dalam membangun hubungan yang efektif dengan lansia.

c) Faktor Lingkungan

Lingkungan pelayanan kesehatan seperti kebisingan, pencahayaan, serta keterbatasan waktu menjadi hambatan utama komunikasi. Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan merupakan salah satu faktor dominan yang menyebabkan hambatan komunikasi antara perawat dan lansia (elzeni et al., 2023).

2) Karakteristik Komunikasi pada Lansia

Komunikasi pada lansia memiliki karakteristik khusus, antara lain: membutuhkan waktu lebih lama untuk memproses informasi, lebih sensitif terhadap pendekatan interpersonal, cenderung menghindari konflik atau mempertanyakan otoritas tenaga Kesehatan, memiliki kebutuhan tinggi terhadap komunikasi emosional (*affective communication*).

Dalam praktik keperawatan, komunikasi tidak hanya bersifat instrumental (berorientasi tugas), tetapi juga harus mencakup aspek afektif untuk memenuhi kebutuhan emosional pasien (Caris-Verhallen et al., 1997).

3) Hambatan Komunikasi pada Lansia

Hambatan komunikasi pada lansia bersifat multifaktorial, meliputi faktor pasien, perawat, dan lingkungan.

Beberapa hambatan yang sering ditemukan: penurunan fungsi sensorik (pendengaran dan penglihatan), gangguan kognitif (demensia, delirium), kurangnya keterampilan komunikasi perawat, beban kerja tinggi, lingkungan yang tidak mendukung.

Komunikasi yang tidak efektif masih menjadi masalah utama dalam pelayanan kesehatan dan dapat menurunkan kualitas asuhan serta kepuasan pasien (elzeni et al., 2023). Selain itu, faktor perawat, pasien, dan setting pelayanan secara bersama-sama memengaruhi kualitas komunikasi yang terjadi (Caris-Verhallen, De Gruijter, et al., 1999).

4) Prinsip Komunikasi Efektif pada Lansia

Pendekatan komunikasi pada lansia harus berbasis *person-centered care*, yaitu menghargai individu sebagai pribadi yang unik dengan kebutuhan dan pengalaman yang berbeda. Berdasarkan panduan WHO (ICOPE), strategi komunikasi pada lansia meliputi:

- a) menghindari stereotip terhadap lansia
- b) fokus pada kebutuhan dan prioritas individu
- c) melibatkan lansia dalam pengambilan keputusan
- d) menyesuaikan komunikasi dengan kapasitas pasien
- e) melibatkan keluarga atau *caregiver* bila diperlukan (WHO, 2024)

Selain itu, komunikasi harus bersifat dua arah, saling menghargai, serta mempertimbangkan aspek budaya dan sosial pasien (White & Verdusco, 2018).

5) Komunikasi pada Lansia dengan Gangguan Kognitif

Pada lansia dengan demensia, komunikasi menjadi lebih kompleks karena adanya gangguan memori, bahasa, dan fungsi eksekutif. Pedoman NICE menekankan bahwa: komunikasi harus disesuaikan dengan kemampuan pasien, pasien tetap harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dukungan keluarga sangat penting dalam proses komunikasi (NICE, 2023). Pendekatan komunikasi harus sederhana, konsisten, dan menggunakan kombinasi verbal serta nonverbal.

b. Pengkajian Komunikasi pada Lansia

Pengkajian komunikasi merupakan langkah awal dalam asuhan keperawatan untuk mengidentifikasi kemampuan serta hambatan komunikasi pada pasien lansia. Komunikasi pada lansia bersifat kompleks karena dipengaruhi oleh perubahan fisiologis, kognitif, psikologis, sosial, dan lingkungan yang saling berinteraksi (Cenedesi et al., 2024; Sibiya, 2018; White & Verdusco, 2018). Oleh karena itu, pengkajian harus dilakukan secara komprehensif dan berorientasi pada kebutuhan individu.

1) Aspek Fisiologis

Pengkajian aspek fisiologis meliputi: fungsi pendengaran, fungsi penglihatan, penggunaan alat bantu (kacamata, alat bantu dengar). Perubahan fisiologis akibat proses penuaan, seperti penurunan pendengaran dan penglihatan, merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi komunikasi pada lansia. Kondisi ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menerima informasi dan meningkatkan risiko miskomunikasi dalam pelayanan kesehatan (elzeni et al., 2023).

2) Aspek Kognitif

Pengkajian aspek kognitif meliputi: orientasi (waktu, tempat, orang), memori, kemampuan memahami informasi. Fungsi kognitif pada lansia dapat mengalami penurunan, mulai dari proses penuaan normal hingga kondisi patologis seperti *mild cognitive impairment* (MCI) dan demensia. Penurunan ini berdampak langsung pada kemampuan memahami dan memproses informasi komunikasi (Mishari & Ali, 2025).

Pada lansia dengan demensia, kemampuan komunikasi reseptif dan ekspresif perlu dikaji secara spesifik karena sangat bervariasi antar individu dan dapat berubah sesuai progres penyakit (Britto & Samperiz, 2010; C. A. Miller, 2008).

3) Aspek Psikologis

Pengkajian aspek psikologis meliputi: kecemasan, kondisi emosi, motivasi dalam berkomunikasi. Faktor psikologis seperti kecemasan, depresi, atau stres dapat menjadi hambatan komunikasi yang signifikan. Lansia dengan kondisi emosional yang tidak stabil cenderung mengalami kesulitan dalam mengekspresikan kebutuhan dan berpartisipasi dalam komunikasi (elzeni et al., 2023).

Selain itu, komunikasi terapeutik yang efektif terbukti berperan dalam menurunkan kecemasan dan meningkatkan kenyamanan lansia selama proses perawatan (Deviantony et al., 2024).

4) Aspek Sosial

Pengkajian aspek sosial meliputi: dukungan keluarga, pola komunikasi sebelumnya, interaksi sosial. Komunikasi pada lansia tidak terlepas dari konteks sosial. Dukungan keluarga dan pengalaman komunikasi sebelumnya sangat memengaruhi cara lansia berinteraksi dengan tenaga kesehatan. Kurangnya dukungan sosial dapat menurunkan partisipasi lansia dalam komunikasi dan proses perawatan (Verhallen et al., 1998).

5) Aspek Lingkungan

Pengkajian aspek lingkungan meliputi: kebisingan, pencahayaan, privasi. Lingkungan merupakan faktor penting yang dapat menjadi hambatan atau pendukung komunikasi. Lingkungan yang bising, pencahayaan yang buruk, atau kurangnya privasi dapat mengganggu proses komunikasi dan menurunkan pemahaman lansia terhadap informasi yang diberikan (elzeni et al., 2023).

Lingkungan yang mendukung komunikasi juga berperan dalam meningkatkan partisipasi lansia dalam perawatan serta membantu mempertahankan fungsi kognitif dan orientasi (Williams, 2018).

Pengkajian komunikasi yang komprehensif memungkinkan perawat mengidentifikasi secara tepat kebutuhan komunikasi lansia serta menyesuaikan strategi komunikasi yang digunakan. Pendekatan yang berpusat pada pasien (*person-centered*) menjadi kunci dalam memastikan komunikasi berjalan efektif dan mendukung kualitas asuhan keperawatan (Bramhall, 2014; Daly, 2017; White & Verduco, 2018).

c. Diagnosa, Intervensi, dan Evaluasi Komunikasi pada Lansia

Tabel 2.3: Asuhan Keperawatan Komunikasi pada Lansia

Diagnosa Keperawatan	Intervensi Keperawatan	Evaluasi
Gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan penurunan fungsi sensorik (pendengaran/penglihatan)	– Gunakan komunikasi verbal yang jelas, lambat, dan artikulatif – Hadapkan wajah sejajar dengan lansia untuk mendukung pembacaan bibir dan isyarat nonverbal – Kurangi kebisingan lingkungan sebagai distraksi komunikasi – Gunakan alat bantu (kacamata, alat bantu dengar) bila tersedia – Kombinasikan komunikasi verbal dan nonverbal (kontak mata, anggukan, sentuhan) untuk memperjelas pesan	Lansia mampu memahami pesan, ditunjukkan dengan respon verbal/nonverbal yang tepat dan berkurangnya kesalahan persepsi

Diagnosa Keperawatan	Intervensi Keperawatan	Evaluasi
Gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan penurunan kognitif (misalnya demensia)	– Gunakan kalimat sederhana, pendek, dan satu instruksi dalam satu waktu – Ulangi informasi secara konsisten dan gunakan pendekatan yang familiar – Berikan waktu lebih lama untuk respon – Gunakan komunikasi nonverbal dan pendekatan personal (sentuhan, ekspresi wajah) – Sesuaikan komunikasi dengan tingkat kemampuan bahasa pasien yang dapat berubah sesuai progres penyakit	Lansia mampu mengikuti instruksi sederhana, menunjukkan keterlibatan dalam komunikasi, dan tampak lebih tenang
Isolasi sosial berhubungan dengan keterbatasan komunikasi dan perubahan psikososial	– Fasilitasi komunikasi dengan keluarga atau caregiver – Libatkan lansia dalam percakapan bermakna berbasis pengalaman hidup (reminiscence approach) – Gunakan komunikasi empatik untuk membangun hubungan terapeutik	Lansia menunjukkan peningkatan interaksi sosial, lebih responsif, dan terlibat dalam percakapan

Diagnosa Keperawatan	Intervensi Keperawatan	Evaluasi
	– Dorong partisipasi dalam aktivitas sosial sesuai kemampuan	
Risiko kesepian berhubungan dengan kehilangan pasangan/peran sosial	– Berikan kesempatan lansia mengekspresikan perasaan – Validasi emosi tanpa menghakimi – Gunakan komunikasi terapeutik untuk menurunkan kecemasan – Libatkan keluarga dalam komunikasi dan pengambilan keputusan	Lansia mampu mengungkapkan perasaan, tampak lebih tenang, dan menunjukkan penurunan tanda kesepian/kecemasan
Gangguan interaksi sosial berhubungan dengan perubahan fungsi fisik dan peran	– Identifikasi hambatan komunikasi (fisik, psikologis, lingkungan) – Terapkan komunikasi berpusat pada pasien (person-centred communication) – Gunakan kombinasi komunikasi instrumental (informasi) dan afektif (dukungan emosional) – Libatkan lansia dalam pengambilan keputusan	Lansia mampu mempertahankan hubungan sosial, menunjukkan keterlibatan dalam komunikasi, dan meningkatkan kepuasan interaksi

3. Asuhan Keperawatan Komunikasi pada Klien dengan Gangguan Jiwa

a. Pendahuluan

Dalam praktik modern, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pertukaran informasi, tetapi merupakan komponen inti dalam proses terapeutik yang memengaruhi *therapeutic alliance*, kepatuhan terapi, dan *outcome* klinis (Huang et al., 2021).

Namun, komunikasi pada kondisi gangguan jiwa sering menghadapi hambatan seperti stigma, kondisi emosional pasien, serta faktor individu dan sistem pelayanan yang memengaruhi efektivitas interaksi (Milton, Mullan, MacCann, & Hunt, 2018). Komunikasi pada klien dengan gangguan jiwa memiliki kompleksitas tinggi karena adanya gangguan pada proses pikir, emosi, dan persepsi, seperti halusinasi, waham, dan disorganisasi pikir yang secara langsung memengaruhi kemampuan komunikasi (Ali & Viqar, 2024; Hodgins et al., 2022).

Komunikasi pada klien gangguan jiwa tidak hanya menghadapi hambatan kognitif dan emosional, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti stigma, struktur layanan kesehatan, serta kesiapan tenaga kesehatan dalam menyampaikan informasi sensitif. Hambatan ini dapat menimbulkan kesalahpahaman, distress, serta penurunan keterlibatan pasien dalam terapi (Hodgins et al., 2022; Kramer et al., 1998). Oleh karena itu, pendekatan komunikasi harus bersifat individual, empatik, dan berorientasi pada pasien (*patient-centered*).

Komunikasi terapeutik merupakan inti hubungan perawat–pasien dan berfungsi tidak hanya sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai intervensi untuk membantu klien memahami pengalaman dirinya dan meningkatkan adaptasi psikologis. Hubungan terapeutik yang efektif terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kualitas perawatan dan outcome pasien (Huang et al., 2021).

Prinsip utama komunikasi adalah membangun *trust*, dengan pendekatan konsisten, jujur, dan *non-judgmental*. Komunikasi yang efektif juga berperan dalam meningkatkan kepatuhan terapi, stabilisasi kondisi mental, dan pencegahan kekambuhan (Sharkiya, 2023). Selain itu, komunikasi terapeutik memiliki dampak langsung terhadap kualitas layanan, kepuasan pasien, serta keberhasilan terapi. Studi menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dapat meningkatkan keterlibatan pasien,

memperkuat hubungan terapeutik, dan memperbaiki *outcome* kesehatan mental secara signifikan (Mersha et al., 2023).

b. Landasan Teori

Komunikasi terapeutik dalam keperawatan jiwa berakar pada Teori Hubungan Interpersonal Peplau, yang memandang keperawatan sebagai proses interpersonal terapeutik antara perawat dan pasien. Dalam teori ini, hubungan terapeutik menjadi inti dari proses penyembuhan dan harus melalui fase orientasi, kerja, dan terminasi (Hagerty, Samuels, & Gigliotti, 2018). Peplau menekankan bahwa hubungan perawat-pasien harus berfokus pada pengalaman subjektif pasien, kebutuhan psikologis, serta pembentukan rasa aman dan kepercayaan sebagai dasar komunikasi efektif (Weber, Lopes, Pereira, & Toledo, 2025).

Dalam perkembangan modern, konsep ini diperluas melalui pendekatan *patient-centered communication*, yang menempatkan pasien sebagai mitra aktif dalam proses terapi. Pendekatan ini terbukti meningkatkan *therapeutic alliance*, kepatuhan terapi, serta hasil kesehatan mental secara keseluruhan (Niu et al., 2025). Komunikasi pada klien gangguan jiwa juga bersifat dinamis dan individual, serta harus disesuaikan dengan kondisi psikopatologi klien (Caris-Verhallen et al., 1997).

Selain itu, komunikasi pada gangguan jiwa harus mempertimbangkan: pengalaman subjektif pasien, faktor trauma dan *distress* emosional, konteks sosial dan budaya pasien. Pendekatan ini sejalan dengan praktik komunikasi berbasis empati dan hubungan terapeutik yang kuat (Bond, 2024).

Secara teoritis komunikasi trapeutik dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Komunikasi terapeutik mencakup *active listening*, refleksi, klarifikasi, dan fokus sebagai teknik utama
- 2) Hubungan terapeutik dibangun melalui empati, kepercayaan, dan konsistensi
- 3) Komunikasi harus mempertimbangkan gangguan proses pikir, persepsi, dan afek

Selain itu, evidence terbaru menunjukkan bahwa kombinasi komunikasi verbal dan nonverbal (kontak mata, ekspresi wajah, *gesture*) berperan penting dalam membangun hubungan terapeutik dan meningkatkan keterlibatan klien (Caris-Verhallen, Kerkstra, et al., 1999).

c. Pengkajian komunikasi pada gangguan jiwa

Pengkajian komunikasi pada klien gangguan jiwa memerlukan pendekatan multimodal karena keterbatasan komunikasi sering kali tidak hanya bersifat verbal. Individu dengan gangguan komunikasi kompleks dapat mengalami kesulitan dalam mengekspresikan kebutuhan, sehingga diperlukan penggunaan berbagai sumber data seperti observasi perilaku, laporan keluarga, serta alat bantu komunikasi (Pennacchia et al., 2025). Selain itu, gangguan kognitif dan bahasa pada klien dapat menyebabkan keterbatasan dalam memahami pertanyaan atau menyampaikan respons secara akurat, sehingga perawat perlu menyesuaikan metode pengkajian dengan kemampuan komunikasi pasien (Daly, 2017; Dodd, 1978; White & Verduco, 2018).

Dalam konteks keperawatan, komunikasi tidak hanya menjadi alat pengumpulan data, tetapi juga merupakan bagian dari intervensi terapeutik itu sendiri. Oleh karena itu, pengkajian komunikasi harus dilakukan secara berkelanjutan selama interaksi, bukan hanya pada tahap awal.

1) Pengkajian Proses Pikir (Thought Process)

Proses pikir merupakan komponen utama yang memengaruhi komunikasi pada klien gangguan jiwa. Gangguan pada proses pikir dapat menyebabkan komunikasi menjadi tidak terarah, tidak logis, atau sulit dipahami.

Aspek yang dikaji meliputi; **koherensi pembicaraan** (apakah alur pikir teratur atau tidak), **asosiasi ide** (apakah terdapat loncatan ide/tidak nyambung), **kecepatan bicara** (lambat, cepat, atau tidak terkontrol). Beberapa bentuk gangguan yang sering ditemukan; *flight of ideas* (loncatan ide cepat), *loosening of association* (hubungan antar ide longgar), *tangentiality* (jawaban tidak langsung pada inti pertanyaan)(Mundakir, 2006; Sheldon, 2010).

Gangguan ini menyebabkan pesan sulit dipahami, sehingga perawat harus melakukan klarifikasi secara berulang.

2) Pengkajian Persepsi (Perception)

Gangguan persepsi merupakan salah satu karakteristik utama pada klien dengan gangguan jiwa, terutama pada kondisi seperti skizofrenia. Aspek yang dikaji meliputi: adanya **halusinasi** (pendengaran, penglihatan, dll.), distorsi terhadap realitas, respon klien terhadap stimulus internal. Halusinasi, khususnya halusinasi auditorik, dapat mengganggu komunikasi karena klien lebih fokus

pada stimulus internal dibandingkan interaksi dengan lingkungan nyata. Hal ini menyebabkan; respon tidak sesuai konteks, berbicara sendiri, kesulitan mempertahankan percakapan. Pengkajian harus dilakukan tanpa konfrontasi langsung, tetapi dengan pendekatan eksploratif dan empatik.

3) Pengkajian Isi Pikir (Thought Content)

Isi pikir berkaitan dengan apa yang dipikirkan klien dan bagaimana hal tersebut memengaruhi komunikasi. Aspek yang dikaji; adanya **waham (*delusion*)**, keyakinan yang tidak sesuai realitas, ide-ide yang dominan. Waham dapat menyebabkan komunikasi menjadi tidak realistis dan sulit dikoreksi. Misalnya, klien dengan waham kebesaran akan berbicara dengan isi yang tidak sesuai kenyataan.

Perawat tidak dianjurkan untuk langsung menyangkal isi waham, tetapi perlu memahami makna subjektif bagi klien dan mengarahkan komunikasi secara bertahap ke realitas

4) Pengkajian Afek dan Emosi

Emosi sangat memengaruhi cara klien berkomunikasi. Gangguan pada afek dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara isi pesan dan ekspresi emosional. Aspek yang dikaji; jenis afek (datar, tumpul, labil), kesesuaian antara emosi dan situasi, respons emosional terhadap komunikasi. Contoh: klien tertawa saat membahas hal sedih, ekspresi datar tanpa respon emosional. Kondisi ini dapat menyebabkan komunikasi menjadi tidak sinkron dan sulit dipahami.

5) Pengkajian Kemampuan Verbal dan Nonverbal

Pengkajian komunikasi juga mencakup kemampuan ekspresi bahasa. Aspek yang dikaji; kemampuan berbicara (jelas/tidak), penggunaan Bahasa, kontak mata dan gestur dan bahasa tubuh.

Pada klien gangguan jiwa, sering ditemukan, komunikasi verbal berlebihan atau minimal, kontak mata buruk, perilaku nonverbal yang tidak sesuai. Komunikasi nonverbal menjadi indikator penting untuk memahami kondisi internal klien .

6) Pengkajian Interaksi Sosial

Gangguan komunikasi pada klien gangguan jiwa sering disertai gangguan dalam interaksi sosial. Aspek yang dikaji; kemampuan membangun hubungan, respons terhadap orang lain, tingkat isolasi sosial. Klien mungkin menarik diri, tidak responsive, atau menunjukkan perilaku agresif. Pengkajian ini penting karena komunikasi sangat bergantung pada kemampuan interaksi sosial.

7) Pengkajian Insight dan Kemampuan Realitas

Insight adalah kemampuan klien untuk menyadari kondisi dirinya. Aspek yang dikaji; kesadaran terhadap penyakit, kemampuan membedakan realitas dan non-realitas, penerimaan terhadap kondisi. Klien dengan *insight* rendah cenderung menolak komunikasi, tidak kooperatif, sulit menerima edukasi.

8) Pengkajian Hambatan Komunikasi Spesifik

Perawat perlu mengidentifikasi hambatan komunikasi yang khas pada gangguan jiwa, seperti: disorganisasi piker, halusinasi dominan, gangguan emosi, kurangnya motivasi berinteraksi. Hambatan ini sering terjadi secara bersamaan dan saling memengaruhi.

Pengkajian komunikasi pada klien gangguan jiwa merupakan proses kompleks karena komunikasi sering terganggu oleh kondisi psikopatologis. Selain aspek diatas, *evidence* menunjukkan bahwa:

- a) Individu dengan gangguan komunikasi kompleks sering mengalami keterbatasan dalam mengekspresikan kebutuhan, sehingga memerlukan pendekatan multi-sumber (observasi, keluarga, alat bantu komunikasi (Pennacchia et al., 2025).
- b) Hambatan komunikasi juga dapat berasal dari keterbatasan kognitif dan bahasa, terutama pada kondisi disabilitas atau gangguan berat (Kupara & Woodward, 2023).

Pengkajian sebaiknya tidak hanya verbal, tetapi juga mencakup; interpretasi perilaku nonverbal, penggunaan sumber data tambahan, evaluasi akses komunikasi pasien.

d. Diagnosis Keperawatan komunikasi pasien gangguan jiwa

Gangguan komunikasi pada klien gangguan jiwa sering berkaitan dengan: distorsi realitas (halusinasi, waham), disorganisasi kognitif, hambatan emosional. Kondisi ini menyebabkan komunikasi menjadi tidak efektif dan memerlukan pendekatan terapeutik khusus, bukan sekadar perbaikan bahasa (Papageorgiou, Loke, & Fromage, 2017) .

Gangguan komunikasi pada klien gangguan jiwa tidak hanya mencerminkan keterbatasan bahasa, tetapi merupakan manifestasi langsung dari gangguan psikopatologi, seperti distorsi realitas dan disorganisasi kognitif, sehingga memerlukan pendekatan diagnosis yang integratif (Escalada-Hermández & Marín-Fernández, 2018).

Diagnosis keperawatan pada klien dengan gangguan jiwa difokuskan pada gangguan dalam proses komunikasi yang berkaitan dengan distorsi

persepsi, gangguan proses pikir, perubahan emosi, serta gangguan interaksi sosial. Berbeda dengan kelompok lain, diagnosis pada klien gangguan jiwa sering mencerminkan gangguan pada **struktur dan isi komunikasi**, bukan hanya kemampuan berbicara (Frauenfelder, Achterberg, Needham, & Staub, 2014).

Beberapa diagnosis yang sering muncul antara lain:

1) Gangguan komunikasi verbal.

Berhubungan dengan disorganisasi proses pikir, gangguan persepsi (halusinasi), atau gangguan kognitif, ditandai dengan pembicaraan tidak koheren, sulit dipahami, atau tidak sesuai konteks (Frauenfelder et al., 2014; Sánchez-Almagro et al., 2022).

2) Gangguan proses pikir

Berhubungan dengan gangguan neurologis atau psikologis, ditandai dengan *flight of ideas*, *loosening of association*, atau *tangentiality* yang mengganggu alur komunikasi (Escalada-Hermández & Marín-Fernández, 2018).

3) Gangguan persepsi sensori (halusinasi)

Berhubungan dengan gangguan neuropsikiatri, ditandai dengan respon terhadap stimulus internal yang mengganggu komunikasi dengan lingkungan nyata (Escalada-Hermández & Marín-Fernández, 2018).

4) Isolasi sosial / gangguan interaksi sosial

Berhubungan dengan ketidakmampuan membangun hubungan interpersonal, ditandai dengan menarik diri, kurang responsif, atau perilaku defensif (Gonçalves, Sequeira, & e Silva, 2019).

5) Ansietas / distress emosional

Berhubungan dengan kondisi psikologis, ditandai dengan ketegangan, ketakutan, atau perilaku tidak terkontrol yang mengganggu komunikasi (Gonçalves et al., 2019; Sánchez-Almagro et al., 2022).

Diagnosis harus dirumuskan berdasarkan analisis integratif antara proses pikir, persepsi, dan respons emosional klien, karena ketiga aspek tersebut saling memengaruhi dalam komunikasi (Gonçalves et al., 2019).

e. Intervensi Keperawatan komunikasi pasien gangguan jiwa

Intervensi komunikasi pada klien dengan gangguan jiwa bertujuan untuk meningkatkan orientasi realitas, memperbaiki kemampuan komunikasi, serta membangun hubungan terapeutik yang aman dan

suportif. Pendekatan yang digunakan harus bersifat sistematis, empatik, dan disesuaikan dengan kondisi psikopatologi pasien.

1) Membangun hubungan terapeutik (trust building)

Hubungan terapeutik merupakan dasar utama dalam keperawatan jiwa, karena membangun rasa aman, kepercayaan, dan keterlibatan pasien dalam terapi (Mersha et al., 2023). Kepercayaan yang terbentuk juga berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan dan outcome pasien dalam pendekatan *patient-centered care* (Niu et al., 2025).

Dalam komunikasi ini, perawat perlu; menunjukkan sikap konsisten, jujur, dan dapat dipercaya, menggunakan pendekatan non-judgmental, menjaga batas profesional (Furnes, Kvaal, & Høye, 2018; Kourkouta & Papathanasiou, 2014).

2) Penerapan komunikasi terapeutik (active listening, refleksi, klarifikasi)

Komunikasi terapeutik merupakan inti intervensi dalam keperawatan jiwa. Teknik seperti *active listening*, refleksi, dan klarifikasi memungkinkan perawat memahami pengalaman subjektif pasien serta membantu pasien mengekspresikan emosi dan pikirannya secara lebih adaptif (Bond, 2024).

Efektivitas komunikasi terapeutik terbukti berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup, kepuasan pasien, serta outcome klinis (Sharkiya, 2023). Selain itu, komunikasi terapeutik juga berperan dalam proses penyembuhan dengan meningkatkan pemahaman pasien terhadap kondisi dirinya (Shahi & Sharma, 2024).

3) Mengatasi hambatan komunikasi (stigma & distress emosional)

Hambatan komunikasi pada klien gangguan jiwa sering dipengaruhi oleh stigma dan distress emosional. Oleh karena itu, perawat perlu mengidentifikasi respon emosional pasien serta menggunakan komunikasi empatik yang disertai *follow-up* secara konsisten untuk menjaga kesinambungan hubungan terapeutik (Milton et al., 2018).

4) Manajemen halusinasi (reality orientation)

Pada pasien dengan halusinasi, komunikasi difokuskan pada orientasi realitas secara bertahap. Perawat tidak dianjurkan untuk menguatkan maupun menyangkal secara konfrontatif, tetapi menggunakan pendekatan suportif untuk membantu pasien membedakan stimulus internal dan eksternal.

5) Adaptasi komunikasi (kognitif & bahasa)

Intervensi komunikasi harus disesuaikan dengan kemampuan kognitif dan bahasa pasien. Perawat dapat menggunakan bahasa sederhana, memberikan instruksi secara bertahap, serta memanfaatkan alat bantu komunikasi bila diperlukan. Keterlibatan keluarga juga penting sebagai sumber informasi dan dukungan dalam proses komunikasi (Pennacchia et al., 2025).

6) Pelatihan dan peningkatan keterampilan komunikasi perawat

Pelatihan komunikasi bagi tenaga kesehatan terbukti meningkatkan kepuasan pasien serta kualitas hubungan terapeutik (Papageorgiou et al., 2017). Selain itu, peningkatan kompetensi komunikasi juga berkontribusi terhadap efektivitas intervensi keperawatan secara keseluruhan.

7) Pendekatan inovatif (digital & teknologi)

Pemanfaatan teknologi seperti *telehealth* dan aplikasi kesehatan mental dapat meningkatkan akses komunikasi antara pasien dan tenaga kesehatan. Namun, penggunaannya harus mempertimbangkan aspek etika, keamanan, dan kualitas interaksi terapeutik (Löchner, Carlbring, Schuller, Torous, & Sander, 2025)

8) Teknik khusus (mirroring & refleksi lanjutan)

Teknik *mirroring* merupakan salah satu pendekatan yang dapat meningkatkan empati dan pemahaman terhadap pengalaman pasien. Intervensi ini terbukti efektif dalam meningkatkan kompetensi komunikasi terapeutik, terutama dalam membangun hubungan interpersonal yang lebih mendalam (S. H. Lee & Yoo, 2024)

9) Outcome komunikasi

Komunikasi yang efektif berkontribusi terhadap peningkatan kepuasan pasien, kualitas layanan kesehatan, serta keberhasilan terapi secara keseluruhan (Safitri, Nursalam, & Nihayati, 2024).

f. Evaluasi

Evaluasi harus dilakukan secara kontinu karena kondisi klien gangguan jiwa bersifat fluktuatif dan dapat berubah sewaktu-waktu. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas komunikasi serta perubahan kondisi psikologis dan perilaku klien. Dalam keperawatan jiwa, evaluasi tidak hanya berfokus pada kemampuan komunikasi, tetapi juga pada dampaknya terhadap hubungan terapeutik, keterlibatan pasien, dan *outcome* klinis secara keseluruhan.

Efektivitas komunikasi terbukti berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup, kepuasan pasien, serta outcome klinis (Sharkiya, 2023). Selain itu, pendekatan *patient-centered communication* berkontribusi signifikan terhadap peningkatan *therapeutic alliance*, kepatuhan terapi, kepuasan pasien, serta outcome kesehatan mental (Niu et al., 2025).

1) Indikator Evaluasi

Evaluasi komunikasi pada klien gangguan jiwa dapat dilakukan melalui beberapa indikator berikut:

a) Peningkatan koherensi komunikasi

Menunjukkan perbaikan pada proses kognitif dan kemampuan menyampaikan pesan secara logis, diantaranya; alur pikir lebih terarah dan berkurangnya disorganisasi pikir.

b) Penurunan gangguan persepsi

Menggambarkan kemampuan klien dalam membedakan stimulus internal dan eksternal, diantaranya; berkurangnya respons terhadap halusinasi, meningkatnya orientasi realitas.

c) Peningkatan kemampuan interaksi

Menunjukkan peningkatan fungsi sosial dan keterlibatan interpersonal, diantaranya; klien lebih responsif dalam komunikasi, meningkatnya partisipasi dalam percakapan atau aktivitas sosial.

d) Stabilitas emosi

Mengindikasikan regulasi emosi yang lebih adaptif, diantaranya; berkurangnya kecemasan, agitasi, atau perilaku impulsif, dan respons emosional lebih sesuai dengan situasi.

e) Terbentuknya hubungan terapeutik

Menjadi indikator utama keberhasilan komunikasi terapeutik, diantaranya; klien menunjukkan kepercayaan kepada perawat, dan meningkatnya kerja sama dalam proses perawatan (Niu et al., 2025).

2) Makna Klinis Evaluasi

Peningkatan pada indikator-indikator tersebut mencerminkan keberhasilan komunikasi dalam membangun hubungan terapeutik yang efektif. Hal ini berdampak pada peningkatan keterlibatan pasien dalam terapi, penurunan risiko putus terapi (*dropout*), serta percepatan perbaikan gejala pada berbagai gangguan mental.

3) Prinsip Evaluasi

Evaluasi harus dilakukan secara kontinu dan dinamis, karena kondisi klien gangguan jiwa bersifat fluktuatif dan dapat berubah

sewaktu-waktu. Oleh karena itu, perawat perlu melakukan penilaian berulang dan menyesuaikan strategi komunikasi sesuai dengan perkembangan kondisi pasien.

Selain itu, evaluasi komunikasi harus mempertimbangkan secara integrative, yaitu bagaimana kualitas hubungan terapeutik, tingkat keterlibatan pasien dan perubahan kondisi psikologis dan perilaku. Pendekatan ini memastikan bahwa komunikasi tidak hanya dinilai sebagai keterampilan, tetapi sebagai intervensi terapeutik yang memiliki dampak klinis nyata.

4. Asuhan keperawatan Komunikasi pada Klien dengan Disabilitas

a. Landasan teori

Komunikasi pada klien dengan disabilitas menuntut pendekatan yang fleksibel dan individual, karena setiap jenis disabilitas memiliki karakteristik yang berbeda. Disabilitas dapat bersifat fisik, sensorik (pendengaran/penglihatan), intelektual, atau kombinasi dari beberapa kondisi (Sheldon, 2010).

Dalam konteks pelayanan kesehatan, komunikasi menjadi faktor krusial dalam menjamin kualitas asuhan. Namun, berbagai studi menunjukkan masih adanya kesenjangan komunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien dengan disabilitas, terutama akibat kurangnya pelatihan, keterbatasan sistem, serta kurangnya akses terhadap alat bantu komunikasi (Moussa, Alzahrani, Elshemy, & Fawzy, 2025).

Disabilitas dapat memengaruhi tiga tahap utama komunikasi, yaitu persepsi, pemrosesan, dan ekspresi. Ketiga tahap ini saling berhubungan dan menentukan keberhasilan interaksi. Gangguan pada salah satu tahap dapat menyebabkan hambatan komunikasi yang signifikan, bahkan berdampak pada keselamatan pasien dan kualitas pelayanan (Dunsmore, Watharow, & Schneider, 2025).

Pada klien dengan gangguan pendengaran, komunikasi verbal sering tidak efektif tanpa dukungan visual. Hambatan ini dapat menyebabkan kesalahpahaman informasi kesehatan dan berdampak pada outcome klinis (Garcia, Arabi, Croteau, & de Lacerda, 2025). Oleh karena itu, diperlukan penggunaan strategi seperti bahasa isyarat, tulisan, atau dukungan teknologi komunikasi. Pada klien dengan gangguan penglihatan, komunikasi verbal harus lebih deskriptif, sistematis, dan dilengkapi dengan orientasi lingkungan serta penggunaan sentuhan sebagai bentuk komunikasi tambahan (Alves, Maia, & Pagliuca, 2020).

Pada klien dengan disabilitas intelektual, keterbatasan komunikasi sering terjadi pada aspek pemahaman dan ekspresi, sehingga informasi harus disampaikan secara sederhana, berulang, dan menggunakan pendekatan konkret. Hambatan komunikasi pada kelompok ini juga sering berkaitan dengan kesulitan dalam memastikan pemahaman selama interaksi klinis (Bruun & Tuffrey-Wijne, 2025).

Selain aspek teknis, komunikasi juga dipengaruhi oleh faktor psikososial. Individu dengan disabilitas sering mengalami stigma dan stereotip negatif dalam pelayanan kesehatan, yang dapat menurunkan kepercayaan diri dan keterlibatan dalam komunikasi (Heydarian, Morera, & Frankowski, 2020).

Lingkungan komunikasi juga berperan penting. Lingkungan yang tidak aksesibel, seperti adanya kebisingan, kurangnya alat bantu, atau tidak tersedianya interpreter, dapat memperburuk hambatan komunikasi (Ruesch, 2018).

Secara keseluruhan, komunikasi pada klien dengan disabilitas menuntut kompetensi perawat dalam melakukan adaptasi, menggunakan berbagai strategi komunikasi, serta membangun hubungan yang inklusif dan berpusat pada pasien.

b. Pengkajian Komunikasi pada Klien dengan Disabilitas

Pengkajian komunikasi pada klien dengan disabilitas merupakan proses kompleks yang bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan komunikasi yang masih dimiliki, hambatan yang dialami, serta kebutuhan komunikasi spesifik individu. Disabilitas tidak selalu berarti ketidakmampuan total, tetapi sering kali berupa keterbatasan pada salah satu atau beberapa tahap komunikasi, yaitu persepsi, pemrosesan, dan ekspresi (Sheldon, 2010).

Pendekatan pengkajian harus berorientasi pada **ability-based**, yaitu menilai kemampuan yang masih dapat dimanfaatkan sebagai dasar intervensi. Hal ini penting karena individu dengan gangguan komunikasi berat tetap memiliki potensi komunikasi melalui cara alternatif yang perlu diidentifikasi secara sistematis (Hemsley et al., 2001).

Selain itu, pengkajian komunikasi harus bersifat komprehensif, mencakup aspek verbal, nonverbal, kognitif, serta faktor lingkungan dan sosial, karena hambatan komunikasi pada disabilitas bersifat multidimensional (Khanlou et al., 2023). Pengkajian juga perlu mengidentifikasi apakah klien membutuhkan sistem AAC, terutama pada

individu dengan kemampuan verbal terbatas atau tidak berkembang optimal (Riswari, Ediyanto, Efendi, & Sunandar, 2022).

1) Pengkajian Tahap Persepsi (Input Komunikasi)

Tahap persepsi berkaitan dengan kemampuan klien menerima informasi melalui sistem sensorik. **Aspek yang dikaji diantaranya;** kemampuan pendengaran, kemampuan penglihatan, dan kemampuan mengenali simbol atau bahasa.

Gangguan pada tahap ini dapat menyebabkan kegagalan dalam menerima informasi, yang sering disalahartikan sebagai ketidakmampuan komunikasi. Pada klien dengan gangguan pendengaran, keterbatasan dalam memahami pesan verbal sering menyebabkan miskomunikasi dan menurunkan kualitas pelayanan kesehatan (Garcia et al., 2025). Pada klien dengan gangguan penglihatan, kurangnya deskripsi verbal dan orientasi lingkungan dapat menghambat pemahaman pasien terhadap situasi perawatan (Alves et al., 2020).

2) Pengkajian Tahap Pemrosesan (Processing)

Tahap pemrosesan melibatkan kemampuan kognitif dalam memahami dan menginterpretasikan informasi. **Aspek yang dikaji, diantaranya;** kemampuan memahami instruksi, kemampuan berpikir konkret atau abstrak, kecepatan pemrosesan informasi.

Pada klien dengan disabilitas intelektual, sering ditemukan kesulitan dalam memahami informasi kompleks, sehingga komunikasi harus disesuaikan dengan kapasitas kognitif pasien. Selain itu, keterbatasan dalam memastikan pemahaman menjadi tantangan utama dalam komunikasi klinis, sehingga diperlukan strategi verifikasi seperti pengulangan atau klarifikasi (Bruun & Tuffrey-Wijne, 2025).

Dalam konteks AAC, pengkajian harus mencakup kemampuan klien dalam memahami simbol, gambar, atau sistem representasi yang digunakan dalam komunikasi alternatif. Hal ini penting karena keberhasilan AAC sangat bergantung pada kemampuan pemrosesan simbolik individu (Riswari et al., 2022).

3) Pengkajian Tahap Ekspresi (Output Komunikasi)

Tahap ekspresi berkaitan dengan kemampuan klien menyampaikan pesan. **Aspek yang dikaji diantaranya;** kemampuan berbicara, penggunaan bahasa alternatif (AAC, simbol, tulisan), kemampuan mengekspresikan kebutuhan.

Pada klien dengan gangguan komunikasi berat, ekspresi sering dilakukan melalui metode nonkonvensional, sehingga perawat perlu mengenali dan memfasilitasi penggunaan *augmentative and alternative communication* (AAC), yaitu sistem komunikasi non-verbal yang mencakup metode tanpa alat (gestur, bahasa isyarat) maupun dengan alat seperti gambar, papan komunikasi, atau perangkat berbasis teknologi (Riswari et al., 2022). Kegagalan dalam mengidentifikasi kemampuan ekspresi ini dapat menyebabkan kebutuhan pasien tidak terpenuhi dan meningkatkan risiko *distress*.

AAC telah digunakan secara luas sebagai intervensi berbasis evidence untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, interaksi sosial, dan partisipasi individu dengan keterbatasan komunikasi verbal (Riswari et al., 2022).

4) Pengkajian Komunikasi Nonverbal

Komunikasi nonverbal menjadi aspek penting, terutama pada klien dengan keterbatasan verbal. **Aspek yang dikaji, diantaranya;** kontak mata, ekspresi wajah, gestur.

Pada pasien dengan gangguan penglihatan, penggunaan komunikasi nonverbal harus disesuaikan, karena tidak semua bentuk nonverbal dapat diinterpretasikan secara visual. Sebaliknya, sentuhan dan posisi tubuh menjadi lebih bermakna (Rebouças, Pagliuca, & Almeida, 2007).

5) Pengkajian Faktor Psikososial

Disabilitas sering dikaitkan dengan stigma, diskriminasi, dan pengalaman negatif dalam pelayanan kesehatan. **Aspek yang dikaji, diantaranya;** kepercayaan diri, pengalaman komunikasi sebelumnya, respons emosional. Stigma dan persepsi negatif dari tenaga kesehatan dapat menurunkan kepuasan dan keterlibatan pasien dalam komunikasi (Heydarian et al., 2020).

6) Pengkajian Lingkungan dan Aksesibilitas Komunikasi

Lingkungan memiliki peran penting dalam efektivitas komunikasi. **Aspek yang dikaji, diantaranya;** ketersediaan alat bantu komunikasi/AAC, dukungan keluarga, akses terhadap interpreter atau teknologi. Kurangnya dukungan lingkungan, termasuk tidak tersedianya interpreter atau alat bantu komunikasi, menjadi hambatan utama dalam pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas (Moussa et al., 2025).

Penggunaan AAC memerlukan dukungan lingkungan yang konsisten, termasuk keterlibatan keluarga dan tenaga kesehatan dalam penggunaan sistem komunikasi tersebut secara **berkelanjutan** (Riswari et al., 2022).

c. Diagnosa–Intervensi–Evaluasi Komunikasi pada Disabilitas (dengan integrasi AAC)

Tabel 2.4: Asuhan Keperawatan Komunikasi pada Lansia

Diagnosa Keperawatan	Intervensi Keperawatan	Evaluasi
Gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan keterbatasan fungsi sensorik atau motorik	– Kaji kemampuan komunikasi verbal dan nonverbal – Identifikasi kebutuhan penggunaan AAC – Gunakan media komunikasi alternatif (gambar, tulisan, papan komunikasi) – Kombinasikan komunikasi verbal dan nonverbal – Libatkan keluarga dalam proses komunikasi	Klien mampu menyampaikan kebutuhan dasar melalui metode komunikasi yang sesuai (verbal/nonverbal/AAC)
Gangguan komunikasi berhubungan dengan keterbatasan kognitif atau pemrosesan informasi	– Gunakan bahasa sederhana dan instruksi singkat – Gunakan simbol visual atau alat AAC berbasis gambar – Ulangi dan klarifikasi informasi – Gunakan teknik teach-back untuk	Klien mampu memahami informasi sederhana dan menunjukkan respon yang sesuai

Diagnosa Keperawatan	Intervensi Keperawatan	Evaluasi
	verifikasi pemahaman	
Hambatan komunikasi berhubungan dengan keterbatasan ekspresi (expressive impairment)	– Identifikasi metode ekspresi yang masih dimiliki (gestur, simbol, suara) – Fasilitasi penggunaan AAC (PECS, papan komunikasi, perangkat digital) – Berikan waktu cukup untuk respon – Hindari interupsi saat klien berusaha berkomunikasi	Klien mampu mengekspresikan kebutuhan, keinginan, atau respon melalui metode yang tersedia
Gangguan interaksi sosial berhubungan dengan keterbatasan komunikasi	– Fasilitasi interaksi komunikasi secara bertahap – Gunakan pendekatan komunikasi suportif dan empatik – Latih penggunaan AAC dalam konteks sosial – Libatkan keluarga/<i>caregiver</i> sebagai mediator komunikasi	Klien menunjukkan peningkatan partisipasi dalam interaksi sosial
Risiko ketidakpahaman informasi berhubungan dengan hambatan komunikasi	– Verifikasi pemahaman menggunakan <i>teach-back</i>	Klien mampu memahami informasi yang diberikan dan menunjukkan respon yang tepat

Diagnosa Keperawatan	Intervensi Keperawatan	Evaluasi
	– Gunakan media visual atau demonstrasi – Sesuaikan metode komunikasi dengan kemampuan klien – Ulangi informasi secara konsisten	
Hambatan komunikasi berhubungan dengan faktor lingkungan dan sistem	– Modifikasi lingkungan (minim distraksi, pencahayaan baik) – Sediakan alat bantu komunikasi (AAC tools) – Gunakan interpreter atau caregiver jika diperlukan – Pastikan aksesibilitas komunikasi	Lingkungan komunikasi mendukung dan klien mampu berpartisipasi dalam komunikasi secara optimal

D. Asesmen

1. Asesmen CPMK 5 (Utama)

Simulasi Komunikasi pada Populasi Khusus (*High-Risk Scenario*)

a. Desain Kegiatan

Mahasiswa melakukan simulasi komunikasi pada situasi sulit, misalnya:

- anak dengan kecemasan tinggi
- lansia dengan gangguan pendengaran
- pasien gangguan jiwa dengan agitasi
- pasien disabilitas dengan hambatan komunikasi

b. Durasi: 10–15 menit

c. Output: video/rekaman

d. Instrumen: RUBRIK PENILAIAN (CPMK 5)

Aspek	Skor 1 (Tidak adekuat)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
De-eskalasi	Tidak mampu meredakan situasi	Ada upaya, tidak efektif	Efektif sebagian	Sangat efektif, situasi terkendali
Validasi pesan	Tidak memvalidasi	Validasi tidak tepat	Validasi cukup tepat	Validasi tepat, empatik
Keselamatan komunikasi	Berisiko (misleading)	Ada potensi risiko	Aman sebagian	Aman, jelas, tanpa risiko
Adaptasi komunikasi	Tidak sesuai kondisi pasien	Kurang sesuai	Cukup sesuai	Sangat sesuai (individualized)

Skor akhir = rata-rata x 25

- e. Indikator Inti
 - Ketepatan de-eskalasi
 - Validasi pesan
 - Keselamatan komunikasi
- f. Bukti
 - Video simulasi
 - Lembar penilaian rubrik
- g. Bobot penilaian: 15%

2. Asesmen CPMK 3 (Pendukung)

OSCE Komunikasi Terapeutik (Fase Hubungan)

- a. Desain Kegiatan
OSCE station:
 - fase orientasi
 - fase kerja
 - fase terminasi
 Kasus: pasien anak/lansia/gangguan jiwa
- b. Instrumen: CHECKLIST OSCE

Komponen	Ya (1)	Tidak (0)
Memperkenalkan diri dengan tepat		
Menjelaskan tujuan interaksi		
Menjaga batas profesional		
Menggunakan teknik empatik		
Active listening		
Tidak ada kesalahan kritis		

c. Kriteria Khusus

Harus 0 kesalahan kritis, seperti:

- menghakimi pasien
- memberikan informasi salah
- melanggar batas profesional

d. Skoring

- Total skor / jumlah item × 100
- Lulus minimal: 80%

e. Indikator Inti

- Fase hubungan terapeutik
- Respons empatik
- Profesionalisme

f. Bukti

- Checklist OSCE
- Rekaman simulasi

g. Bobot penilaian: 15%

3. ASESMEN CPMK 6 (PENDUKUNG)

Simulasi Komunikasi Interprofesional & Eskalasi

a. Desain Kegiatan

Simulasi:

- komunikasi SBAR
- eskalasi kondisi pasien berisiko
- kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain

b. Instrumen: CHECKLIST SBAR & ESKALASI

Komponen	Ya (1)	Tidak (0)
Situation jelas		
Background relevan		
Assessment tepat		
Recommendation jelas		
Komunikasi terstruktur		
Eskalasi tepat waktu		
Kolaborasi efektif		

c. Indikator Inti

- Kejelasan pesan klinis
- Kolaborasi
- Ketepatan eskalasi

d. Skoring

- Total skor / jumlah item × 100
- Minimal kompeten: 75%

e. Bukti

- Checklist
- Catatan simulasi
- Rekaman

f. Bobot: 15%

E. Redflag

Tabel Red Flag Komunikasi pada Populasi Khusus

Populasi	Red Flag Komunikasi	Implikasi Klinis
Anak	- Anak tidak merespons atau sangat pasif - Menangis berlebihan / tantrum saat interaksi - Menghindari kontak mata / menarik diri - Orang tua mendominasi komunikasi sepenuhnya	Risiko miskomunikasi kebutuhan, kecemasan meningkat, pengkajian tidak akurat
Lansia	- Sering mengatakan “tidak paham” atau salah mengulang informasi - Tampak tidak fokus / lambat merespons - Mengangguk tanpa benar-benar memahami - Tidak menggunakan alat bantu (kacamata/alat dengar)	Risiko kesalahan instruksi, ketidakpatuhan terapi, penurunan keselamatan pasien
Gangguan Jiwa	- Bicara tidak terarah / tidak koheren - Halusinasi / waham memengaruhi komunikasi - Menarik diri atau sangat defensif - Respons emosional tidak sesuai konteks	Risiko miskomunikasi berat, potensi agitasi/agresivitas, gangguan hubungan terapeutik
Disabilitas	- Tidak memahami pesan meski sudah diulang - Tidak mampu mengekspresikan kebutuhan - Tidak tersedia alat bantu komunikasi - Mengandalkan penerjemah tidak terlatih (keluarga)	Risiko kesalahan diagnosis/terapi, kebutuhan tidak terpenuhi, distorsi informasi klinis

Red flag komunikasi merupakan tanda peringatan dini adanya hambatan komunikasi yang dapat berdampak pada keselamatan pasien. Identifikasi *red flag* secara cepat memungkinkan perawat melakukan penyesuaian strategi komunikasi, seperti penyederhanaan bahasa, penggunaan media bantu, atau melibatkan *caregiver* secara tepat, sehingga risiko miskomunikasi dapat diminimalkan.

F. Rangkuman Materi

Komunikasi dalam keperawatan pada populasi khusus merupakan proses kompleks yang tidak hanya berfungsi sebagai pertukaran informasi, tetapi juga sebagai sarana membangun hubungan terapeutik, rasa aman, dan kepercayaan pasien. Pada kelompok seperti anak, lansia, pasien dengan gangguan jiwa, dan disabilitas, komunikasi harus disesuaikan dengan karakteristik perkembangan, kognitif, psikologis, serta kemampuan sensorik masing-masing individu. Ketidaksesuaian strategi komunikasi dapat menyebabkan miskomunikasi yang berdampak pada keselamatan pasien, termasuk kesalahan terapi, peningkatan kecemasan, hingga kejadian tidak diinginkan dalam pelayanan kesehatan.

Secara teoretis, komunikasi keperawatan pada populasi khusus didasarkan pada prinsip *patient-centered*, *developmentally appropriate*, *safety-oriented*, dan *accessible communication*. Komunikasi tidak hanya menekankan kejelasan dan akurasi informasi, tetapi juga aspek relasional seperti empati, kepercayaan, dan keterlibatan pasien. Selain itu, emotional intelligence menjadi komponen penting dalam mendukung efektivitas komunikasi, karena memungkinkan perawat memahami dan merespons kondisi emosional pasien secara tepat. Teknik komunikasi terapeutik seperti *active listening*, refleksi, klarifikasi, dan empati terbukti berperan dalam meningkatkan keterlibatan pasien, kepatuhan terapi, serta outcome klinis.

Dalam praktiknya, komunikasi pada populasi khusus menghadapi berbagai hambatan yang dapat terjadi pada tahap persepsi, pemrosesan, maupun ekspresi informasi. Hambatan ini dapat berasal dari faktor pasien (perkembangan, kognitif, sensorik), tenaga kesehatan (keterampilan komunikasi), maupun sistem (lingkungan, budaya, dan beban kerja). Oleh karena itu, asuhan keperawatan komunikasi harus dilakukan secara sistematis melalui pengkajian komprehensif, penetapan diagnosa, intervensi yang sesuai, serta evaluasi berkelanjutan. Pendekatan komunikasi yang adaptif, individual, dan berbasis kebutuhan terbukti mampu meningkatkan kualitas interaksi terapeutik serta keberhasilan asuhan keperawatan secara keseluruhan.

G. Daftar Pustaka

- AACN. (2021). The Essentials: Core Competencies for Professional Nursing Education. American Association of Colleges of Nursing.
- Alanezi, S. (2025). A modified framework for understanding provider–patient communication in healthcare. *International Journal of ADVANCED AND APPLIED SCIENCES*, 12(10), 100–107. <http://doi.org/10.21833/ijaas.2025.10.012>
- Alharazi, R. M., Abdulrahim, R. J., Mazuzah, A. H., Almutairi, R. M., Almutary, H., & Alhofaian, A. (2025). Barriers and Factors Affecting Nursing Communication When Providing Patient Care in Jeddah. *Clinics and Practice*, 15(1), 1–17. <http://doi.org/10.3390/clinpract15010019>
- Alkhamees, M., & Alasqah, I. (2023). Patient-physician communication in intercultural settings: An integrative review. *Heliyon*, 9(12). <http://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22667>
- Allan, E., Henderson, L., & Hay-Higgins, E. (2024). Therapeutic relationships across the lifespan. A Textbook of Community Nursing. <http://doi.org/10.4324/9781003347545-8>
- Alligood, M. R. (2018). Nursing Theorists and their work. In Elseiver Mosby, Inc (pp. 1–765).
- Alves, M. J. H., Maia, E. R., & Pagliuca, L. M. F. (2020). Evaluation of nurse's verbal communication skills in the blind patient consultation after training. *Academia.Edu*, 9(1), 31–36. <http://doi.org/10.9790/1959-0901053135>
- AMA. (2022). Specifications Manual for Joint Commission National Quality Measures. In American Medical Association (pp. 1–1398).
- Anggraini, I. R., Alifatin, A., Aini, N., & Pradita, V. G. (2022). The Effect of Play Therapy Among Children with Autism: A Scoping Review. *Jurnal Aisyah : Jurnal Ilmu Kesehatan*, 7(1), 287–294. <http://doi.org/10.30604/jika.v7i1.836>
- Arda, D., Menga, M. K., & Yuriatson, Y. (2023). Pelaksanaan Komunikasi Terapeutik Perawat di Ruang Rawat Inap Implementation of Nurse Therapeutic Communication in the Inpatient Room Penerbit : Edukasi Ilmiah Indonesia. *Jurnal Edukasi Kesehatan Ilmiah*, 1(2), 55–60.
- Arnold, E. C., & Boggs, K. U. (2020). Interpersonal relationships : professional communication skills for nurses / Elizabeth C. Arnold and Kathleen Underman Boggs, xii, 541 pages :-xii, 541 pages : Retrieved from <https://library.marjon.ac.uk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=60067>
- Aseeri, A. M., Saleh Alsalem, M. S., Saleh Alsalem, F. S., Asiri, A. hasel, Aseeri, K. M., mohammed alshahrani, sharifa ali, ... Khormi, T. M. (2024). Impact of Poor Communication among Nurses and Internal Medicine physicians on Patient

Safety: A Narrative Review with case studies. *Journal of International Crisis & Risk Communication Research (JICRCR)*, 7, 411–425. Retrieved from <https://research-ebsco-com.ezlib.iium.edu.my/linkprocessor/plink?id=82617545-cdee-383c-8446-c9541ba2dc8e>

- Astuti, A. M., Novianti, N. P., Santos, N. M. dos, Pinto, O. M., & Azhar, B. (2025). Effectiveness of Nurse Therapeutic Communication in Enhancing Patient Cooperation During Treatment. *Proceeding of International Conference on Science, Health, And Technology*, 44–50. <http://doi.org/10.47701/fxv4tn51>
- Axton, S. E., & Fugate, T. (2009). *Pediatric nursing care plans for the hospitalized child*. Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey.
- Ball, J. W., et al. (2011). *Principles of Pediatric Nursing*. Pearson.
- Barnlund, D. C. (2017). *Communication Theory Second edition*. (C. D. Mortensen, Ed.) Routledge Taylor & Francis.
- Bell, J., & Condren, M. (2018). Communication strategies for empowering and protecting children. *Journal of Pediatric Pharmacology and Therapeutics*, 21(2), 176–184. <http://doi.org/10.5863/1551-6776-21.2.176>
- Bergen, C., Bortolotti, L., Tallent, K., Broome, M., Larkin, M., Temple, R., ... McCabe, R. (2022). Communication in youth mental health clinical encounters: Introducing the agential stance. *Theory and Psychology*, 32(5), 667–690. <http://doi.org/10.1177/09593543221095079>
- Bond, C. (2024). Skills for communicating effectively with people who have mental health issues. *Nursing standard*. Royal College of Nursing (Great Britain), 39(12).
- Boztepe, H., & Cinar Ozbay, S. (2023). Communication Experiences of Nursing students with Children and Their Families: A Qualitative Study. *Journal of Education and Research in Nursing*, 20(1), 35–43. <http://doi.org/10.5152/jern.2022.80707>
- Bramhall, E. (2014). Effective communication skills in nursing practice. *Nursing Standard (Royal College of Nursing (Great Britain): 1987)*, 29(14), 53–59. <http://doi.org/10.7748/ns.29.14.53.e9355>
- Britto, F. da R., & Samperiz, M. M. F. (2010). Communication difficulties and strategies used by the nurses and their team in caring for the hearing impaired. *Einstein (São Paulo)*, 8(1), 80–85. <http://doi.org/10.1590/s1679-45082010ao1339>
- Broca, P. V., & Ferreira, M. de A. (2016). Action plan for the communication process in a nursing team. *Acta Scientiarum - Health Sciences*, 38(1), 23–31. <http://doi.org/10.4025/actascihealthsci.v38i1.29758>

- Bruun, A., & Tuffrey-Wijne, I. (2025). Palliative care communication between patients with intellectual disabilities and hospice staff: a Conversation Analysis pilot study. *BMJ Open*, 15(6), 1–6. <http://doi.org/10.1136/bmjopen-2025-101622>
- Caris-Verhallen, W. M. C. M., De Gruijter, I. M., Kerkstra, A., & Bensing, J. M. (1999). Factors related to nurse communication with elderly people. *Journal of Advanced Nursing*, 30(5), 1106–1117. <http://doi.org/10.1046/j.1365-2648.1999.01197.x>
- Caris-Verhallen, W. M. C. M., Kerkstra, A., & Bensing, J. M. (1997). The role of communication in nursing care for elderly people: A review of the literature. *Journal of Advanced Nursing*, 25(5), 915–933. <http://doi.org/10.1046/j.1365-2648.1997.1997025915.x>
- Caris-Verhallen, W. M. C. M., Kerkstra, A., & Bensing, J. M. (1999). Non-verbal behaviour in nurse-elderly patient communication. *Journal of Advanced Nursing*, 29(4), 808–818. <http://doi.org/10.1046/j.1365-2648.1999.00965.x>
- Carvalho, R., Mara Pontes, R. M., Carvalho, S. T., Felipe, T. C., do Espírito Santo, F. H., & Setenta, I. (2015). Body language in health care: a contribution to nursing communication. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 68(3), 430–436.
- Casey, P., & Kelly, B. D. (2024). Disorders of Perception. In *Fish's Clinical Psychopathology* (pp. 24–41). Cambridge University Press. <http://doi.org/10.1017/9781009372688.004>
- Cenedesi, R. T. F., Moura-Ferreira, M. C. De, Almeida, E. P. F. De, & Júnior, M. A. C. (2024). Effective Communication In Health: Strategies For Effective Work Development. *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, 29(9), 47–53. <http://doi.org/10.9790/0837-2909084753>
- Coyne, I., Hallström, I., & Söderbäck, M. (2016). Reframing the focus from a family-centred to a child-centred care approach for children's healthcare. *Journal of Child Health Care*, 20(4), 494–502. <http://doi.org/10.1177/1367493516642744>
- Daly, L. (2017). Effective communication with older adults. *Nursing Standard*, 31(41), 55–63. <http://doi.org/10.7748/ns.2017.e10832>
- Danishta, Kapoor, G., Kumar, M., Gugnani, A., Kuswaha, N., Rajbhar, R., ... -, I. U. (2024). Doctor-patient Communication in Healthcare: A Scoping Review. *International Journal For Multidisciplinary Research*, 6(3), 1–6. <http://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i03.23361>
- Davison, G., Conn, R., Kelly, M. A., Thompson, A., & Dornan, T. (2023). Fifteen-minute consultation: Guide to communicating with children and young people. *Archives of Disease in Childhood: Education and Practice Edition*, 108(2), 91–95. <http://doi.org/10.1136/archdischild-2021-323302>

- Desai, P. P., & Pandya, S. V. (2013). Communicating with children in healthcare settings. *Indian Journal of Pediatrics*, 80(12), 1028–1033. <http://doi.org/10.1007/s12098-013-0969-z>
- Deviantony, F., Kurniyawan, E. H., Alifia Marcheilla Yulfansha, Aura Najwa Salasabila, Adhelia Reisa Zalsabilla, Dewi, E. I., & Fitria, Y. (2024). The Effect Of Therapeutic Communication On The Anxiety Level Of The Elderly. *International Health Sciences Journal*, 2(1), 1–12. <http://doi.org/10.61777/ihsj.v2i1.46>
- Díaz-Pérez, A., Yáñez-Torregroza, Z., Gómez, J. L., Carrillo-Suárez, I., & Mora, S. G. (2018). Communication Process for the Strengthening of the Care of the Minor in a Pediatric Unit. *Global Journal of Health Science*, 10(10), 84. <http://doi.org/10.5539/gjhs.v10n10p84>
- Do Nascimento, J. M. F., Neto, F. J. D. C., Vieira Júnior, D. N., Braz, Z. R., Costa Júnior, I. G., Ferreira, A. C. D. C., ... De Oliveira, A. K. S. (2020). Escuta terapêutica: uma tecnologia do cuidado em saúde mental. *Revista de Enfermagem UFPE on Line*, 14. <http://doi.org/10.5205/1981-8963.2020.244257>
- Dodd, M. J. (1978). Assessing mental status. In *American journal of Nursing*.
- Doğan, T., & Çamurcu, Ş. (2025). Communication and the Importance of Communication in Child Development. *Contemporary Issues of Communication*, 4(1), 102–111. <http://doi.org/10.62425/conicom.1642225>
- Dunsmore, M. E., Watharow, A., & Schneider, J. (2025). An invisible disability: Communication, patient safety and dual sensory impairment in older persons. *Journal of Advanced Nursing*, 81(9), 5623–5626. <http://doi.org/10.1111/jan.16159>
- elzeni, basma, soliman, S., & Boughdady, A. (2023). Assessment of Communication Barriers between Nurses and Elderly Patients. *Mansoura Nursing Journal*, 10(1), 251–269. <http://doi.org/10.21608/mnj.2023.320390>
- Escalada-Hermández, P., & Marín-Fernández, B. (2018). The Nursing Diagnosis Disturbed Thought Processes: An Integrative Review. *International Journal of Nursing Knowledge*, 29(4), 253–262. <http://doi.org/10.1111/2047-3095.12186>
- Espinoza, K. M., & Heaton, L. J. (2016). Communicating with Patients with Special Health Care Needs. *Dental Clinics of North America*, 60(3), 693–705. <http://doi.org/10.1016/j.cden.2016.02.004>
- Finke, E. H., Davis, J. M., Benedict, M., Goga, L., Kelly, J., Palumbo, L., ... Waters, S. (2017). Effects of a Least-to-Most Prompting Procedure on Multisymbol Message Production in Children With Autism Spectrum Disorder Who Use Augmentative and Alternative Communication. *American Journal of Speech-Language Pathology*, 26(1), 81–98. http://doi.org/10.1044/2016_AJSLP-14-0187

- Frauenfelder, F., Achterberg, T. Van, Needham, I., & Staub, M. M. (2014). Nursing Diagnoses in Inpatient Psychiatry Search terms : Author contact : International Journal of Nursing Knowledge, 27(1), 1–11.
- Furnes, M., Kvaal, K. S., & Høye, S. (2018). Communication in mental health nursing - Bachelor Students' appraisal of a blended learning training programme - an exploratory study. BMC Nursing, 17(1), 20. <http://doi.org/10.1186/s12912-018-0288-9>
- Gamage, C. K. W., & Sudusinghe, W. S. (2024). Unveiling the heart of nursing: the transformative impact of emotional intelligence on patient-centred care. Asian Journal of Internal Medicine, 3(1), 36–41. <http://doi.org/10.4038/ajim.v3i1.129>
- Garcia, A. C., Arabi, A., Croteau, C., & de Lacerda, A. B. M. (2025). Enhancing communication in healthcare: Supports for interactions between adults with hearing loss and healthcare providers. PLoS ONE, 20(2 February), 1–12. <http://doi.org/10.1371/journal.pone.0308592>
- Ghrayeb, F., Zaben, K., Haddad, R. H., Ghrayeb, N., Barhoush, M., Zuraikat, N., & Abuejheisheh, A. J. (2025). Exploring the relationship between emotional intelligence and communication skills in nurses: a cross-sectional study. BMC Nursing, 24(1). <http://doi.org/10.1186/s12912-025-03679-5>
- Gilbert, F. T. (2019). Nursing intervention in the care of Autistic adolescents with communication disorder. Retrieved from [https://www.theseus.fi/handle/10024/266685%0Ahttps://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/266685/Final Thesis. Gilbert Tangem.pdf?sequence=2](https://www.theseus.fi/handle/10024/266685%0Ahttps://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/266685/Final%20Thesis%20Gilbert%20Tangem.pdf?sequence=2)
- Gonçalves, P. D. B., Sequeira, C. A. C., & e Silva, M. A. T. C. P. (2019). Content analysis of nursing diagnoses in mental health records in Portugal. International Nursing Review, 66(2), 199–208. <http://doi.org/10.1111/inr.12493>
- Groher, M. (1981). Neurologically Based Disorders of Speech and Language Among Older Adults. Seminars in Hearing, 2(3), 149–156. <http://doi.org/10.1055/s-0028-1095009>
- Hagerty, T. A., Samuels, W., & Gigliotti, E. (2018). Peplau's Theory of Interpersonal Relations: An Alternate Factor. Nurs Sci, 30(2), 1–15. <http://doi.org/10.1177/0894318417693286>.Peplau
- Hemsley, B., Sigafos, J., Balandin, S., Forbes, R., Taylor, C., Green, V. A., & Parmenter, T. (2001). Nursing the patient with severe communication impairment. Journal of Advanced Nursing, 35(6), 827–835. <http://doi.org/10.1046/j.1365-2648.2001.01920.x>
- Heydarian, N., Morera, O., & Frankowski, S. (2020). Developing a measure of blind patients' interactions with their healthcare providers. Disability and Health Journal, 13(3), 100906. <http://doi.org/10.1016/j.dhjo.2020.100906>

- Huang, S. C. C., Morgan, A., Peck, V., & Khoury, L. (2021). Improving Communications With Patients and Families in Geriatric Care. The How, When, and What. *Journal of Patient Experience*, 8, 1–9. <http://doi.org/10.1177/23743735211034047>
- Hurlock, E. B. (1979). *Child development* (5th Edition). McGraw-Hill.
- John Barren, J., Thakur, P., & Singh, S. (2025). Relational Dynamics in Health-Care: A Literature Review on the Impact of Nurse-Patient Communication on Patient Satisfaction and Health Outcomes. *International Research Journal of Medicine and Surgery*, 2(3), 01–08. <http://doi.org/10.47857/irjmeds.2025.v02i03.035>
- Katantha, M. N., Strametz, R., Baluwa, M. A., Mapulanga, P., & Chirwa, E. M. (2025). Effective Interprofessional Communication for Patient Safety in Low-Resource Settings: A Concept Analysis. *Safety*, 11(3), 1–20. <http://doi.org/10.3390/safety11030091>
- Keshtkar, L., Bennett-Weston, A., Khan, A. S., Mohan, S., Jones, M., Nockels, K., ... Howick, J. (2025). Impacts of Communication Type and Quality on Patient Safety Incidents A Systematic Review. *SSRN Electronic Journal*, 178(5), 687–700. <http://doi.org/10.2139/ssrn.5218033>
- Khanlou, N., Khan, A., Kurtz Landy, C., Srivastava, R., McMillan, S., VanDeVelde-Coke, S., & Vazquez, L. M. (2023). Nursing care for persons with developmental disabilities: Review of literature on barriers and facilitators faced by nurses to provide care. *Nursing Open*, 10(2), 404–423. <http://doi.org/10.1002/nop2.1338>
- Koegel, L. K., & Ashbaugh, K. (2017). Communication and Autism Spectrum Disorder. In *Curricula for Teaching Students with Autism Spectrum Disorder* (pp. 47–70). http://doi.org/10.1007/978-3-319-69983-7_3
- Kourkouta, L., & Papathanasiou, I. (2014). Communication in Nursing Practice. *Materia Socio Medica*, 26(1), 65. <http://doi.org/10.5455/msm.2014.26.65-67>
- Kupara, D., & Woodward, P. (2023). Conducting mental health assessments of people with learning disabilities. *Learning Disability Practice*. <http://doi.org/10.7748/ldp.2023.e2218>
- Kyle, T., & Carman, S. (2012). *Essentials of Pediatric Nursing*. In Lippincott Williams & Wilkins.
- Kyle, T., & Carman, S. (2013). *Essentials of Pediatric Nursing* 2nd edition. Wolters Kluwer Health.
- L Gaol, R., & Mestiana Br. Karo, M. B. (2025). The Relationship between Therapeutic Communication and Patient Satisfaction with Nursing Care. *Interest : Jurnal Ilmu Kesehatan*, 14(1), 9–18. <http://doi.org/10.37341/interest.v14i1.703>

- Lacerda, J. F. E. de, Santos, P. S. P. dos, Maia, E. R., Oliveira, D. R. de, Viana, M. C. A., & Cavalcante, E. G. R. (2021). Effective communication in the nurse-patient relationship in the light of Transcultural Interprofessional Practice model. *Rev Rene*, 22, e61443. <http://doi.org/10.15253/2175-6783.20212261443>
- Lee, S. H., & Yoo, H. J. (2024). Therapeutic Communication Using Mirroring Interventions in Nursing Education: A Mixed Methods Study. *Asian Nursing Research*, 18(5), 435–442. <http://doi.org/10.1016/j.anr.2024.09.012>
- Lee, S. J., Lee, S. J., Song, J. Y., & Kim, H. (2014). Characteristics of Language Comprehension in Normal Elderly and the Mild Cognitive Impaired. *Dementia and Neurocognitive Disorders*, 13(3), 51. <http://doi.org/10.12779/dnd.2014.13.3.51>
- Leotin, S. (2025). Addressing Health Communication Gaps: Improving Patient Experiences and Outcomes Through Human-Centered Design. *Journal of Patient Experience*, 12, 1–5. <http://doi.org/10.1177/23743735251334015>
- Lichtwarck-Aschoff, A., & van Rooij, M. M. J. W. (2019). Are changes in children's communication patterns predictive of treatment outcomes for children with anxiety? *Clinical Psychology and Psychotherapy*, 26(5), 572–585. <http://doi.org/10.1002/cpp.2383>
- Lind, B. M., Wigert, H., Jenholt Nolbris, M., & Patriksson, K. (2024). Child healthcare nurses' experience of communication with 4-year-old children during their visit to the child health care center. *Public Health Nursing*, 41(5), 1098–1105. <http://doi.org/10.1111/phn.13351>
- Löchner, J., Carlbring, P., Schuller, B., Torous, J., & Sander, L. B. (2025). Digital interventions in mental health: An overview and future perspectives. *Internet Interventions*, 40(March). <http://doi.org/10.1016/j.invent.2025.100824>
- Mariati, L. H., Jakri, Y., & Djerubu, D. (2022). The Effect of Emotional Intelligence on Nurse's Communication Skill. *Jurnal Ners Dan Kebidanan (Journal of Nursing and Midwifery)*, 9(2), 218–226. <http://doi.org/10.26699/jnk.v9i2.art.p218-226>
- Martinez, E. A., Tocantins, F. R., & de Souza, S. R. (2013). [The specificities of communication in child nursing care]. *Revista Gaúcha de Enfermagem / EENFUGRS*, 34(1), 37–44.
- Martino, D., Espay, A. J., Asano, A., & Morgante, F. (2016). Disorders of Movement. *Disorders of Movement: A Guide to Diagnosis and Treatment*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. <http://doi.org/10.1007/978-3-662-48468-5>
- McCabe, C., & Timmins, F. (2013). *Communication Skills for Nursing Practice*. Palgrave. <http://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-0-230-36901-4>

- McQueen, A. C. H. (2004). Emotional intelligence in nursing work. *Journal of Advanced Nursing*, 47(1), 101–108. <http://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2004.03069.x>
- Mersha, A., Abera, A., Tesfaye, T., Abera, T., Belay, A., Melaku, T., ... Wake, S. K. (2023). Therapeutic communication and its associated factors among nurses working in public hospitals of Gamo zone, southern Ethiopia: application of Hildegard Peplau's nursing theory of interpersonal relations. *BMC Nursing*, 22(1), 1–10. <http://doi.org/10.1186/s12912-023-01526-z>
- Miller, C. A. (2008). Communication Difficulties in Hospitalized Older Adults with Dementia. *AJN, American Journal of Nursing*, 108(3), 58–66. <http://doi.org/10.1097/01.naj.0000311828.13935.1e>
- Miller, W. R., & Rose, G. S. (2009). Toward a theory of motivational interviewing. *American Psychologist*, 64(6), 527–537. <http://doi.org/10.1037/a0016830>
- Milton, A. C., Mullan, B., MacCann, C., & Hunt, C. (2018). An evaluation of communication barriers and facilitators at the time of a mental health diagnosis: A survey of health professional practices. *Epidemiology and Psychiatric Sciences*, 27(4), 357–368. <http://doi.org/10.1017/S2045796016001153>
- Minarti, M., Kholifah, S. N., Sulistijono, H., Yumni, H., Windi, Y. ., Asnani, A., ... Kumala, F. (2022). Model of Guidance: Effective Communication with the Elderly for Empowering Elderly Caregivers in Nursing Homes in Indonesia. *Frontiers in Community Service and Empowerment*, 1(2), 58–62. <http://doi.org/10.35882/ficse.v1i2.11>
- Mishari, A. K., & Ali, M. A. K. (2025). Enhancing Communication with Older Adults with Cognitive Impairment in Healthcare Settings. *Iraqi Journal of Community Medicine*, 38(2), 107–111. http://doi.org/10.4103/irjcm.irjcm_2_25
- Mountford, S. K. B. (1997). *a Therapeutic Nursing Relationship*.
- Moussa, Y., Alzahrani, F., Elshemy, R., & Fawzy, S. (2025). An investigation of healthcare communication with patients with disability: The case of medical practitioners. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 9(12), 304–311. <http://doi.org/10.55214/2576-8484.v9i12.11339>
- Mundakir. (2006). *komunikasi keperawatan aplikasi dlm pelayanan.pdf*. Graha Ilmu.
- NICE. (2023). Dementia: assessment, management and support for people living with dementia and their carers (NG97)| Guidance | NICE. National Institute for Health and Care Excellence, (January), 1–5. Retrieved from <https://www.nice.org.uk/guidance/ng97>
- Niu, Y., Sun, J., Zhu, K., Xu, B., Zhang, Y. P., & Peng, M. (2025). The Critical Role and Effects of Patient-Centered Communication in Psychotherapy: A Narrative

- Review. *Psychology Research and Behavior Management*, 18(July), 1657–1671. <http://doi.org/10.2147/PRBM.S528343>
- NMC. (2025). Standards for competence for registered nurses. Nursing MidWifery Council. Retrieved from <https://www.nursingcouncil.org.nz/common/Uploadedfiles/Public/Nursing/Registered nurse/NCNZ031-Competencies-RN-11.pdf>
- O'Toole, J. K., Alvarado-Little, W., & Ledford, C. J. W. (2019). Communication with Diverse Patients: Addressing Culture and Language. *Pediatric Clinics of North America*, 66(4), 791–804. <http://doi.org/10.1016/j.pcl.2019.03.006>
- OpenStax. (2024). Fundamentals of nursing: Communication. LibreTexts. Retrieved from [https://med.libretexts.org/Bookshelves/Nursing/Fundamentals_of_Nursing_\(OpenStax\)/02%3A_Communication](https://med.libretexts.org/Bookshelves/Nursing/Fundamentals_of_Nursing_(OpenStax)/02%3A_Communication)
- Orujlu, A., & Adigozalova, S. (2026). The Impact of Language Barriers on Nurse–Patient Communication and Clinical Errors. *EuroGlobal Journal of Linguistics and Language Education*, 3(1), 74–81. <http://doi.org/10.69760/egjlle.26010080>
- Osei Appiah, E., Appiah, S., Kontoh, S., Mensah, S., Awuah, D. B., Menlah, A., & Baidoo, M. (2022). Pediatric nurse-patient communication practices at Pentecost Hospital, Madina: A qualitative study. *International Journal of Nursing Sciences*, 9(4), 481–489. <http://doi.org/10.1016/j.ijnss.2022.09.009>
- Panguluri, P., & Mohan, N. D. (2018). Conceptual paper on emotional Intelligence. *Ijrar*, 5(4), 47–64.
- Papageorgiou, A., Loke, Y. K., & Fromage, M. (2017). Communication skills training for mental health professionals working with people with severe mental illness. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2017(6). <http://doi.org/10.1002/14651858.CD010006.pub2>
- Parrales-Choez, A. J., Jaqueline-Beatriz, D. M., Menéndez-Pin, T.-R., & Ramos-Arce, G. C. (2022). Effective communication skills as a nurse in understanding patients. *Cienciamatria*, 8(1), 24–35. <http://doi.org/10.35381/cm.v8i1.613>
- Pennacchia, J. M., Østvik, J., Dutia, I., Walsh, M., Coghill, D., Granlund, M., & Imms, C. (2025). Assessing mental health of people with complex communication needs: A systematic review. *Journal of Communication Disorders*, 113(April 2024). <http://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2025.106494>
- Perry, & Potter. (2012). Fundamentals of Nursing 4th edition.
- Pontes, A. C., Leitão, I. M. T. A., & Ramos, I. C. (2008). Comunicação terapêutica em Enfermagem: instrumento essencial do cuidado. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 61(3), 312–318. <http://doi.org/10.1590/s0034-71672008000300006>

- Putri, A. K., Nugraheni, S. A., & Winarni, S. (2024). A scoping review of risk factor analysis influencing speech and language delay in toddler's development. *Journal of Holistic Nursing Science*, 11(1), 37–43. <http://doi.org/10.31603/nursing.v11i1.11185>
- Raeissi, P., Zandian, H., Mirzarahimy, T., Delavari, S., Moghadam, T. Z., & Rahimi, G. (2019). Relationship between communication skills and emotional intelligence among nurses. *Nursing Management*, 26(2), 31–35. <http://doi.org/10.7748/nm.2019.e1820>
- Rasmita, D., Suza, D. E., & Arruum, D. (2026). Nurses ' Communication in Providing Care for Children with Cancer : Literature Review, 9(1), 121–132.
- Rebouças, C. B. de A., Pagliuca, L. M. F., & Almeida, P. C. de. (2007). Non-verbal communication: aspects observed during nursing consultations with blind patients. *Escola Anna Nery*, 11(1), 38–43. <http://doi.org/10.1590/s1414-81452007000100005>
- Rider, E. A. (2011). Advanced communication strategies for relationship-centered care. *Pediatric Annals*, 40(9), 447–453. <http://doi.org/10.3928/00904481-20110815-08>
- Riswari, F., Ediyanto, E., Efendi, M., & Sunandar, A. (2022). Augmentative and Alternative Communication (AAC) sebagai Teknologi Assistive dalam Mendukung Anak Cerebral Palsy dengan Kebutuhan Komunikasi yang Kompleks. *Jurnal Pendidikan Kebutuhan Khusus*, 6(1), 76–85. <http://doi.org/10.24036/jpkk.v6i1.610>
- Ruesch, A. L. (2018). Exploring an educational assessment tool to measure registered nurses' knowledge of hearing impairment and effective communication strategies: A USA study. *Nurse Education in Practice*, 28(June 2016), 144–149. <http://doi.org/10.1016/j.nepr.2017.10.017>
- Safitri, M. A., Nursalam, N., & Nihayati, H. E. (2024). The Influence and Factors of Nurse Therapeutic Communication on Patient Satisfaction: A Systematic Review. *Indonesian Journal of Global Health Research*, 6(S6), 1413–1422. Retrieved from <https://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/IJGHR/article/view/4647>
- Sánchez-Almagro, Pedro, C., Romero-Sánchez, Manuel, J., White-Ríos, Melanie, ... Olga. (2022). NANDA International nursing diagnoses in the coping/stress tolerance domain and their linkages to Nursing Outcomes Classification outcomes and Nursing Interventions Classification interventions in the pre-hospital emergency care. *Journal of Advanced Nursing*, 78(10), 3273–3289. <http://doi.org/10.1111/jan.15280>
- Schmutz, T., Le Terrier, C., Ribordy, V., Iglesias, K., & Guechi, Y. (2023). The Effect of Positive Therapeutic Communication on Pain (POPAIN) and Anxiety During

Arterial Blood Gas Standardized Procedures in the Emergency Department Compared to Traditional Communication: Protocol for a Monocentric Randomized Controlled Trial. *JMIR Research Protocols*, 12. <http://doi.org/10.2196/42043>

Shahi, M. U., & Sharma, D. L. (2024). Interpersonal Communication and Mental Health: An Impact Study of Interpersonal Communication Skills on Mental Health of Youth. *Indian Journal of Mass Communication and Journalism*, 3(4), 1–7. <http://doi.org/10.54105/ijmcj.d1071.03040624>

Sharki, S. H. (2023). Quality communication can improve patient-centred health outcomes among older patients: a rapid review. *BMC Health Services Research*, 23(1), 1–14. <http://doi.org/10.1186/s12913-023-09869-8>

Sheldon, L. Kennedy. (2010). komunikasi untuk keperawatan-berbicara dengan pasien.pdf. Erlangga.

Sibiya, M. N. (2018). Effective Communication in Nursing. *Nursing*. <http://doi.org/10.5772/intechopen.74995>

Silverman, J., Kurtz, S., & Draper, J. (2016). Skills for Communicating with Patients. Skills for Communicating with Patients. <http://doi.org/10.1201/9781910227268>

Sisk, B. A., Friedrich, A. B., Mozersky, J., Walsh, H., & DuBois, J. (2020). Core Functions of Communication in Pediatric Medicine: an Exploratory Analysis of Parent and Patient Narratives. *Journal of Cancer Education*, 35(2), 256–263. <http://doi.org/10.1007/s13187-018-1458-x>

Street, R. L. (2013). How clinician-patient communication contributes to health improvement: Modeling pathways from talk to outcome. *Patient Education and Counseling*, 92(3), 286–291. <http://doi.org/10.1016/j.pec.2013.05.004>

Street, R. L., Makoul, G., Arora, N. K., & Epstein, R. M. (2009). How does communication heal? Pathways linking clinician-patient communication to health outcomes. *Patient Education and Counseling*, 74(3), 295–301. <http://doi.org/10.1016/j.pec.2008.11.015>

Tatiana, F., Cruz, C., Esteban, J., Camargo, G., Alejandro, M., Rojas, C., ... Effective, D. (2020). Effective communication in health care : a systematic review Citation Review question Search strategy Participants / population Intervention (s), exposure (s) Comparator (s)/ control Main outc. *National Institute for Health Research*, 1–5.

Thornton, R., & Light, L. L. (2006). Language Comprehension and Production in Normal Aging. *Handbook of the Psychology of Aging*, 261–287. <http://doi.org/10.1016/B978-012101264-9/50015-X>

Verhallen, C., M.C.M., W., Kerkstra, A., Van Der Heijden, P. G. M., & Bensing, J. M. (1998). Nurse-elderly patient communication in home care and institutional

- care: An explorative study. *International Journal of Nursing Studies*, 35(1–2), 95–108. [http://doi.org/10.1016/s0020-7489\(97\)00039-4](http://doi.org/10.1016/s0020-7489(97)00039-4)
- Voss, E. A. (2019). Nursing Strategies to Meet the Communication Needs of Children with Autism Spectrum Disorder. Retrieved from <https://spark.bethel.edu/etd/643/%0Ahttps://spark.bethel.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1642&context=etd>
- Weber, A., Lopes, P. F., Pereira, C. F., & Toledo, V. P. (2025). Schutz and Peplau: Possibilities for Dialogue Between Research and Nursing Care. *Nursing Open*, 12(12). <http://doi.org/10.1002/nop2.70382>
- White, M. L., & Verduco, L. M. (2018). Communicating with Older Adults. *Home Healthcare Now*, 36(3), 181–184. <http://doi.org/10.1097/NHH.0000000000000653>
- WHO, I. &. COMMUNICATION, WHO (2024).
- WHO. (2017). Guidelines for drinking water quality, 4th. In Incorporating the first addendum (Vol. 55, pp. 87–87). Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd.
- Williams, R. (2018). Older people in hospital. *Nursing Management*, 24(9), 11–11. <http://doi.org/10.7748/nm.24.9.11.s9>
- Xue, L., Gong, Y., Pill, S., & Han, W. (2025). Communication Disorders and Mental Health Outcomes in Children and Adolescents: A Scoping Review. *Healthcare (Switzerland)*, 13(15), 1–20. <http://doi.org/10.3390/HEALTHCARE13151807>

BAB 3

KOMUNIKASI BUDAYA DAN SPIRITUAL TRANSKULTURAL, BAHASA, DAN SENSITIVITAS NILAI

CPMK Terkait: CPMK-5 (Menerapkan teknik komunikasi pada populasi khusus/rentan serta situasi sulit/berisiko).

CPL Terkait: CPL-1 (Mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik serta menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keperawatan secara mandiri).

Capaian Pembelajaran Bab (Sub-CPMK)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu:

- (S11.1) Menganalisis fenomena transkultural dan strategi komunikasi sensitif bahasa dalam asuhan keperawatan.
- (S11.2) Mendemonstrasikan teknik de-eskalasi dan validasi pesan pada pasien dengan latar belakang budaya atau keyakinan yang beragam.

Indikator Ketercapaian

- Ketepatan dalam menjelaskan konsep kecerdasan budaya (*cultural intelligence*) dan kompetensi budaya (Andrews & Boyle, 2019).
- Kemampuan menunjukkan perilaku empatik dan sensitivitas nilai dalam simulasi komunikasi spiritual.
- Skor penilaian de-eskalasi dan adaptasi populasi khusus $\geq 3/4$ berdasarkan rubrik CPMK-5.

Peta Konsep Bab

Kecerdasan Budaya Komunikasi Transkultural Sensitivitas Bahasa & Nilai Hambatan Budaya (Jargon & Power Imbalance) Komunikasi Spiritual Keselamatan Pasien.

Kata Kunci & Glosarium

- **Keperawatan Transkultural (*Transcultural Nursing*):** Fokus asuhan keperawatan yang memadukan perbedaan budaya untuk memberikan perawatan yang selaras dengan nilai pasien.
- **Kecerdasan Budaya (*Cultural Intelligence*):** Kemampuan perawat untuk berfungsi dan berkomunikasi secara efektif dalam situasi yang beragam secara budaya.
- **Sensitivitas Nilai (*Value Sensitivity*):** Kesadaran dan penghormatan terhadap keyakinan, norma, dan tradisi unik yang dianut oleh pasien dan keluarganya.
- **Komunikasi Spiritual:** Interaksi yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan batin, makna hidup, dan dukungan terhadap praktik keagamaan pasien selama masa sakit.
- **Jargon Medis:** Istilah teknis kedokteran yang harus dihindari atau disederhanakan untuk mencegah ketimpangan kekuasaan (power imbalance) dan salah interpretasi.
- **Literasi Kesehatan (*Health Literacy*):** Tingkat kemampuan pasien untuk memperoleh, memproses, dan memahami informasi kesehatan dasar guna mengambil keputusan medis yang tepat.
- **Validasi Pesan:** Teknik memastikan bahwa pesan atau instruksi klinis telah dipahami dengan benar oleh pasien melalui metode seperti teach-back.
- **De-eskalasi Budaya:** Strategi komunikasi untuk menurunkan ketegangan atau konflik yang dipicu oleh perbedaan persepsi budaya antara tenaga kesehatan dan pasien.

Pendahuluan

Keperawatan merupakan profesi yang unik karena berinteraksi langsung dengan dimensi kemanusiaan yang paling dasar, yaitu budaya dan keyakinan. Dalam kurikulum *Outcome-Based Education* (OBE), mahasiswa keperawatan dituntut tidak hanya menguasai keterampilan klinis, tetapi juga kecerdasan budaya (*cultural intelligence*) untuk menjembatani perbedaan nilai antara perawat dan pasien (Andrews & Boyle, 2019). Komunikasi transkultural menjadi kunci utama dalam meminimalisir kesalahan medis dan meningkatkan kepuasan pasien. Bab ini akan membedah secara filosofis dan praktis bagaimana komunikasi budaya dan spiritual diintegrasikan dalam asuhan keperawatan.

A. Konsep Keperawatan Transkultural dan Strategi Komunikasi

1. Definisi komunikasi antar budaya dan komponennya

Keperawatan transkultural adalah area spesialisasi yang berfokus pada studi komparatif dan analisis budaya yang berbeda di dunia terkait dengan perilaku asuhan keperawatan (Leininger & McFarland, 2018). Komunikasi dalam konteks ini adalah proses dinamis yang dipengaruhi oleh pandangan dunia, bahasa, dan struktur sosial pasien. Tanpa pemahaman transkultural, perawat berisiko melakukan *cultural imposition*, yaitu memaksakan nilai-nilai kesehatan modern tanpa mempertimbangkan kearifan lokal pasien.

Komunikasi lintas budaya (*cross-cultural communication*) sering digunakan sebagai istilah yang setara dengan komunikasi antar budaya (*intercultural communication*). Istilah ini tidak dibatasi oleh perbedaan geografis, ras, maupun etnis, melainkan menekankan pada interaksi antara individu atau kelompok dengan latar belakang budaya yang berbeda. Komunikasi antar budaya dalam keperawatan dipahami sebagai proses interaksi di mana individu atau kelompok yang terlibat memiliki latar belakang budaya yang berbeda, sehingga memengaruhi cara mereka menafsirkan pesan dan konteks (Sarfika & Sidaria, 2025).

Secara konseptual, komunikasi lintas budaya merupakan suatu kajian komparatif yang menitikberatkan pada perbandingan aktivitas dan fenomena budaya dalam berbagai konteks. Pendekatan ini lebih menekankan pada bagaimana perbedaan budaya memengaruhi proses komunikasi, tanpa harus menghasilkan budaya baru sebagaimana yang terjadi dalam proses asimilasi (Purwasito, 2003).

Menurut Fiber Luce (1991) dalam Sarfika, & Sidaria (2025), hakikat komunikasi lintas budaya adalah studi komparatif yang bertujuan membandingkan variabel-variabel budaya tertentu serta dampak atau konsekuensi yang ditimbulkan dari pengaruh budaya tersebut dalam dua atau lebih konteks budaya. Melalui kajian ini, individu tidak hanya memahami budaya dirinya sendiri, tetapi juga menyadari adanya dominasi atau pengaruh budaya lain dalam interaksi antarbudaya. Dengan demikian, komunikasi antar budaya akan berlangsung efektif apabila seseorang memiliki pemahaman yang baik terhadap budayanya sendiri dan budaya pihak/orang lain.

Lebih lanjut, Williams (1966) dalam Sarfika., & Sidaria (2025), menjelaskan bahwa komunikasi lintas budaya berfokus pada analisis perbandingan perilaku komunikasi antar budaya dengan mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya. Aspek-aspek yang dibandingkan meliputi:

- a. **Persepsi terhadap pengalaman**, termasuk pengaruh lingkungan sosial dan fisik.
- b. **Kognisi**, yang mencakup unsur budaya, bahasa, dan pola berpikir.
- c. **Proses sosialisasi**, yaitu bagaimana individu mempelajari nilai dan norma budaya.
- d. **Kepribadian**, termasuk karakter budaya yang memengaruhi etos dan perilaku individu maupun kelompok.

Pemahaman terhadap aspek-aspek tersebut menjadi dasar penting dalam membangun komunikasi yang efektif, adaptif, dan sensitif terhadap perbedaan budaya. Menurut Sarfika & Sidaria (2025), terdapat empat komponen utama yang menentukan keberhasilan komunikasi antar budaya ini:

- a. Bahasa: tantangan utama dalam penerjemahan makna dan nuansa.
- b. Simbol: gestur, warna, atau objek yang maknanya dapat bertolak belakang antar budaya.
- c. Nilai dan Norma: standar perilaku yang menentukan apakah sebuah interaksi dianggap sopan atau tidak.
- d. Praktik dan Tradisi: kebiasaan sosial yang memengaruhi pola komunikasi.

2. Teori model komunikasi antar budaya

Terdapat 3 (tiga) teori model komunikasi antar budaya, yaitu: teori konteks budaya Edward T. Hall, teori transcultural nursing menurut Madeleine Leinenger, dan teori model kompetensi budaya menurut Larry Prnell.

a. Teori Konteks Budaya (Edward T. Hall)

Edward T. Hall membagi budaya berdasarkan bagaimana pesan disampaikan dan diterima. Pemahaman ini sangat penting agar perawat tidak salah menafsirkan respons pasien (Sarfika & Sidaria, 2025).

- 1) **Budaya Konteks Tinggi (*High-Context*)**: Pesan bersifat implisit, tidak langsung, dan sangat bergantung pada bahasa tubuh, intonasi, serta situasi (banyak ditemukan di budaya Asia, termasuk Indonesia).
 - a) **Contoh**: Perawat bertanya apakah pasien bersedia dilakukan tindakan medis. Pasien hanya mengangguk pelan dan tersenyum meskipun sebenarnya ia merasa takut.
 - b) **Cara Komunikasi Perawat**: Perawat tidak boleh hanya berpegang pada kata "ya", tetapi harus memperhatikan isyarat non-verbal.

Perawat bisa berkata: *"Saya melihat Ibu tampak agak ragu, apakah ada bagian dari prosedur ini yang membuat Ibu merasa kurang nyaman?"*

- 2) **Budaya Konteks Rendah (*Low-Context*):** Pesan bersifat eksplisit, langsung, dan apa adanya. Kata-kata yang diucapkan adalah makna sebenarnya (budaya Barat seperti Amerika atau Jerman).
 - a) Contoh: Pasien langsung berkata, "Saya tidak mau minum obat ini karena membuat saya mual."
 - b) Cara Komunikasi Perawat: Perawat harus berkomunikasi secara to-the-point, jelas, dan memberikan fakta medis yang logis tanpa perlu banyak basa-basi yang tidak relevan.

b. Teori Transkultural Nursing (Madeleine Leininger)

Leininger menekankan bahwa asuhan keperawatan harus selaras dengan nilai-nilai budaya agar efektif. Ia memperkenalkan dua konsep utama (Leininger & McFarland, 2018):

- 1) **Cultural Care Universality (Kesamaan Budaya):** Merujuk pada nilai-nilai kesehatan yang bersifat umum dan dimiliki oleh hampir semua budaya (seperti kebutuhan akan kasih sayang, kebersihan, dan keamanan).
 - a) **Cara Komunikasi:** Perawat menunjukkan empati universal seperti sentuhan lembut pada bahu atau menjaga privasi pasien saat tindakan. Hal ini diterima dengan baik oleh pasien dari latar belakang mana pun karena merupakan kebutuhan dasar manusia.
- 2) **Cultural Care Diversity (Keragaman Budaya):** Merujuk pada variasi nilai, keyakinan, dan pola hidup yang unik pada kelompok tertentu.
 - a) **Contoh:** Seorang pasien dari suku tertentu menolak makan sayuran hijau karena dianggap "dingin" bagi tubuhnya setelah operasi.
 - b) **Cara Komunikasi:** Perawat melakukan negosiasi budaya. Alih-alih memarahi, perawat berkata: *"Saya mengerti Bapak menghindari sayur ini demi keseimbangan tubuh Bapak. Bagaimana jika kita menggantinya dengan sumber protein lain yang menurut Bapak lebih cocok, namun tetap membantu penyembuhan luka Bapak?"*

c. Model Kompetensi Budaya Larry Purnell

Model Purnell menyediakan kerangka kerja 12 domain untuk memahami budaya pasien secara menyeluruh. Intinya adalah perawat harus berpindah dari "ketidaktahuan" menjadi "kesadaran budaya" (Sarfika & Sidaria, 2025).

- 1) **Aplikasi Komunikasi menurut Purnell:** Purnell menekankan pada pengkajian yang mendalam sebelum memberikan asuhan. Perawat harus berkomunikasi untuk menggali domain budaya pasien (seperti organisasi keluarga, tradisi tenaga kerja, atau praktik keagamaan).
- 2) **Contoh Kasus (Domain Organisasi Keluarga):** Seorang pasien harus segera dioperasi, namun ia menolak menandatangani *informed consent* dan mengatakan harus menunggu keputusan dari kepala suku atau anggota keluarga laki-laki tertua.
- 3) **Cara Komunikasi Perawat (Sesuai Purnell):** Perawat menghargai hierarki pengambilan keputusan tersebut. Perawat berkata: *"Kami sangat menghormati keputusan keluarga besar Ibu. Apakah ada anggota keluarga yang bisa segera kami hubungi melalui telepon untuk mendiskusikan prosedur darurat ini agar keselamatan Ibu tetap terjaga?"*

d. Bentuk Komunikasi Antar Budaya

Dalam konteks komunikasi lintas budaya, bentuk komunikasi dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Keduanya memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan serta membangun pemahaman antarindividu dari latar belakang budaya yang berbeda.

1) Komunikasi Verbal

Komunikasi verbal merupakan proses penyampaian pesan menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tertulis. Bentuk komunikasi ini menjadi sarana utama dalam menyampaikan informasi, gagasan, perasaan, dan pikiran secara eksplisit sehingga relatif mudah dipahami oleh lawan bicara.

Bahasa menjadi komponen utama dalam komunikasi verbal karena berfungsi sebagai media untuk menerjemahkan ide dan makna dari komunikator kepada komunikan. Oleh karena itu, perbedaan bahasa dalam komunikasi lintas budaya seringkali menjadi tantangan yang memerlukan perhatian khusus.

Berdasarkan bentuknya, komunikasi verbal dibedakan menjadi:

a) Komunikasi Lisan

Komunikasi lisan adalah penyampaian pesan secara langsung melalui ucapan. Interaksi ini dapat berlangsung secara tatap muka maupun melalui media komunikasi seperti telepon atau platform

virtual. Komunikasi lisan memungkinkan adanya umpan balik secara langsung, sehingga mempermudah klarifikasi pesan.

b) Komunikasi Tertulis

Komunikasi tertulis dilakukan melalui media tulisan, baik dalam bentuk konvensional seperti surat maupun melalui media digital seperti email dan media sosial. Bentuk komunikasi ini memberikan kesempatan bagi penyusun pesan untuk lebih terstruktur, namun memerlukan kejelasan bahasa agar tidak menimbulkan multitafsir.

2) Komunikasi Nonverbal

Komunikasi nonverbal adalah proses penyampaian pesan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan melalui berbagai isyarat atau simbol. Dalam praktiknya, komunikasi nonverbal seringkali lebih dominan dan dianggap lebih spontan serta mencerminkan kondisi emosional yang sebenarnya.

Komunikasi nonverbal memiliki peran penting dalam memperkuat, melengkapi, atau bahkan menggantikan pesan verbal. Melalui komunikasi ini, individu dapat mengekspresikan berbagai perasaan seperti senang, sedih, marah, atau cemas.

Beberapa bentuk komunikasi nonverbal meliputi:

a) Perilaku Tubuh (Kinesik)

Meliputi gerakan tubuh, postur, dan penampilan fisik yang dapat memberikan makna tertentu dalam interaksi.

b) Ekspresi Wajah

Ekspresi wajah menjadi indikator utama dalam menunjukkan emosi seseorang, seperti kebahagiaan, kesedihan, atau kemarahan.

c) Kontak Mata

Tatapan mata dapat mencerminkan perhatian, kepercayaan diri, atau bahkan ketidaksopanan, tergantung pada konteks budaya.

d) Sentuhan (Haptik)

Sentuhan digunakan sebagai bentuk komunikasi interpersonal, seperti berjabat tangan atau menepuk bahu, yang maknanya berbeda di setiap budaya.

e) Parabahasa

Meliputi aspek vokal seperti intonasi, nada, kecepatan bicara, dan volume suara yang memengaruhi makna pesan.

f) Ruang dan Jarak (Proksemik)

Mengacu pada penggunaan ruang dan jarak dalam interaksi, yang berbeda-beda antar budaya.

g) **Waktu dan Sikap Diam (Kronemik)**

Persepsi terhadap waktu dan penggunaan diam dalam komunikasi juga memiliki makna tertentu dalam konteks budaya.

e. Pengaruh Budaya Terhadap Komunikasi

Hubungan antara budaya dan komunikasi bersifat kompleks dan saling memengaruhi. Dalam perspektif dialektis, budaya dan komunikasi tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki hubungan timbal balik. Budaya membentuk cara individu berkomunikasi, sementara komunikasi juga berperan dalam membangun dan mempertahankan realitas budaya dalam suatu masyarakat.

Setiap kelompok budaya memiliki cara tersendiri dalam memaknai realitas yang tercermin melalui tindakan, simbol, dan pola komunikasi sehari-hari. Dengan kata lain, budaya memberikan kerangka interpretasi terhadap pengalaman hidup, sedangkan komunikasi menjadi sarana utama untuk mengekspresikan dan mentransmisikan makna tersebut kepada orang lain. Oleh karena itu, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian pesan, tetapi juga sebagai mekanisme pembentuk realitas sosial dan budaya.

Dalam kajian komunikasi antar budaya, para ahli sering menggunakan pendekatan dari antropologi dan psikologi untuk memahami perbedaan budaya dalam proses komunikasi. Dua kerangka teori yang banyak digunakan adalah teori orientasi nilai dari Kluckhohn dan Strodtbeck (1961) serta dimensi budaya dari Hofstede (1984).

1) **Orientasi Nilai Budaya**

Kluckhohn dan Strodtbeck menekankan bahwa nilai-nilai budaya merupakan dasar yang membentuk perilaku komunikasi suatu kelompok. Nilai budaya berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan apa yang dianggap benar, penting, dan bermakna dalam kehidupan.

Sebagai contoh, nilai kesetaraan (*equality*) menjadi salah satu nilai dominan dalam masyarakat Amerika Serikat. Nilai ini mencerminkan keyakinan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama, meskipun dalam kenyataannya terdapat perbedaan dalam kemampuan, sumber daya, dan kesempatan.

Perbedaan orientasi nilai sering kali menjadi sumber konflik dalam komunikasi antar budaya. Misalnya, sebagian budaya sangat

menghargai tradisi dan pengalaman masa lalu sebagai pedoman dalam bertindak, sementara budaya lain lebih berorientasi pada masa depan dan inovasi. Perbedaan ini dapat menimbulkan kesalahpahaman, terutama dalam konteks kerja sama internasional, di mana pihak yang berorientasi masa depan dapat dianggap kurang menghargai nilai-nilai tradisional.

2) Perbedaan Kekuasaan dan Nilai Dominan

Konflik komunikasi antar budaya juga dapat diperkuat oleh adanya ketimpangan kekuasaan. Dalam situasi tertentu, nilai-nilai dari kelompok yang lebih dominan cenderung lebih diutamakan dibandingkan nilai kelompok lain. Hal ini dapat menyebabkan marginalisasi budaya tertentu dalam proses komunikasi.

Dalam konteks organisasi, khususnya di beberapa tempat kerja di Amerika Serikat, nilai individualisme sering kali lebih dihargai dibandingkan kolektivisme. Penekanan pada kemandirian, pencapaian pribadi, dan tanggung jawab individu memengaruhi pola komunikasi yang cenderung langsung, terbuka, dan berorientasi pada hasil. Sebaliknya, dalam budaya kolektivistik, komunikasi lebih menekankan harmoni, hubungan interpersonal, dan kepentingan kelompok.

f. Cara berkomunikasi dalam konteks budaya yang beragam

Komunikasi dalam konteks lintas budaya menuntut kemampuan adaptasi, sensitivitas, serta pemahaman terhadap perbedaan nilai dan norma yang dimiliki oleh setiap kelompok budaya. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang tepat agar interaksi dapat berlangsung secara efektif, saling menghargai, dan minim konflik.

1) Memahami Perbedaan Budaya

Langkah awal dalam komunikasi lintas budaya adalah memahami karakteristik budaya pihak lain. Hal ini dapat dilakukan dengan:

- a) **Mengidentifikasi nilai, norma, dan kebiasaan budaya** sebelum melakukan interaksi, sehingga komunikasi dapat disesuaikan dengan konteks budaya tersebut.
- b) **Menyadari relativitas budaya**, yaitu memahami bahwa standar sopan santun, etika, dan perilaku komunikasi berbeda antara satu budaya dengan budaya lainnya. Apa yang dianggap wajar atau sopan dalam suatu budaya belum tentu memiliki makna yang sama dalam budaya lain.

Pemahaman ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dan meningkatkan efektivitas komunikasi.

2) **Menggunakan Bahasa yang Jelas dan Sederhana**

Bahasa merupakan elemen utama dalam komunikasi lintas budaya yang sering menjadi sumber hambatan. Oleh karena itu, diperlukan strategi sebagai berikut:

- a) **Menghindari penggunaan istilah lokal, jargon, atau bahasa gaul (slang)** yang berpotensi tidak dipahami oleh lawan bicara dari budaya berbeda.
- b) **Menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan langsung**, terutama ketika berkomunikasi dalam bahasa asing, agar pesan dapat diterima dengan baik tanpa menimbulkan ambiguitas.

Penggunaan bahasa yang efektif akan membantu memperjelas pesan dan mengurangi risiko miskomunikasi.

3) **Memperhatikan Komunikasi Nonverbal**

Selain bahasa verbal, komunikasi nonverbal memiliki peran penting dalam interaksi lintas budaya. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi:

- a) **Ekspresi wajah, kontak mata, intonasi suara, serta bahasa tubuh**, yang dapat memiliki makna berbeda dalam setiap budaya.
- b) **Perbedaan interpretasi kontak mata**, misalnya kontak mata yang intens di budaya Barat sering diartikan sebagai tanda kepercayaan diri, sedangkan di beberapa budaya Asia dapat dianggap kurang sopan atau menantang.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap makna simbolik komunikasi nonverbal menjadi sangat penting dalam menjaga keharmonisan interaksi.

4) **Mengembangkan Sikap Sensitif Budaya**

Komunikasi lintas budaya yang efektif tidak hanya bergantung pada keterampilan teknis, tetapi juga pada sikap individu. Sikap tersebut meliputi:

- a) **Menghargai perbedaan budaya**, yaitu menerima dan mengakui keberagaman sebagai suatu realitas sosial yang harus dihormati.
- b) **Membangun kesadaran diri (self-awareness)**, yaitu memahami bagaimana latar belakang budaya sendiri memengaruhi cara berpikir, berbicara, dan berperilaku dalam komunikasi.

Dengan mengembangkan sikap ini, perawat atau tenaga kesehatan dapat menciptakan komunikasi yang lebih empatik, terbuka, dan berpusat pada pasien.

g. Faktor-faktor penghambat komunikasi antar budaya

Dalam praktik komunikasi lintas budaya, terdapat berbagai faktor yang dapat menghambat efektivitas interaksi. Hambatan-hambatan ini umumnya berkaitan dengan sikap, persepsi, dan cara pandang individu terhadap budaya lain. Beberapa faktor utama yang menjadi penghambat komunikasi lintas budaya antara lain sebagai berikut:

1) Etnosentrisme

Etnosentrisme adalah kecenderungan individu atau kelompok untuk menganggap budaya sendiri sebagai yang paling benar, unggul, dan menjadi standar dalam menilai budaya lain. Sikap ini sering disertai dengan pandangan negatif terhadap kelompok yang berbeda, seperti meremehkan, menganggap asing, atau bahkan menolak keberadaan budaya lain.

Dalam konteks komunikasi, etnosentrisme dapat menyebabkan individu menilai budaya lain berdasarkan ukuran budaya sendiri, sehingga menghambat pemahaman yang objektif. Sikap ini juga dapat memunculkan solidaritas berlebihan terhadap kelompok sendiri (*in-group favoritism*) tanpa disertai sikap kritis, serta menimbulkan prasangka terhadap kelompok lain. Jika tidak dikelola dengan baik, etnosentrisme dapat berkembang menjadi sikap diskriminatif dan menjadi salah satu akar munculnya konflik antar budaya.

2) Stereotip

Stereotip merupakan gambaran atau persepsi yang disederhanakan mengenai kelompok tertentu, yang terbentuk dalam pikiran individu. Stereotip sering kali digunakan untuk mempermudah proses berpikir, namun berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam komunikasi.

Dalam praktiknya, stereotip menyebabkan individu mengelompokkan orang lain ke dalam kategori *in-group* dan *out-group*, serta cenderung lebih mengutamakan kelompoknya sendiri. Hal ini dapat mengarah pada generalisasi berlebihan, di mana penilaian terhadap seseorang didasarkan pada keanggotaan kelompoknya, bukan pada karakteristik individu.

Akibatnya, stereotip dapat memicu bias, menghambat komunikasi yang objektif, dan meningkatkan potensi konflik sosial.

3) Prasangka

Prasangka (*prejudice*) adalah sikap atau keyakinan negatif terhadap individu atau kelompok tertentu yang didasarkan pada asumsi tanpa dasar yang kuat. Prasangka biasanya disertai dengan emosi negatif, seperti ketidaksukaan, kecurigaan, atau permusuhan.

Dalam komunikasi lintas budaya, prasangka dapat memengaruhi cara seseorang menerima, menafsirkan, dan merespons pesan. Hal ini dapat berujung pada perilaku diskriminatif, sehingga menghambat terciptanya komunikasi yang efektif dan hubungan interpersonal yang harmonis.

4) Kedaerahan (Primordialisme Budaya)

Kedaerahan atau primordialisme budaya adalah sikap yang terlalu mengutamakan nilai-nilai budaya asal yang diperoleh sejak lahir, seperti adat istiadat, tradisi, bahasa, dan kepercayaan. Sikap ini dapat memperkuat identitas budaya, namun juga berpotensi menjadi hambatan jika tidak disertai keterbukaan terhadap budaya lain.

Dalam komunikasi lintas budaya, sikap kedaerahan yang berlebihan dapat menyebabkan individu sulit menerima perbedaan, kurang fleksibel, dan cenderung menolak nilai-nilai baru. Hal ini dapat menghambat proses adaptasi dan interaksi yang efektif dengan individu dari latar belakang budaya yang berbeda.

h. Strategi komunikasi antar budaya

Hambatan dalam komunikasi lintas budaya dapat diminimalkan melalui penerapan berbagai strategi yang berfokus pada peningkatan pemahaman, sensitivitas budaya, serta keterampilan komunikasi interpersonal. Strategi ini penting untuk menciptakan interaksi yang efektif dan harmonis antara individu dari latar belakang budaya yang berbeda.

1) Meningkatkan Kesadaran Budaya (Cultural Awareness)

Kesadaran budaya merupakan kemampuan individu untuk memahami, menghargai, dan menerima perbedaan nilai, norma, serta kebiasaan budaya lain. Peningkatan kesadaran ini berperan penting dalam mengurangi prasangka dan stereotip negatif, sekaligus menumbuhkan empati dalam proses komunikasi.

2) Mengembangkan Keterampilan Mendengar Aktif (Active Listening)

Mendengar secara aktif berarti memberikan perhatian penuh kepada lawan bicara tanpa melakukan penilaian secara prematur. Keterampilan ini memungkinkan individu memahami pesan secara lebih mendalam, termasuk konteks budaya yang melatarbelakangi komunikasi tersebut.

3) Menggunakan Bahasa yang Sederhana dan Jelas

Dalam komunikasi lintas budaya, penggunaan bahasa yang lugas dan mudah dipahami sangat dianjurkan. Penghindaran terhadap istilah teknis, idiom, jargon, maupun ungkapan lokal yang sulit dipahami akan membantu mengurangi potensi kesalahpahaman.

4) Memperhatikan Komunikasi Nonverbal

Unsur nonverbal seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, intonasi suara, dan kontak mata memiliki makna yang berbeda dalam setiap budaya. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk mampu mengamati dan menyesuaikan isyarat nonverbal agar sesuai dengan norma budaya lawan bicara.

5) Mengembangkan Sikap Menghargai Budaya Lain (Cultural Respect)

Upaya untuk mempelajari dan memahami nilai, norma, serta praktik budaya lain akan memperkuat efektivitas komunikasi. Sikap saling menghargai menjadi fondasi dalam membangun hubungan interpersonal yang positif dalam konteks lintas budaya.

i. Dampak komunikasi antar budaya

Komunikasi lintas budaya memberikan berbagai konsekuensi dalam kehidupan sosial masyarakat. Dampak tersebut dapat bersifat positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana individu dan kelompok mengelola perbedaan budaya dalam interaksi.

1) Dampak Positif

a) Meningkatkan Toleransi dan Saling Menghargai

Interaksi lintas budaya mendorong individu untuk lebih terbuka terhadap perbedaan nilai, norma, dan kebiasaan, sehingga tercipta sikap saling menghormati dan hidup harmonis dalam masyarakat yang beragam.

b) Memperkuat Persatuan dalam Keberagaman

Perbedaan budaya tidak menjadi penghalang, melainkan menjadi kekuatan yang memperkaya identitas kolektif. Hal ini mendukung terwujudnya integrasi sosial dalam masyarakat multikultural.

c) Memperluas Jaringan Sosial dan Kerja Sama Internasional

Komunikasi lintas budaya membuka peluang kolaborasi dalam berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan diplomasi, baik pada tingkat nasional maupun global.

d) Mendorong Kreativitas dan Inovasi

Pertukaran ide dan perspektif dari berbagai latar budaya dapat menghasilkan gagasan baru yang inovatif, terutama dalam pemecahan masalah dan pengembangan ilmu pengetahuan.

e) Meningkatkan Kemampuan Adaptasi Individu

Individu menjadi lebih fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, baik dalam konteks sosial maupun profesional.

2) Dampak Negatif

a) Terjadinya Kesalahpahaman Komunikasi

Perbedaan bahasa, simbol, serta gaya komunikasi dapat menyebabkan interpretasi yang keliru, sehingga menghambat efektivitas interaksi.

b) Munculnya Stereotip dan Prasangka

Kurangnya pemahaman terhadap budaya lain dapat memicu generalisasi negatif, yang berpotensi menimbulkan diskriminasi dan sikap etnosentris.

c) Potensi Konflik Sosial

Perbedaan nilai, norma, dan kebiasaan dapat memicu ketegangan atau konflik antarindividu maupun kelompok jika tidak dikelola dengan baik.

d) Ancaman terhadap Identitas Budaya Lokal

Dominasi budaya tertentu, terutama budaya global, dapat menyebabkan terkikisnya nilai dan tradisi lokal jika tidak diimbangi dengan upaya pelestarian budaya.

e) Terjadinya Kesenjangan Sosial

Perbedaan cara pandang, pola pikir, dan tingkat adaptasi terhadap budaya lain dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam interaksi sosial dan hubungan antar kelompok.

3) Manfaat komunikasi antar budaya

Komunikasi lintas budaya memberikan berbagai manfaat penting dalam kehidupan sosial, profesional, maupun global. Manfaat ini berkontribusi dalam meningkatkan kualitas interaksi serta memperkuat

hubungan antarindividu dan kelompok yang memiliki latar belakang budaya berbeda.

a) Meningkatkan Pemahaman Antarindividu dan Kelompok

Komunikasi lintas budaya membantu individu memahami perbedaan nilai, norma, bahasa, dan kebiasaan yang dimiliki oleh kelompok lain. Pemahaman ini berperan dalam mengurangi potensi kesalahpahaman dalam interaksi sosial.

b) Membangun Toleransi dan Sikap Saling Menghargai

Dengan mengenal dan memahami budaya lain, individu akan lebih terbuka terhadap perbedaan. Hal ini mendorong terbentuknya sikap saling menghormati yang menjadi dasar terciptanya hubungan sosial yang harmonis.

c) Memperkuat Kerja Sama

Dalam konteks organisasi maupun kehidupan bermasyarakat, komunikasi lintas budaya mempermudah koordinasi, meningkatkan efektivitas kerja tim, serta memperluas peluang kolaborasi lintas daerah maupun lintas negara.

d) Meningkatkan Kemampuan Adaptasi

Interaksi dengan berbagai budaya melatih individu untuk bersikap fleksibel, terbuka, dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, baik dalam situasi sosial maupun profesional.

e) Mencegah Konflik Sosial

Kesadaran terhadap perbedaan budaya dapat mengurangi munculnya prasangka, stereotip, dan diskriminasi. Hal ini berkontribusi dalam meminimalkan potensi konflik dalam masyarakat yang majemuk.

f) Memperkaya Wawasan dan Pengalaman

Interaksi lintas budaya memberikan kesempatan untuk memahami berbagai cara pandang, pola pikir, serta nilai kehidupan yang berbeda, sehingga memperluas perspektif dan pengalaman individu.

B. Komunikasi Sensitif Bahasa dalam Pelayanan Kesehatan

1. Definisi dan Fenomena Bahasa

Bahasa adalah hambatan paling nyata dalam pelayanan kesehatan. Komunikasi sensitif bahasa melibatkan penggunaan kata-kata sederhana, menghindari jargon, dan memastikan bahwa makna pesan diterima sama oleh kedua belah pihak. Apabila perawat dan klien tidak memiliki kesamaan bahasa,

penggunaan penerjemah yang kompeten menjadi sangat penting (Wade, 2020).

2. Model Strategi: *The LEARN Model*

Model ini sangat efektif untuk mengatasi kendala bahasa dan persepsi (Purnell & Fenkl, 2021):

- a. **Listen:** Dengarkan persepsi pasien tentang sakitnya.
- b. **Explain:** Jelaskan pandangan medis dengan bahasa awam.
- c. **Acknowledge:** Akui adanya perbedaan persepsi.
- d. **Recommend:** Berikan saran pengobatan.
- e. **Negotiate:** Sepakati rencana tindakan bersama.

3. Hasil Penelitian Terkait

Menurut studi Halter et al. (2019), pasien dengan hambatan bahasa memiliki risiko 2,5 kali lebih tinggi mengalami kejadian yang tidak diharapkan (*adverse events*) jika tidak didampingi oleh penerjemah medis resmi.

4. SOP Komunikasi dengan Pasien Kendala Bahasa (Penerjemah)

- a. **Persiapan:** Identifikasi bahasa utama pasien. Gunakan penerjemah medis bersertifikat, bukan keluarga (terutama anak-anak).
- b. **Posisi:** Duduk membentuk segitiga antara perawat, pasien, dan penerjemah.
- c. **Teknik Bicara:** Tataplah pasien secara langsung saat bicara, bukan menatap penerjemah. Gunakan kalimat pendek (10-15 kata).
- d. **Verifikasi:** Gunakan teknik *Teach-Back* (Minta pasien menjelaskan kembali instruksi melalui penerjemah).

C. Integrasi Spiritualitas dan Sensitivitas Nilai

1. Definisi Spiritualitas dalam Keperawatan

Spiritualitas adalah inti dari keberadaan manusia yang mencari makna, tujuan, dan hubungan dengan sesuatu yang transenden (Suhron, 2017). Komunikasi spiritual tidak harus membicarakan agama, melainkan memberikan ruang bagi pasien untuk mengungkapkan harapan dan ketakutan mereka.

2. Model Strategi: *FICA Spiritual Assessment Tool*

Faith: "Apa keyakinan yang menguatkan Anda?"

Importance: "Seberapa besar pengaruh keyakinan ini dalam perawatan Anda?"

Community: "Siapa orang/kelompok yang paling mendukung Anda saat ini?"

Address: "Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu kenyamanan spiritual Anda?" (Suhron, 2017).

3. Contoh Penerapan (Benar vs Salah)

Salah: Pasien bertanya "Mengapa Tuhan memberi saya penyakit ini?" Perawat menjawab: "Sabar saja, Pak, itu ujian." (Ini menutup dialog).

Benar: Perawat menjawab: "Bapak merasa ini sangat tidak adil ya? Apakah Bapak ingin menceritakan lebih lanjut apa yang Bapak rasakan saat ini?" (Ini membuka dialog spiritual) (Koenig, 2018).

4. SOP Fasilitasi Kebutuhan Spiritual Pasien

- Pengkajian:** Lakukan pengkajian FICA saat observasi awal.
- Lingkungan:** Ciptakan suasana tenang, matikan TV/gadget jika pasien ingin berdoa/meditasi.
- Kolaborasi:** Hubungi layanan pastoral atau pemuka agama sesuai permintaan pasien.
- Dokumentasi:** Catat kebutuhan spiritual spesifik (misal: posisi tempat tidur menghadap arah tertentu).

D. Latihan Terstruktur

Buatkan video komunikasi perawat-pasien menggunakan teknik LEARN untuk pasien yang menolak operasi karena dilarang oleh adat!

Jawaban

Skenario Komunikasi Teknik LEARN

Kasus:

Seorang pasien (Tuan A) menderita apendisitis akut dan harus segera dioperasi, namun ia menolak karena menurut adat di desanya, tubuh tidak boleh "dilukai" oleh besi/logam tajam karena dipercayai akan menjauhkan leluhur.

L - Listen (Dengarkan):

Perawat: "Selamat pagi, Tuan A. Saya mengerti Tuan merasa keberatan dengan rencana operasi ini. Bolehkan Tuan menceritakan lebih lanjut apa yang membuat

Tuan khawatir atau apa yang diyakini dalam keluarga Tuan mengenai prosedur ini?"

Pasien: "Di kampung saya, kami percaya tubuh itu titipan leluhur. Kalau dibedah dengan besi, leluhur akan marah dan kesembuhan tidak akan abadi."

E - Explain (Jelaskan):

Perawat: "Terima kasih sudah berbagi, Tuan. Dari sisi medis, kami melihat ada **peradangan** serius di usus buntu Tuan. Jika tidak segera diangkat, ada risiko usus tersebut pecah dan menyebabkan infeksi luas di seluruh perut yang bisa membahayakan nyawa Tuan."

A - Acknowledge (Akui):

Perawat: "Saya sangat menghargai kepercayaan Tuan dan keinginan Tuan untuk tetap menghormati leluhur. Saya paham bahwa menjaga keutuhan tubuh adalah hal yang sakral bagi Tuan."

R - Recommend (Rekomendasikan):

Perawat: "Rekomendasi kami tetap melakukan operasi untuk menyelamatkan nyawa Tuan. Namun, kami ingin mencari jalan tengah agar Tuan tetap merasa tenang secara batin."

N - Negotiate (Negosiasikan):

Perawat: "Bagaimana jika sebelum dan sesudah operasi, kami memberikan waktu bagi keluarga untuk memimpin doa atau melakukan ritual doa khusus sesuai adat Tuan di kamar ini? Kami juga akan memastikan luka bekas operasi dijahit dengan sangat rapi agar tubuh Tuan kembali utuh dan pulih. Apakah itu bisa membantu Tuan merasa lebih nyaman untuk melanjutkan operasi?"

Rubrik Penilaian Video Simulasi Teknik LEARN (RB-11)

Indikator Penilaian	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Aplikasi Teknik LEARN (L, E, A)	Mahasiswa hanya menggunakan 1-2 tahapan; komunikasi terkesan kaku atau memaksa.	Menggunakan 3 tahapan LEARN; penjelasan medis terlalu dominan dibandingkan mendengarkan.	Menggunakan tahapan Listen, Explain, Acknowledge dengan runtut; menunjukkan empati.	Mengintegrasikan L, E, A secara natural; menunjukkan pemahaman mendalam terhadap kekhawatiran pasien.

Indikator Penilaian	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Negosiasi & Rekomendasi (R, N)	Tidak memberikan solusi jalan tengah; gagal mencapai kesepakatan dengan pasien.	Memberikan rekomendasi namun negosiasi kurang akomodatif terhadap adat pasien.	Memberikan rekomendasi medis yang jelas dan negosiasi yang menghargai nilai budaya.	Rekomendasi sangat persuasif; negosiasi kreatif (misal: ruang untuk doa/ritual) dan berhasil mencapai <i>win-win solution</i> .
Sensitivitas Budaya & Bahasa	Menggunakan banyak jargon medis; nada bicara menghakimi keyakinan pasien.	Bahasa cukup dimengerti; namun masih ada kesan meremehkan kepercayaan adat.	Bahasa sederhana (bebas jargon); menunjukkan sikap menghormati (<i>respect</i>) terhadap nilai pasien.	Sangat sensitif; menggunakan bahasa yang sangat membumi; menunjukkan <i>cultural humility</i> yang tinggi.
Kualitas Komunikasi Non-Verbal	Kontak mata tidak ada; ekspresi wajah datar atau tidak ramah; kualitas video buruk.	Kontak mata dan posisi tubuh cukup baik; ekspresi kurang mendukung empati.	Kontak mata konsisten; posisi tubuh terbuka (<i>SOLER</i>); kualitas audio/video jelas.	Komunikasi non-verbal sangat empatik; gestur mendukung pesan verbal; kualitas video profesional dan kreatif.

E. Rangkuman Materi

- Kecerdasan budaya adalah kompetensi inti perawat dalam menghadapi keberagaman pasien.
- Penggunaan jargon medis harus dihindari untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mendukung literasi kesehatan pasien.
- Komunikasi spiritual yang empatik membantu pasien menemukan kekuatan dalam proses penyembuhan.
- Validasi pesan secara berulang diperlukan untuk memastikan keamanan

F. Daftar Pustaka

- Andrews, M. M., & Boyle, J. S. (2019). *Transcultural Concepts in Nursing Care* (8th ed.).
- Jones & Bartlett Learning. Purnell, L. D., & Fenkl, E. A. (2021). *Textbook for Transcultural Health Care: A Population-Focused Approach*. Springer Nature.
- Koenig, H. G. (2018). *Religion and Mental Health: Research and Clinical Applications*. Academic Press.
- Leininger, M., & McFarland, M. R. (2018). *Culture Care Diversity and Universality: A Worldwide Nursing Theory*.
- Purnell, L. D., & Fenkl, E. A. (2021). *Textbook for Transcultural Health Care: A Population-Focused Approach*. Springer Nature.
- Sarfika, R., & Sidaria. (2025). *Buku Ajar Komunikasi Keperawatan Lengkap*. Universitas Andalas: Padang.
- Suhron, M. (2017). *Asuhan Keperawatan Konsep Spiritual*. Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Wade, G. H. (2020). Cultural Competence in Nursing Communication. *Journal of Nursing Education*, 59(4), 210-215.
- Wolters Kluwer. Halter, M. J., Rolin-Kenny, D., & Grindel, C. G. (2019). Communication and Patient Safety. *Journal of Nursing Care Quality*, 34(1), 25-30.

BAB 4

KOMUNIKASI DALAM KEDARURATAN DAN KRISIS: KABAR SULIT, KONFLIK, ESKALASI

CPL	CPMK	Sub-CPMK
CPL 5 Mampu berkomunikasi efektif pada situasi sulit/krisis serta populasi khusus dengan mempertimbangkan budaya, spiritual, dan keselamatan.	CPMK 6 Menerapkan komunikasi interprofesional, kolaborasi tim, negosiasi, dan eskalasi untuk koordinasi layanan yang efektif.	12.1 Menyampaikan kabar sulit secara terstruktur dan empatik sesuai prioritas keselamatan. 12.2 Melaksanakan eskalasi konflik/krisis kepada pihak terkait dengan pesan ringkas dan fokus risiko
	CPMK 5 Menerapkan komunikasi nonverbal, validasi pesan, dan strategi komunikasi pada situasi sulit serta populasi khusus secara aman.	12.3 Menerapkan komunikasi nonverbal dan teknik validasi pesan dalam penyampaian kabar sulit serta pengelolaan konflik secara empatik dan profesional. 12.4 Menerapkan strategi komunikasi pada situasi krisis dengan mempertimbangkan kondisi psikologis, budaya, dan kebutuhan populasi khusus.
	CPMK 7 Melaksanakan handover terstruktur (SBAR, read-back, closed-loop), dokumentasi sebagai komunikasi klinis, serta refleksi untuk perbaikan praktik.	12.5 Menerapkan komunikasi eskalasi melalui handover terstruktur (SBAR, <i>read-back, closed-loop communication</i>) dalam situasi kedaruratan dan krisis. 12.6 Melaksanakan dokumentasi komunikasi klinis serta melakukan refleksi praktik untuk meningkatkan keselamatan pasien dan kualitas pelayanan.

Pendahuluan

Mutu, keselamatan, dan keberlanjutan pelayanan kesehatan sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi, khususnya dalam situasi kedaruratan dan krisis. Kompleksitas kondisi klinis, ketidakpastian prognosis, tekanan waktu, serta tingginya beban emosional pasien dan keluarga menempatkan komunikasi sebagai elemen krusial dalam pengambilan keputusan dan keselamatan pasien. Konteks ini menegaskan bahwa perawat tidak hanya berperan sebagai pelaksana asuhan, tetapi juga sebagai komunikator profesional yang mampu menjaga kejelasan informasi, stabilitas emosional, dan hubungan terapeutik di tengah situasi bertekanan tinggi. Kegagalan komunikasi pada kondisi krisis terbukti berkontribusi terhadap meningkatnya konflik, kesalahan klinis, dan penurunan kepercayaan terhadap layanan kesehatan.

Situasi krisis dan kedaruratan memunculkan respons psikologis yang intens pada pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan. Penyampaian kabar sulit, pengelolaan konflik, serta proses eskalasi keputusan sering berlangsung dalam kondisi emosi yang tidak stabil, keterbatasan waktu, dan ketimpangan informasi. Kondisi tersebut menuntut keterampilan komunikasi yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga terapeutik, empatik, dan berlandaskan prinsip etika. Perawat, khususnya perawat dengan kompetensi keperawatan jiwa, memiliki peran strategis dalam memfasilitasi komunikasi yang menenangkan, mencegah eskalasi psikologis, serta membantu individu dan keluarga beradaptasi terhadap situasi krisis yang dihadapi.

Kualitas komunikasi dalam penyampaian kabar sulit menjadi indikator penting profesionalisme layanan kesehatan. Kabar yang berkaitan dengan kondisi kritis, kegagalan terapi, atau prognosis yang buruk berpotensi menimbulkan distress emosional, penolakan, bahkan konflik terbuka apabila tidak disampaikan secara tepat. Pendekatan komunikasi yang terstruktur, sensitif terhadap kondisi psikologis, serta menghargai nilai dan budaya pasien menjadi kebutuhan mendasar dalam praktik keperawatan modern. Perawat dituntut mampu menyeimbangkan kejujuran informasi dengan empati, sekaligus mempertahankan kejelasan pesan agar tidak menimbulkan ambiguitas yang merugikan keselamatan pasien.

Konflik dalam pelayanan kesehatan sering tidak terpisahkan dari situasi krisis dan kedaruratan. Perbedaan persepsi, tekanan emosional, serta keterbatasan sumber daya dapat memicu konflik antara pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan, maupun antarprofesi. Kemampuan komunikasi yang efektif menjadi kunci dalam mencegah konflik berkembang menjadi situasi yang lebih destruktif. Perawat dengan pemahaman komunikasi krisis yang kuat mampu berperan sebagai mediator, menjaga hubungan terapeutik, serta menciptakan ruang dialog yang konstruktif. Kompetensi ini berkontribusi langsung terhadap terciptanya lingkungan pelayanan yang aman, suportif, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Komunikasi eskalasi merupakan bagian integral dari sistem keselamatan pasien dalam pelayanan kesehatan modern. Keputusan untuk meningkatkan level komunikasi kepada otoritas klinis atau manajerial membutuhkan kejelasan pesan, keberanian profesional, dan ketepatan penilaian situasional. Kegagalan melakukan eskalasi komunikasi secara tepat berdampak serius terhadap luaran klinis dan mutu pelayanan. Pemahaman mengenai prinsip, alur, dan etika komunikasi eskalasi menjadi kompetensi esensial bagi perawat dalam menghadapi situasi krisis yang dinamis dan berisiko tinggi.

Pemahaman mendalam mengenai konsep, teori, dan praktik komunikasi dalam kedaruratan dan krisis menjadi dasar penyusunan buku ini. Setiap bab dirancang secara sistematis untuk mengintegrasikan landasan teoritis keperawatan jiwa, prinsip komunikasi terapeutik, serta temuan penelitian terkini dengan realitas praktik klinik. Pembahasan mencakup konsep dasar komunikasi krisis, penyampaian kabar sulit, pengelolaan konflik, dan komunikasi eskalasi, dilengkapi dengan ilustrasi kasus dan refleksi praktik agar pembaca mampu mengembangkan kemampuan analitis dan pengambilan keputusan profesional.

Tujuan utama buku ini adalah memperkuat kapasitas perawat dalam mengelola komunikasi pada situasi kedaruratan dan krisis secara etis, empatik, dan berbasis bukti. Penguasaan komunikasi krisis diharapkan mampu meningkatkan keselamatan pasien, mengurangi konflik, serta mendukung kesejahteraan psikologis pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan. Komunikasi yang berlandaskan nilai kemanusiaan, kepekaan psikologis, dan profesionalisme menjadi fondasi penting bagi terciptanya pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan berorientasi pada kebutuhan manusia secara utuh.

A. Konsep Dasar Komunikasi dalam Situasi Kedaruratan dan Krisis

1. Definisi

Komunikasi dalam pelayanan kesehatan merupakan proses pertukaran informasi, makna, dan emosi antara tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga yang bertujuan mendukung pengambilan keputusan klinis, meningkatkan keselamatan pasien, serta memperkuat hubungan terapeutik. Proses ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mencakup dimensi afektif dan relasional yang berperan penting dalam keberhasilan asuhan keperawatan. Praktik keperawatan menempatkan komunikasi sebagai fondasi interaksi profesional yang memungkinkan perawat memahami kebutuhan pasien secara holistik, mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *Therapeutic Communication* yang menekankan penggunaan komunikasi secara sadar, terarah, dan berorientasi pada penyembuhan (Arnold & Boggs, 2020).

Komunikasi kedaruratan dalam pelayanan kesehatan merujuk pada proses penyampaian dan pertukaran informasi yang dilakukan secara cepat, tepat, dan terstruktur dalam situasi yang mengancam nyawa atau berpotensi menimbulkan kecacatan permanen. Situasi tersebut ditandai oleh keterbatasan waktu, tekanan tinggi, serta kebutuhan pengambilan keputusan secara segera. Karakteristik utama komunikasi kedaruratan meliputi kecepatan penyampaian informasi, akurasi isi pesan, kejelasan komunikasi, serta koordinasi yang efektif antar anggota tim kesehatan. Praktik klinis menunjukkan bahwa komunikasi kedaruratan sering terjadi pada kondisi seperti henti jantung, trauma berat, kegawatan obstetri, dan perawatan intensif. Komunikasi pada kondisi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi, tetapi juga sebagai mekanisme koordinasi tindakan medis yang terintegrasi untuk menjamin keselamatan pasien (*patient safety*) (Engel & Ph, 2023; Kwame & Petrucka, 2021).

Komunikasi krisis dalam pelayanan kesehatan merupakan proses komunikasi yang berlangsung dalam situasi ketidakpastian tinggi yang disertai tekanan emosional, risiko keselamatan, serta potensi dampak psikologis jangka panjang bagi pasien dan keluarga. Komunikasi ini memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan komunikasi kedaruratan karena melibatkan aspek emosional, sosial, dan etis secara simultan. Situasi yang termasuk dalam komunikasi krisis meliputi penyampaian diagnosis penyakit terminal, kejadian tidak diharapkan (*adverse events*), kematian mendadak, konflik antara keluarga dan tenaga kesehatan, serta kondisi bencana. Pendekatan komunikasi krisis berkaitan erat

dengan Crisis Communication Theory yang menekankan pentingnya transparansi, empati, dan konsistensi pesan dalam situasi yang penuh ketidakpastian (Cruz & Mariana, 2023).

Perbedaan antara komunikasi kedaruratan dan komunikasi krisis terletak pada fokus, durasi, serta pendekatan yang digunakan. Komunikasi kedaruratan berorientasi pada stabilisasi kondisi fisik pasien dalam waktu yang sangat singkat melalui pendekatan yang bersifat instruktif dan direktif. Komunikasi krisis berfokus pada stabilisasi emosional dan psikososial dengan pendekatan empatik dan suportif yang dapat berlangsung lebih lama. Praktik klinik menunjukkan bahwa kedua bentuk komunikasi ini sering terjadi secara berkesinambungan. Perawat dapat memulai dengan komunikasi kedaruratan untuk menangani kondisi akut, kemudian melanjutkan dengan komunikasi krisis saat menjelaskan kondisi pasien kepada keluarga dan membantu proses adaptasi terhadap situasi yang dihadapi (Carpenter et al., 2022; Hinata et al., 2024)

Komunikasi dalam situasi kedaruratan dan krisis memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi karena melibatkan berbagai dimensi secara bersamaan. Dimensi kognitif berkaitan dengan kemampuan memproses informasi secara cepat dan akurat dalam kondisi tekanan tinggi. Dimensi emosional mencakup respons seperti kecemasan, ketakutan, dan kesedihan yang dapat mempengaruhi penerimaan pesan. Dimensi sosial berhubungan dengan interaksi antara pasien, keluarga, dan tim kesehatan dalam konteks nilai budaya dan hubungan interpersonal. Dimensi etis mencakup kejujuran, transparansi, serta penghormatan terhadap hak pasien. Kompleksitas tersebut semakin diperkuat oleh kondisi ketidakpastian yang dijelaskan dalam Uncertainty in Illness Theory, yang menggambarkan kesulitan individu dalam memahami situasi kesehatan yang tidak dapat diprediksi. Pemahaman komprehensif mengenai komunikasi kedaruratan dan krisis memberikan implikasi penting dalam praktik keperawatan. Peningkatan keselamatan pasien (patient safety) dapat dicapai melalui penyampaian informasi yang akurat dan tepat waktu. Pengambilan keputusan klinis menjadi lebih efektif ketika komunikasi dilakukan secara jelas dan terstruktur. Risiko kesalahan komunikasi dan kejadian tidak diharapkan (adverse events) dapat diminimalkan melalui koordinasi tim yang baik. Kepuasan pasien dan keluarga meningkat ketika komunikasi dilakukan secara empatik dan responsif terhadap kebutuhan emosional. Kepercayaan terhadap tenaga kesehatan juga semakin kuat ketika komunikasi dilakukan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

2. Karakteristik situasi krisis dan dampaknya terhadap respon psikologis individu dan keluarga

Situasi krisis dalam pelayanan kesehatan merupakan kondisi yang ditandai oleh ketidakpastian tinggi, ancaman terhadap keselamatan jiwa, serta tekanan waktu yang menuntut pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Karakteristik situasi kritis antara lain sebagai berikut (Bscn & Nurse, 2023; Vaz, 2021):

a. Kompleksitas masalah dan keterbatasan informasi

Situasi krisis ditandai oleh kompleksitas masalah yang tinggi serta keterbatasan informasi yang tersedia pada saat pengambilan keputusan. Informasi yang tidak lengkap atau berubah secara cepat menuntut tenaga kesehatan untuk melakukan interpretasi klinis secara tepat dalam waktu yang singkat. Kondisi ini meningkatkan risiko ketidakpastian dalam tindakan serta memerlukan kemampuan berpikir kritis dan komunikasi yang efektif antar tim.

b. Perubahan kondisi yang dinamis dan tidak terprediksi

Situasi krisis menunjukkan perubahan kondisi pasien yang berlangsung cepat dan tidak dapat diprediksi. Lingkungan klinis seperti unit gawat darurat, ruang intensif, maupun situasi bencana memperlihatkan bahwa tenaga kesehatan harus mampu merespons perubahan secara simultan. Karakteristik ini sejalan dengan Crisis Communication Theory yang menekankan adanya ancaman serius, ketidakpastian, serta kebutuhan respons segera (Coombs, 2022).

c. Tekanan waktu dan konsekuensi klinis yang tinggi

Keterbatasan waktu dalam situasi krisis menuntut pengambilan keputusan yang cepat dengan konsekuensi yang signifikan terhadap *outcome* klinis. Kesalahan dalam komunikasi atau keterlambatan respons dapat berdampak langsung pada keselamatan pasien. Tekanan ini menjadikan komunikasi sebagai elemen kunci dalam koordinasi tindakan medis yang efektif.

d. Tekanan emosional yang tinggi

Situasi krisis ditandai oleh tingginya tekanan emosional baik pada pasien maupun keluarga. Ancaman kehilangan, ketidakpastian prognosis, serta keterbatasan kontrol terhadap situasi memicu respons emosional yang intens. Kondisi ini mempengaruhi cara individu menerima informasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan.

Karakteristik situasi krisis yang ditandai oleh kompleksitas masalah, ketidakpastian, tekanan waktu, serta intensitas emosional yang tinggi tidak hanya mempengaruhi proses klinis, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap kondisi psikologis individu dan keluarga. Kombinasi faktor-faktor tersebut menciptakan pengalaman yang menekan secara kognitif maupun emosional, sehingga memengaruhi cara individu memahami informasi, merespons situasi, serta mengambil keputusan. Dampak yang muncul tidak bersifat tunggal, melainkan berkembang secara multidimensional dan dapat memengaruhi stabilitas emosional, hubungan interpersonal, serta dinamika pengambilan keputusan dalam keluarga. Dampak tersebut di antara lain adalah sebagai berikut (Girotti et al., 2024; Hudson & Marie-, 2024):

a. Respon emosional individu sebagai mekanisme koping awal

Individu dalam situasi krisis dapat menunjukkan berbagai respons emosional seperti syok, penolakan (*denial*), kecemasan, ketakutan, hingga kemarahan. Respon tersebut merupakan bagian dari mekanisme koping awal terhadap stres yang ekstrem. Proses ini berkaitan dengan teori stres dan koping yang menjelaskan bahwa individu melakukan penilaian kognitif terhadap ancaman serta menggunakan strategi tertentu untuk mengelola stresor (Lazarus & Folkman, 1984).

b. Gangguan proses kognitif dan pemahaman informasi

Tekanan psikologis yang tinggi dapat mengganggu kemampuan individu dalam memproses informasi secara rasional. Konsentrasi menjadi menurun, perhatian menyempit, serta kemampuan memahami informasi menjadi terbatas. Kondisi ini meningkatkan risiko miskomunikasi, kesalahpahaman, dan pengambilan keputusan yang kurang optimal. Fenomena ini berkaitan dengan Uncertainty in Illness Theory yang menjelaskan bahwa individu mengalami kesulitan dalam memaknai situasi kesehatan yang tidak dapat diprediksi (Mishel, 1988).

c. Dampak psikologis kompleks pada keluarga

Keluarga dalam situasi krisis menghadapi tekanan psikologis yang lebih kompleks karena harus berperan dalam pengambilan keputusan sekaligus menghadapi kondisi anggota keluarga yang sakit. Respons yang muncul dapat berupa kecemasan yang intens, perasaan bersalah, kebingungan, hingga konflik baik dengan tenaga kesehatan maupun antar anggota keluarga. Kondisi ini sering diperburuk oleh kurangnya informasi yang jelas dan konsisten, sehingga meningkatkan ketegangan emosional (Back et al., 2020).

d. Munculnya konflik interpersonal dan sosial

Situasi krisis berpotensi menimbulkan konflik antara keluarga dengan tenaga kesehatan maupun antar anggota keluarga. Perbedaan persepsi, keterbatasan informasi, serta tekanan emosional menjadi faktor pemicu utama konflik. Kondisi ini dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan memperburuk hubungan terapeutik jika tidak dikelola dengan komunikasi yang efektif.

e. Pengaruh budaya, nilai, dan sistem kepercayaan

Respon individu dan keluarga dalam situasi krisis dipengaruhi oleh latar belakang budaya, nilai, dan sistem kepercayaan. Konteks masyarakat kolektif menunjukkan bahwa pengambilan keputusan sering melibatkan keluarga besar, sehingga komunikasi menjadi lebih kompleks. Persepsi terhadap penyakit, kematian, dan intervensi medis mempengaruhi cara individu dan keluarga merespons krisis, sehingga diperlukan pendekatan komunikasi yang sensitif terhadap aspek budaya dan spiritual.

Karakteristik situasi krisis yang melibatkan tekanan tinggi, ketidakpastian, dan respon emosional yang intens menuntut tenaga kesehatan, khususnya perawat, untuk memiliki kemampuan komunikasi yang adaptif dan responsif. Kemampuan ini mencakup penyampaian informasi secara jelas dan terstruktur, pengelolaan emosi pasien dan keluarga, serta kemampuan membangun hubungan terapeutik dalam waktu yang terbatas. Pemahaman terhadap karakteristik krisis dan dampak psikologisnya menjadi landasan penting dalam mengembangkan strategi komunikasi yang efektif untuk mendukung stabilitas emosional dan pengambilan keputusan yang tepat dalam pelayanan kesehatan (Bscn & Nurse, 2023; Girotti et al., 2024; Hudson & Marie-, 2024; Vaz, 2021).

3. Prinsip-prinsip komunikasi efektif pada kondisi tekanan tinggi

Komunikasi dalam kondisi tekanan tinggi merupakan proses yang menuntut ketepatan, kejelasan, serta sensitivitas emosional dalam waktu yang sangat terbatas. Situasi seperti kedaruratan dan krisis sering kali melibatkan ketidakpastian, beban kerja tinggi, serta respon emosional yang intens, sehingga komunikasi yang tidak efektif berpotensi meningkatkan risiko kesalahan klinis dan menurunkan keselamatan pasien. Prinsip komunikasi dalam kondisi ini tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga mencakup kemampuan mengelola emosi, membangun kepercayaan, serta memastikan pemahaman yang akurat antara tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga (Engel & Ph, 2023; Forte et al., 2024; Lee et al., 2023).

a. Kejelasan dan akurasi informasi

Komunikasi pada kondisi tekanan tinggi harus disampaikan secara jelas, ringkas, dan akurat untuk menghindari kesalahpahaman. Informasi yang ambigu atau tidak lengkap dapat meningkatkan risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan klinis. Penggunaan bahasa yang sederhana dan terstruktur menjadi penting agar pesan dapat dipahami dengan cepat oleh semua pihak yang terlibat. Prinsip ini sejalan dengan standar keselamatan pasien yang menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dalam mencegah *medical error*.

b. Ketepatan waktu (*timeliness*)

Penyampaian informasi harus dilakukan secara tepat waktu tanpa penundaan yang tidak perlu. Keterlambatan komunikasi dalam situasi krisis dapat berdampak serius terhadap kondisi pasien. Informasi yang disampaikan secara cepat memungkinkan tim kesehatan untuk segera melakukan tindakan yang diperlukan serta mengurangi ketidakpastian yang dialami pasien dan keluarga.

c. Konsistensi dan kesinambungan informasi

Pesan yang disampaikan oleh tenaga kesehatan harus konsisten dan tidak saling bertentangan. Ketidakkonsistenan informasi dapat menimbulkan kebingungan, kecemasan, serta menurunkan kepercayaan pasien dan keluarga terhadap tim kesehatan. Koordinasi antar anggota tim menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan komunikasi, terutama dalam situasi yang melibatkan banyak profesi kesehatan.

d. Empati dan sensitivitas emosional

Komunikasi efektif dalam kondisi tekanan tinggi memerlukan kemampuan untuk menunjukkan empati dan memahami kondisi emosional pasien serta keluarga. Pendekatan empatik membantu menurunkan kecemasan, meningkatkan rasa aman, serta memperkuat hubungan terapeutik. Kemampuan ini merupakan bagian dari Therapeutic Communication yang menekankan pentingnya respon emosional yang tepat dalam interaksi keperawatan.

e. Adaptasi terhadap kondisi dan kebutuhan individu

Setiap individu memiliki tingkat pemahaman, latar belakang budaya, serta respon emosional yang berbeda. Komunikasi harus disesuaikan dengan kondisi pasien dan keluarga, termasuk penggunaan bahasa yang sesuai, mempertimbangkan nilai budaya, serta memperhatikan kesiapan emosional dalam menerima informasi. Pendekatan ini membantu meningkatkan efektivitas komunikasi dan mencegah terjadinya resistensi.

f. Penguatan umpan balik (*feedback*)

Komunikasi yang efektif memerlukan adanya umpan balik untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan telah dipahami dengan benar. Tenaga kesehatan perlu memberikan kesempatan kepada pasien dan keluarga untuk mengajukan pertanyaan serta mengklarifikasi informasi. Proses ini penting untuk mengurangi kesalahan persepsi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

g. Pengelolaan komunikasi dalam tim (*team communication*)

Komunikasi dalam kondisi tekanan tinggi tidak hanya terjadi antara perawat dengan pasien atau keluarga, tetapi juga antar tenaga kesehatan. Koordinasi tim yang efektif memerlukan komunikasi yang terstruktur dan sistematis. Pendekatan seperti *closed-loop communication* dan penggunaan alat komunikasi standar seperti SBAR (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*) dapat meningkatkan akurasi dan keselamatan dalam praktik klinis.

4. Peran perawat sebagai komunikator profesional dalam situasi krisis

Perawat memiliki peran strategis sebagai komunikator profesional dalam situasi krisis karena berada pada garis terdepan pelayanan dan memiliki intensitas interaksi yang tinggi dengan pasien dan keluarga. Situasi krisis yang ditandai oleh ketidakpastian, tekanan emosional, dan kebutuhan pengambilan keputusan cepat menempatkan komunikasi sebagai kompetensi inti yang menentukan keberhasilan asuhan keperawatan. Perawat tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator pemahaman, pengelola emosi, serta penghubung antara pasien, keluarga, dan tim kesehatan menurut (Barnes et al., 2024; Guo et al., 2024; Yoo et al., 2020) antara lain sebagai berikut.

a. Perawat sebagai penyampai informasi klinis yang akurat dan terpercaya

Perawat menyampaikan informasi kondisi pasien secara jelas, jujur, dan mudah dipahami dengan tetap menjaga akurasi data klinis.

b. Perawat sebagai fasilitator komunikasi antara tim kesehatan dan keluarga

Perawat berperan sebagai penghubung yang memastikan konsistensi informasi antara tim kesehatan dan keluarga.

c. Perawat sebagai pemberi dukungan emosional

Perawat memberikan empati, mendengarkan aktif, dan validasi perasaan sebagai bagian dari Therapeutic Communication untuk menurunkan kecemasan.

d. Perawat sebagai advokat pasien

Perawat memastikan hak, kebutuhan, dan keputusan pasien dihormati serta membantu keluarga memahami pilihan tindakan.

e. Perawat sebagai pengelola komunikasi dalam kondisi tekanan tinggi

Perawat mengatur komunikasi secara tenang, fokus, dan terstruktur, termasuk menggunakan *closed-loop communication*.

f. Perawat sebagai pengendali potensi konflik

Perawat mengidentifikasi dan meredakan konflik melalui komunikasi de-eskalatif untuk menjaga hubungan terapeutik.

g. Perawat sebagai komunikator yang sensitif terhadap budaya dan nilai

Perawat menyesuaikan komunikasi dengan budaya dan keyakinan pasien agar pesan dapat diterima dengan baik.

Peran tersebut menunjukkan bahwa perawat mengintegrasikan kemampuan kognitif, emosional, dan sosial dalam komunikasi untuk mendukung keselamatan pasien dan kualitas pelayanan.

A. Landasan Teoretis dan Etik Komunikasi Krisis

1. Perspektif teori keperawatan dalam komunikasi krisis

Perspektif keperawatan menempatkan komunikasi sebagai sarana utama dalam memahami respons emosional dan perilaku individu saat menghadapi situasi krisis. Kondisi krisis sering memunculkan kecemasan, ketakutan, dan ketidakpastian yang dapat memengaruhi kemampuan individu dalam berpikir dan mengambil keputusan. Pendekatan keperawatan jiwa membantu perawat mengidentifikasi kebutuhan psikologis pasien serta memberikan intervensi komunikasi yang sesuai dengan kondisi emosional yang dialami.

Teori seperti Peplau Interpersonal Relations Theory menekankan pentingnya hubungan terapeutik antara perawat dan pasien sebagai proses interpersonal yang dinamis. Hubungan ini memungkinkan perawat membangun kepercayaan, menciptakan rasa aman, serta membantu pasien dan keluarga dalam mengelola kecemasan dan beradaptasi terhadap situasi krisis. Pendekatan ini memperkuat peran komunikasi sebagai bagian integral dari intervensi keperawatan (Cuidarte, 2024).

2. Pendekatan komunikasi terapeutik pada kondisi akut dan darurat

Komunikasi terapeutik pada kondisi akut dan darurat menuntut perawat untuk mampu menyampaikan informasi secara cepat, jelas, dan terstruktur tanpa mengabaikan aspek emosional pasien dan keluarga. Situasi yang penuh tekanan sering kali membatasi waktu interaksi, sehingga perawat perlu menggunakan komunikasi yang fokus dan efektif agar pesan dapat dipahami dengan baik dalam waktu singkat.

Penerapan Therapeutic Communication dalam kondisi ini mencakup teknik mendengarkan aktif, validasi emosi, serta pemberian informasi secara bertahap sesuai kesiapan individu. Pendekatan ini membantu menurunkan kecemasan, meningkatkan rasa percaya, serta mendukung stabilitas emosional pasien dan keluarga meskipun berada dalam situasi yang kritis.

3. Prinsip etik

Komunikasi dalam situasi krisis harus berlandaskan prinsip etik yang menjadi pedoman dalam praktik keperawatan profesional. Prinsip otonomi menekankan penghormatan terhadap hak pasien dalam menentukan pilihan

terkait perawatan yang dijalani. Beneficence dan non-maleficence mengarahkan perawat untuk memberikan manfaat terbaik serta menghindari tindakan yang dapat merugikan pasien.

Prinsip keadilan menuntut perawat untuk memberikan pelayanan secara adil tanpa diskriminasi, sedangkan veracity menekankan pentingnya kejujuran dalam penyampaian informasi. Penerapan prinsip-prinsip ini membantu menjaga integritas profesional, memperkuat hubungan terapeutik, serta meningkatkan kepercayaan pasien dan keluarga dalam situasi krisis (Mercan & Mersin, 2025).

4. Aspek hukum dan tanggung jawab profesional dalam komunikasi krisis

Komunikasi dalam situasi krisis memiliki implikasi hukum yang erat kaitannya dengan tanggung jawab profesional perawat. Setiap informasi yang disampaikan harus sesuai dengan kondisi klinis, tidak menyesatkan, serta didukung oleh dokumentasi yang akurat. Kesalahan dalam komunikasi dapat berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, terutama jika berdampak pada keselamatan pasien.

Perawat dituntut untuk memahami batas kewenangan, menjaga kerahasiaan pasien, serta mematuhi standar praktik dan regulasi yang berlaku. Tanggung jawab profesional ini mencakup kemampuan untuk berkomunikasi secara etis, legal, dan aman, sehingga setiap tindakan komunikasi yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional maupun hukum.

B. Komunikasi Kabar Sulit (*Breaking Bad News*)

1. Definisi

Komunikasi kabar sulit (breaking bad news) merupakan proses penyampaian informasi yang secara signifikan mengubah persepsi individu terhadap masa depan, terutama terkait kondisi kesehatan, prognosis, atau kemungkinan kematian. Kabar sulit tidak hanya berkaitan dengan isi informasi yang disampaikan, tetapi juga dampak emosional yang ditimbulkan pada pasien dan keluarga.

Makna “kabar sulit” bersifat subjektif karena dipengaruhi oleh nilai, pengalaman, dan harapan individu. Informasi yang bagi tenaga kesehatan bersifat rutin dapat menjadi peristiwa yang sangat mengguncang bagi pasien dan keluarga. Kondisi ini menuntut tenaga kesehatan untuk memahami konteks psikologis penerima informasi sebelum menyampaikan pesan.

Penyampaian kabar sulit menekankan keseimbangan antara kejujuran (truth-telling) dan empati. Informasi harus disampaikan secara akurat tanpa

menghilangkan sensitivitas terhadap kondisi emosional pasien. Pendekatan yang tidak tepat dapat meningkatkan distress, sedangkan komunikasi yang efektif dapat membantu proses adaptasi dan penerimaan (Carpenter et al., 2022; Cruz & Mariana, 2023).

2. Ruang lingkup kabar sulit dalam pelayanan kesehatan

Ruang lingkup kabar sulit dalam pelayanan kesehatan mencakup berbagai situasi yang memiliki implikasi serius terhadap kondisi fisik, psikologis, maupun sosial pasien. Situasi tersebut meliputi diagnosis penyakit kronis atau terminal, penurunan kondisi pasien, kegagalan terapi, serta kejadian tidak diharapkan (adverse events).

Kabar sulit juga mencakup penyampaian informasi terkait kematian, perubahan rencana perawatan, serta keputusan end-of-life care. Kompleksitas situasi ini menuntut tenaga kesehatan untuk mampu menyesuaikan cara penyampaian informasi dengan kondisi klinis dan kesiapan emosional pasien serta keluarga.

3. Dampak psikologis penyampaian kabar sulit pada pasien dan keluarga

Penyampaian kabar sulit dapat menimbulkan respons psikologis yang kompleks pada pasien, seperti syok, penolakan (denial), kecemasan, kesedihan, hingga kemarahan. Respons tersebut merupakan bentuk reaksi normal terhadap informasi yang mengancam harapan dan stabilitas emosional individu.

Dampak psikologis tidak hanya memengaruhi aspek emosional, tetapi juga kemampuan kognitif dalam memahami informasi dan mengambil keputusan. Pasien sering mengalami kesulitan dalam memproses informasi secara rasional setelah menerima kabar sulit, sehingga membutuhkan pendekatan komunikasi yang bertahap dan suportif.

Keluarga juga mengalami tekanan emosional yang signifikan karena harus menghadapi kondisi pasien sekaligus berperan dalam pengambilan keputusan. Perasaan bersalah, kebingungan, dan konflik internal sering muncul, terutama ketika informasi yang diterima tidak sepenuhnya dipahami atau tidak disampaikan secara konsisten. Kondisi ini menegaskan pentingnya komunikasi yang empatik dan berkelanjutan dalam mendukung stabilitas psikologis keluarga.

4. Model dan tahapan komunikasi kabar sulit

Penyampaian kabar sulit memerlukan pendekatan yang terstruktur agar informasi dapat disampaikan secara sistematis dan efektif. Salah satu model yang banyak digunakan adalah SPIKES Protocol yang terdiri dari tahapan persiapan, eksplorasi pemahaman pasien, penyampaian informasi, respon terhadap emosi, serta perencanaan tindak lanjut. Pendekatan terstruktur membantu tenaga kesehatan menjaga alur komunikasi, menghindari kesalahan penyampaian, serta memastikan bahwa pasien dan keluarga memahami informasi yang diberikan. Model ini juga menekankan pentingnya empati dan keterlibatan aktif pasien dalam proses komunikasi (Setyawati et al., 2024).

5. Keterampilan verbal dan nonverbal

Keterampilan verbal dalam komunikasi kabar sulit mencakup kemampuan memilih kata yang tepat, menggunakan bahasa yang sederhana, serta menghindari istilah medis yang sulit dipahami. Penyampaian informasi secara bertahap memungkinkan pasien dan keluarga memproses informasi secara lebih efektif.

Keterampilan nonverbal memiliki peran yang tidak kalah penting dalam memperkuat pesan yang disampaikan. Kontak mata, ekspresi wajah, nada suara, serta bahasa tubuh mencerminkan empati dan kepedulian tenaga kesehatan terhadap kondisi pasien. Konsistensi antara komunikasi verbal dan nonverbal meningkatkan kepercayaan serta membantu pasien merasa didukung secara emosional. Ketidaksesuaian antara keduanya dapat menimbulkan kebingungan dan mengurangi efektivitas komunikasi.

6. Peran perawat

Perawat memiliki peran penting dalam mendampingi respon emosional pasien dan keluarga setelah penyampaian kabar sulit. Situasi ini sering memunculkan reaksi seperti syok, kecemasan, kesedihan, hingga kemarahan yang dapat mempengaruhi kemampuan individu dalam memahami informasi dan mengambil keputusan. Kehadiran perawat sebagai tenaga kesehatan yang paling dekat dengan pasien memberikan peluang untuk membangun hubungan terapeutik dan menciptakan rasa aman di tengah kondisi yang penuh tekanan (Engel & Ph, 2023; Wahyuni et al., 2023).

a. Membangun hubungan terapeutik dan rasa aman

Perawat memiliki peran penting dalam menciptakan hubungan terapeutik yang dilandasi kepercayaan dan rasa aman bagi pasien serta

keluarga. Kehadiran perawat secara konsisten di tengah situasi krisis membantu menurunkan ketegangan emosional dan memberikan dukungan psikologis awal. Interaksi yang hangat dan profesional memungkinkan pasien dan keluarga merasa didampingi dalam menghadapi kondisi yang penuh tekanan.

b. Memberikan dukungan emosional secara empatik

Pendampingan emosional dilakukan melalui komunikasi empatik yang mencakup mendengarkan aktif, validasi perasaan, serta respons yang tidak menghakimi. Pendekatan ini merupakan bagian dari Therapeutic Communication yang membantu individu mengelola kecemasan, kesedihan, dan ketakutan. Respons empatik dari perawat berperan dalam meningkatkan stabilitas emosional pasien dan keluarga.

c. Membantu pemahaman informasi secara bertahap

Perawat berperan dalam menjelaskan kembali informasi medis dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Kondisi emosional yang intens sering menghambat kemampuan pasien dan keluarga dalam memproses informasi. Pendampingan ini memastikan bahwa informasi dipahami secara adekuat sehingga mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

d. Memfasilitasi ekspresi emosi secara konstruktif

Perawat memberikan ruang bagi pasien dan keluarga untuk mengekspresikan perasaan tanpa interupsi. Proses ini membantu individu mengelola emosi secara lebih adaptif serta mencegah penumpukan emosi yang dapat memicu konflik. Pendekatan ini juga mendukung proses penerimaan terhadap kondisi yang dihadapi.

e. Memantau dan menyesuaikan dukungan emosional secara berkelanjutan

Peran perawat tidak berhenti pada respons awal, tetapi berlanjut sesuai dengan perkembangan kondisi pasien dan keluarga. Pemantauan terhadap perubahan respon emosional memungkinkan perawat menyesuaikan bentuk dukungan yang diberikan. Pendampingan yang berkelanjutan berkontribusi terhadap stabilitas psikologis serta kualitas pengalaman pasien dan keluarga dalam situasi krisis.

7. Tantangan dan kesalahan umum dalam komunikasi kabar sulit

Komunikasi kabar sulit menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan waktu, tekanan emosional, serta perbedaan latar belakang budaya dan tingkat pemahaman pasien. Kondisi ini dapat mempengaruhi

efektivitas komunikasi serta meningkatkan risiko miskomunikasi. Kesalahan umum yang sering terjadi meliputi penggunaan bahasa medis yang sulit dipahami, penyampaian informasi secara terlalu cepat, kurangnya empati, serta tidak memberikan kesempatan bagi pasien dan keluarga untuk merespons. Ketidakkonsistenan informasi antar tenaga kesehatan juga dapat menimbulkan kebingungan.

Tantangan lain yang sering muncul adalah ketidaknyamanan tenaga kesehatan dalam menyampaikan kabar sulit, sehingga komunikasi menjadi kurang optimal. Penguasaan keterampilan komunikasi serta penggunaan pendekatan terstruktur menjadi penting untuk meminimalkan kesalahan dan meningkatkan kualitas komunikasi dalam situasi ini.

C. Komunikasi Kabar Konflik

1. Konsep Konflik dalam Pelayanan Kesehatan

Konflik dalam pelayanan kesehatan merupakan kondisi ketidaksesuaian atau pertentangan yang terjadi antara individu, kelompok, maupun profesi akibat perbedaan persepsi, nilai, kepentingan, atau tujuan dalam proses pelayanan. Konflik tidak selalu bersifat negatif, tetapi dapat menjadi bagian dari dinamika interaksi yang kompleks dalam lingkungan pelayanan kesehatan yang sarat tekanan, ketidakpastian, dan tuntutan keputusan cepat. Dalam praktik keperawatan, konflik sering muncul sebagai konsekuensi dari interaksi intensif antara perawat, pasien, keluarga, dan tim kesehatan lainnya.

Konflik dalam konteks pelayanan kesehatan memiliki karakteristik yang khas karena berkaitan langsung dengan keselamatan pasien, kualitas pelayanan, serta aspek emosional yang tinggi. Situasi seperti keterbatasan sumber daya, perbedaan pendapat klinis, serta ekspektasi keluarga yang tidak selaras dengan kondisi medis dapat memicu terjadinya konflik. Kondisi ini menuntut tenaga kesehatan, khususnya perawat, untuk mampu mengelola konflik secara konstruktif melalui komunikasi yang efektif dan profesional.

Berdasarkan tingkat dan pihak yang terlibat, konflik dalam pelayanan kesehatan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Konflik intrapersonal terjadi dalam diri individu, misalnya ketika perawat mengalami dilema antara tuntutan profesional dan kondisi emosional pribadi. Konflik interpersonal terjadi antara dua individu atau lebih, seperti antara perawat dengan pasien atau keluarga. Konflik interprofesional terjadi antar tenaga kesehatan dengan latar belakang profesi yang berbeda, misalnya antara perawat dan dokter dalam pengambilan keputusan klinis.

Pemahaman terhadap jenis konflik ini penting untuk menentukan pendekatan komunikasi yang tepat dalam penyelesaiannya. Setiap jenis konflik memiliki karakteristik dan dinamika yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi penanganan yang spesifik. Konflik intrapersonal memerlukan refleksi diri dan regulasi emosi, konflik interpersonal membutuhkan komunikasi asertif dan empatik, sedangkan konflik interprofesional memerlukan koordinasi dan kolaborasi yang efektif. Konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak negatif terhadap hubungan kerja, kepuasan pasien, serta keselamatan pelayanan. Sebaliknya, konflik yang dikelola secara konstruktif dapat meningkatkan kualitas komunikasi, memperkuat kerja sama tim, serta mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik. Oleh karena itu, konflik perlu dipahami sebagai fenomena yang tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola secara profesional melalui pendekatan komunikasi yang tepat.

2. Faktor pemicu konflik pada situasi krisis dan kedaruratan

Konflik dalam situasi krisis dan kedaruratan sering muncul sebagai akibat dari kondisi yang kompleks, penuh tekanan, serta ditandai oleh ketidakpastian tinggi. Lingkungan pelayanan yang dinamis, keterbatasan waktu, serta risiko terhadap keselamatan pasien menciptakan situasi yang rentan terhadap perbedaan persepsi dan miskomunikasi. Kondisi ini menjadikan konflik sebagai fenomena yang sulit dihindari dalam praktik klinis, terutama pada unit dengan intensitas tinggi seperti instalasi gawat darurat dan ruang perawatan intensif.

a. Faktor individu

Faktor individu menjadi salah satu pemicu utama konflik yang berkaitan dengan kondisi emosional dan psikologis. Stres, kecemasan, kelelahan, serta tekanan dalam pengambilan keputusan dapat mempengaruhi cara individu berkomunikasi dan merespons situasi. Pasien dan keluarga yang berada dalam kondisi emosional tidak stabil cenderung lebih sensitif terhadap informasi yang disampaikan, sehingga meningkatkan potensi konflik.

b. Faktor komunikasi

Faktor komunikasi berperan signifikan dalam memicu konflik, terutama ketika informasi yang disampaikan tidak jelas, tidak lengkap, atau tidak konsisten antar tenaga kesehatan. Penggunaan istilah medis yang sulit dipahami serta kurangnya empati dalam penyampaian informasi dapat memperburuk kondisi emosional pasien dan keluarga. Miskomunikasi dalam tim kesehatan juga dapat menyebabkan kesalahan persepsi yang berdampak pada hubungan kerja dan kualitas pelayanan.

c. Faktor sistem dan organisasi

Faktor sistem dan organisasi turut berkontribusi dalam munculnya konflik melalui keterbatasan sumber daya, beban kerja yang tinggi, serta kurangnya koordinasi antar profesi. Kondisi ini meningkatkan tekanan dalam lingkungan kerja dan sering memicu perbedaan prioritas serta keputusan klinis. Ketidaksesuaian antara harapan keluarga dengan kebijakan atau prosedur pelayanan juga dapat memperkuat potensi konflik.

d. Faktor budaya dan nilai

Faktor budaya dan nilai mempengaruhi cara individu dan keluarga memahami serta merespons situasi krisis. Perbedaan latar belakang budaya, keyakinan, serta persepsi terhadap penyakit dan pengobatan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Ketidaksensitifan terhadap aspek budaya dapat memperburuk hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien dan keluarga.

Pemahaman terhadap berbagai faktor pemicu konflik menjadi dasar penting dalam mengembangkan strategi komunikasi yang efektif. Identifikasi faktor-faktor tersebut memungkinkan tenaga kesehatan melakukan pencegahan serta pengelolaan konflik secara lebih tepat dan profesional dalam situasi krisis dan kedaruratan.

3. Strategi Komunikasi dalam Pencegahan dan Resolusi Konflik

Strategi komunikasi dalam pencegahan dan resolusi konflik merupakan pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengurangi potensi konflik serta mengelola konflik yang telah terjadi secara konstruktif. Situasi krisis dan kedaruratan yang ditandai oleh tekanan tinggi dan ketidakpastian menuntut tenaga kesehatan untuk menggunakan komunikasi yang efektif, terarah, dan empatik agar konflik tidak berkembang menjadi lebih kompleks.

a. Komunikasi yang jelas, terbuka, dan konsisten

Penyampaian informasi yang jelas, terbuka, dan konsisten menjadi dasar dalam mencegah konflik. Informasi yang tidak lengkap atau berbeda antar tenaga kesehatan dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan. Komunikasi yang transparan membantu membangun kepercayaan serta mengurangi kesalahpahaman antara tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga.

b. Penggunaan active listening dan klarifikasi

Kemampuan mendengarkan secara aktif memungkinkan tenaga kesehatan memahami perspektif, kebutuhan, dan emosi pihak lain secara lebih mendalam. Proses klarifikasi terhadap informasi yang diterima membantu menghindari kesalahan persepsi. Pendekatan ini juga menunjukkan penghargaan terhadap individu sehingga dapat menurunkan ketegangan dalam situasi konflik.

c. Komunikasi asertif dan profesional

Komunikasi asertif memungkinkan tenaga kesehatan menyampaikan pendapat atau informasi secara tegas namun tetap menghargai pihak lain. Pendekatan ini membantu menjaga keseimbangan antara kepentingan profesional dan hubungan interpersonal. Komunikasi yang tidak asertif atau terlalu agresif dapat memperburuk konflik dan menghambat proses penyelesaian.

d. Regulasi emosi dan empati dalam komunikasi

Kemampuan mengelola emosi menjadi kunci dalam mencegah eskalasi konflik. Tenaga kesehatan perlu menjaga ketenangan, menghindari respons impulsif, serta menunjukkan empati terhadap kondisi emosional pasien dan keluarga. Pendekatan ini sejalan dengan Therapeutic Communication yang menekankan pentingnya respons emosional yang tepat dalam interaksi keperawatan.

e. Teknik de-eskalasi komunikasi

Teknik de-eskalasi digunakan untuk meredakan ketegangan dalam situasi konflik yang sudah terjadi. Pendekatan ini mencakup penggunaan nada suara yang tenang, bahasa tubuh yang tidak mengancam, serta pemilihan kata yang tidak provokatif. De-eskalasi membantu menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk dialog dan penyelesaian masalah.

f. Kolaborasi dan negosiasi dalam penyelesaian konflik

Penyelesaian konflik memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan semua pihak terkait. Negosiasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama tanpa mengorbankan keselamatan pasien. Komunikasi yang terbuka dan saling menghargai menjadi kunci dalam proses ini.

Strategi komunikasi dalam pencegahan dan resolusi konflik menekankan pentingnya integrasi antara keterampilan kognitif, emosional, dan sosial. Penerapan strategi yang tepat tidak hanya membantu menyelesaikan konflik, tetapi juga meningkatkan kualitas hubungan kerja, kepuasan pasien, serta keselamatan pelayanan dalam situasi krisis dan kedaruratan.

4. Peran perawat sebagai mediator dan advokat pasien

Perawat berperan sebagai mediator dan advokat pasien dalam situasi konflik, terutama pada kondisi krisis yang penuh tekanan dan ketidakpastian. Posisi perawat yang memiliki interaksi intens dengan pasien dan keluarga menjadikannya sebagai penghubung utama dalam menjaga komunikasi yang efektif, empatik, dan profesional. Sebagai mediator, perawat menjembatani perbedaan persepsi antara pasien, keluarga, dan tim kesehatan melalui komunikasi yang terbuka dan objektif. Perawat juga berperan dalam meredakan ketegangan menggunakan teknik komunikasi de-eskalatif agar konflik tidak berkembang dan tetap kondusif untuk proses pengambilan keputusan.

Sebagai advokat pasien, perawat memastikan bahwa hak, kebutuhan, dan preferensi pasien tetap dihormati dalam setiap tindakan. Perawat membantu pasien dan keluarga memahami informasi yang diberikan serta mendukung pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai dan kepentingan pasien.

D. Komunikasi Kabar Eskalasi (*Escalation Communication*)

1. Konsep dan Indikasi Eskalasi Komunikasi

Eskalasi komunikasi dalam pelayanan kesehatan merupakan proses penyampaian informasi secara bertingkat kepada pihak yang memiliki kewenangan lebih tinggi ketika kondisi pasien menunjukkan perburukan atau terdapat risiko terhadap keselamatan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan klinis yang tepat dapat diambil secara cepat dan terkoordinasi, terutama dalam situasi krisis dan kedaruratan yang ditandai oleh ketidakpastian dan tekanan tinggi.

Indikasi eskalasi komunikasi meliputi perubahan kondisi klinis yang signifikan, kegagalan respons terhadap terapi, serta munculnya tanda bahaya yang mengancam keselamatan pasien. Indikasi juga dapat bersifat situasional, seperti ketidaksepakatan dalam tim, keterbatasan sumber daya, atau kondisi yang melampaui kewenangan tenaga kesehatan tertentu.

2. Sistem dan Proses Eskalasi Komunikasi

Sistem eskalasi komunikasi dalam pelayanan kesehatan disusun secara hierarkis untuk memastikan alur komunikasi yang jelas dan terstruktur. Proses ini melibatkan pelaporan kondisi pasien dari tenaga kesehatan lini pertama kepada tingkat yang lebih tinggi, seperti dokter penanggung jawab atau tim respons cepat, sesuai dengan protokol yang berlaku di institusi pelayanan kesehatan.

Alur eskalasi harus dilakukan secara sistematis dengan menggunakan komunikasi yang jelas, ringkas, dan terstruktur. Teknik komunikasi asertif dan profesional diperlukan agar informasi disampaikan secara tegas tanpa menimbulkan konflik. Penggunaan pendekatan standar seperti SBAR (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*) dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dan mengurangi risiko miskomunikasi.

3. Risiko Kegagalan Eskalasi dan Dampaknya

Kegagalan dalam eskalasi komunikasi dapat terjadi akibat keterlambatan pelaporan, informasi yang tidak lengkap, atau hambatan dalam komunikasi antar tim kesehatan. Kondisi ini dapat mengakibatkan keterlambatan penanganan, kesalahan keputusan klinis, serta meningkatnya risiko kejadian tidak diharapkan.

Dampak utama kegagalan eskalasi adalah penurunan keselamatan pasien, termasuk peningkatan morbiditas dan mortalitas. Selain itu, kegagalan komunikasi juga dapat menurunkan kepercayaan pasien dan keluarga terhadap pelayanan kesehatan serta memperburuk hubungan kerja dalam tim.

4. Peran Kepemimpinan Keperawatan dalam Eskalasi

Kepemimpinan keperawatan memiliki peran penting dalam memastikan efektivitas eskalasi komunikasi, terutama dalam situasi krisis. Perawat sebagai pemimpin klinis dituntut mampu mengambil keputusan secara cepat, mengoordinasikan tim, serta memastikan bahwa informasi penting disampaikan kepada pihak yang tepat.

Perawat berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan eskalasi, menginisiasi komunikasi, serta memfasilitasi koordinasi antar anggota tim kesehatan. Kepemimpinan yang efektif mencakup kemampuan komunikasi yang jelas, keberanian dalam menyampaikan kondisi kritis, serta tanggung jawab dalam menjaga keselamatan pasien melalui sistem eskalasi yang optimal.

E. Tantangan Psikososial dan Penguatan Kompetensi Perawat dalam Komunikasi Kedaruratan dan Krisis

1. Respon Psikologis, Mekanisme Koping, dan Stigma dalam Situasi Krisis

Situasi krisis menimbulkan respon psikologis seperti syok, kecemasan, ketakutan, penolakan (*denial*), dan kemarahan yang dapat mempengaruhi kemampuan individu dalam memahami informasi dan mengambil keputusan. Respon ini merupakan reaksi normal terhadap stres yang tinggi dan dipengaruhi oleh pengalaman, dukungan sosial, serta persepsi individu terhadap kondisi yang dihadapi (Hanif et al., 2021).

a. Mekanisme koping

Mekanisme koping merupakan cara individu mengelola stres, baik secara adaptif maupun maladaptif. Perawat perlu mengenali bentuk koping pasien dan keluarga untuk menentukan pendekatan komunikasi yang sesuai.

b. Stigma dalam situasi krisis

Stigma dapat memperburuk respon psikologis dengan menimbulkan rasa malu, takut, dan penolakan terhadap kondisi yang dialami. Kondisi ini dapat menghambat komunikasi dan proses adaptasi.

c. Implikasi terhadap komunikasi

Respon psikologis, koping, dan stigma mempengaruhi efektivitas komunikasi, sehingga diperlukan pendekatan yang empatik, sederhana, dan bertahap agar informasi dapat dipahami dengan baik.

2. Beban Psikologis dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan

Situasi krisis dan kedaruratan memberikan beban psikologis yang signifikan bagi tenaga kesehatan akibat tekanan kerja yang tinggi, tanggung jawab besar, serta paparan terhadap kondisi pasien yang kritis. Kondisi ini dapat menimbulkan stres, kelelahan emosional, dan penurunan kesejahteraan yang berdampak pada kualitas komunikasi dan pelayanan. Burnout sebagai salah satu bentuk kelelahan emosional ditandai oleh menurunnya energi, motivasi, serta empati terhadap pasien, sehingga dapat mempengaruhi efektivitas interaksi dan hubungan terapeutik.

Beban psikologis yang tidak terkelola dengan baik dapat berdampak pada praktik pelayanan, termasuk penurunan kualitas pengambilan keputusan, gangguan komunikasi dalam tim, serta peningkatan risiko kesalahan yang berpotensi membahayakan keselamatan pasien. Kondisi ini menegaskan pentingnya upaya menjaga kesejahteraan tenaga kesehatan melalui dukungan psikologis, lingkungan kerja yang kondusif, serta penguatan kemampuan regulasi emosi dalam menghadapi situasi krisis (Chaaya et al., 2025; Conduah, 2025; Cortez et al., 2025).

3. Faktor Budaya, Spiritual, dan Nilai dalam Komunikasi Krisis

Faktor budaya, spiritual, dan nilai memiliki peran penting dalam mempengaruhi cara pasien dan keluarga memahami, merespons, serta mengambil keputusan dalam situasi krisis. Latar belakang budaya menentukan persepsi terhadap penyakit, makna kesehatan dan kematian, serta pola komunikasi yang digunakan. Nilai-nilai yang dianut individu juga

mempengaruhi harapan terhadap pelayanan kesehatan dan interaksi dengan tenaga kesehatan.

Aspek spiritual menjadi sumber kekuatan bagi pasien dan keluarga dalam menghadapi kondisi krisis. Keyakinan spiritual dapat membantu individu menemukan makna, menerima kondisi yang dialami, serta meningkatkan ketahanan psikologis. Namun, perbedaan keyakinan dan nilai antara tenaga kesehatan dan pasien dapat menimbulkan kesalahpahaman apabila tidak dikelola dengan komunikasi yang sensitif.

Pemahaman terhadap faktor budaya, spiritual, dan nilai menuntut tenaga kesehatan untuk menerapkan komunikasi yang adaptif dan menghargai keberagaman. Pendekatan yang sensitif terhadap budaya dan keyakinan membantu meningkatkan penerimaan terhadap informasi, memperkuat hubungan terapeutik, serta mencegah konflik dalam situasi krisis.

4. Kompetensi dan Pengembangan Profesional Perawat dalam Komunikasi Krisis

Komunikasi krisis menuntut perawat memiliki kompetensi yang mencakup aspek kognitif, emosional, dan sosial dalam menghadapi situasi dengan tekanan tinggi dan ketidakpastian. Kompetensi ini meliputi kemampuan menyampaikan informasi secara jelas dan akurat, menunjukkan empati, mengelola emosi, serta berkomunikasi secara efektif dengan pasien, keluarga, dan tim kesehatan. Penguasaan kompetensi komunikasi krisis menjadi penting untuk mendukung keselamatan pasien, kualitas pelayanan, dan pengambilan keputusan yang tepat.

Pengembangan profesional perawat dalam komunikasi krisis perlu dilakukan secara sistematis melalui pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi dalam kurikulum keperawatan. Pembelajaran yang berkelanjutan memungkinkan perawat meningkatkan keterampilan komunikasi sesuai dengan perkembangan praktik klinis dan kebutuhan pelayanan. Integrasi kompetensi komunikasi krisis dalam pendidikan formal dan pengembangan profesional berkelanjutan menjadi strategi penting dalam mempersiapkan perawat menghadapi situasi kedaruratan dan krisis secara profesional (Staryo et al., 2024; Yusri, 2020).

5. Metode Pembelajaran dan Penguatan Keterampilan Komunikasi Krisis

Penguatan keterampilan komunikasi krisis pada perawat memerlukan metode pembelajaran yang aplikatif, reflektif, dan berkelanjutan. Pendekatan pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pengembangan keterampilan praktis dan kemampuan regulasi emosi dalam

situasi tekanan tinggi. Metode yang tepat memungkinkan perawat mengintegrasikan teori dengan praktik klinis secara efektif.

Pelatihan berbasis simulasi menjadi salah satu metode yang efektif dalam mengembangkan keterampilan komunikasi krisis. Simulasi memberikan pengalaman belajar yang mendekati kondisi nyata, sehingga perawat dapat melatih respon komunikasi dalam situasi kompleks tanpa risiko terhadap pasien. Selain itu, refleksi praktik dan supervisi klinik berperan penting dalam mengevaluasi pengalaman komunikasi yang telah dilakukan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta meningkatkan kualitas praktik secara berkelanjutan (Amalia et al., 2019; Staryo et al., 2024).

F. Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Kasus 1: Komunikasi dalam Situasi Konflik

Seorang pasien perempuan usia 55 tahun dirawat di ruang rawat inap dengan diagnosis gagal jantung. Kondisi pasien mengalami penurunan dalam dua hari terakhir. Keluarga pasien merasa tidak puas terhadap pelayanan karena menganggap perawat lambat dalam merespon keluhan sesak napas yang dialami pasien.

Saat perawat datang untuk melakukan tindakan, anggota keluarga pasien menyampaikan keluhan dengan nada tinggi dan terlihat marah. Keluarga mengatakan bahwa kondisi pasien semakin memburuk karena keterlambatan penanganan. Perawat terlihat mencoba menjelaskan kondisi pasien, namun komunikasi menjadi tidak kondusif karena keluarga terus memotong pembicaraan dan menunjukkan sikap tidak percaya.

Hasil pengkajian situasi:

1. Keluarga tampak emosional (marah, cemas, dan tidak percaya)
2. Terjadi miskomunikasi antara keluarga dan perawat
3. Perawat belum menggunakan teknik komunikasi de-eskalatif secara optimal
4. Lingkungan ruangan cukup ramai sehingga komunikasi kurang fokus

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kasus tersebut.

Pertanyaan Diskusi

1. Identifikasi faktor penyebab terjadinya konflik pada kasus tersebut.
2. Jelaskan respon emosional yang ditunjukkan oleh keluarga pasien.
3. Analisis kesalahan komunikasi yang dilakukan oleh perawat pada situasi tersebut.

4. Jelaskan strategi komunikasi yang dapat digunakan untuk meredakan konflik (*de-escalation communication*).
5. Uraikan peran perawat sebagai mediator dalam menjaga hubungan terapeutik pada kasus tersebut.

Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok dan presentasikan hasil diskusi di kelas.

Rubrik penilaian aktivitas 1

Aspek Penilaian	1 (Tidak Kompeten)	2 (Kurang Kompeten)	3 (Kompeten)	4 (Sangat Kompeten)
Identifikasi masalah konflik	Tidak mampu mengidentifikasi	Identifikasi tidak lengkap	Identifikasi cukup tepat	Identifikasi lengkap & mendalam
Analisis respon emosional	Tidak tepat	Sebagian benar	Tepat	Mendalam & kontekstual
Analisis kesalahan komunikasi	Tidak mampu	Kurang tepat	Tepat	Komprehensif & kritis
Strategi komunikasi konflik	Tidak sesuai	Kurang efektif	Sesuai	Sangat efektif & aplikatif
Peran perawat sebagai mediator	Tidak dijelaskan	Kurang jelas	Jelas	Sangat jelas & profesional
Partisipasi diskusi	Pasif	Terbatas	Aktif	Sangat aktif & kolaboratif

G. Aktivitas 2 — Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Kasus 2: Komunikasi dalam Situasi Eskalasi

Seorang pasien laki-laki usia 60 tahun dirawat di ruang ICU dengan diagnosis sepsis. Pada shift malam, perawat mencatat adanya penurunan tekanan darah secara signifikan (80/50 mmHg), peningkatan frekuensi napas, dan penurunan kesadaran.

Perawat junior telah melakukan monitoring, namun belum segera melaporkan kondisi tersebut kepada dokter penanggung jawab. Perawat merasa ragu karena takut dianggap berlebihan dan berpikir kondisi masih dapat ditangani sementara. Beberapa saat kemudian, kondisi pasien semakin memburuk. Perawat senior yang datang kemudian segera melakukan komunikasi eskalasi kepada dokter menggunakan pendekatan terstruktur.

Hasil pengkajian situasi:

1. Terdapat keterlambatan dalam eskalasi komunikasi
2. Perawat junior mengalami hambatan psikologis (ragu, takut)
3. Kondisi pasien menunjukkan tanda kegawatan
4. Komunikasi tim belum optimal

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kasus tersebut.

Pertanyaan Diskusi

1. Identifikasi indikator klinis yang menunjukkan perlunya eskalasi komunikasi pada kasus tersebut.
2. Jelaskan faktor yang menyebabkan keterlambatan eskalasi komunikasi oleh perawat.
3. Analisis dampak keterlambatan komunikasi eskalasi terhadap keselamatan pasien.
4. Jelaskan langkah komunikasi eskalasi yang tepat menggunakan pendekatan terstruktur (misalnya SBAR).
5. Uraikan peran perawat dalam memastikan komunikasi eskalasi berjalan efektif dan profesional.

Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok dan presentasikan hasil diskusi di kelas.

Rubrik Penilaian Aktivitas 2

Aspek Penilaian	1 (Tidak Kompeten)	2 (Kurang Kompeten)	3 (Kompeten)	4 (Sangat Kompeten)
Identifikasi masalah konflik	Tidak mampu mengidentifikasi	Identifikasi tidak lengkap	Identifikasi cukup tepat	Identifikasi lengkap & mendalam
Analisis respon emosional	Tidak tepat	Sebagian benar	Tepat	Mendalam & kontekstual

Analisis kesalahan komunikasi	Tidak mampu	Kurang tepat	Tepat	Komprehensif & kritis
Strategi komunikasi konflik	Tidak sesuai	Kurang efektif	Sesuai	Sangat efektif & aplikatif
Peran perawat sebagai mediator	Tidak dijelaskan	Kurang jelas	Jelas	Sangat jelas & profesional
Partisipasi diskusi	Pasif	Terbatas	Aktif	Sangat aktif & kolaboratif

SOAL OSCE KOMUNIKASI

No	Komponen	Isi
1	Nomor station	
2	Judul station	Komunikasi Perawat dalam Menyampaikan Kabar Sulit
3	Waktu yang dibutuhkan	10–15 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan mahasiswa keperawatan dalam menyampaikan kabar sulit secara empatik, terstruktur, dan profesional kepada keluarga pasien dalam situasi krisis.
5	Kompetensi	1. Komunikasi terapeutik 2. Edukasi dan konseling 3. Keselamatan pasien 4. Perilaku profesional
6	Kategori	1. Psikososial 2. Komunikasi 3. Keamanan dan keselamatan 4. Etik
7	Instruksi untuk mahasiswa	SKENARIO KLINIK: Seorang pasien laki-laki usia 65 tahun dirawat di ruang ICU dengan gagal napas. Kondisi pasien mengalami penurunan dan prognosis buruk. Keluarga (anak pasien) menunggu di ruang konsultasi dan belum mengetahui kondisi terkini pasien. TUGAS: 1. Sampaikan kondisi pasien kepada keluarga secara empatik dan profesional. 2. Gunakan komunikasi verbal dan nonverbal yang tepat. 3. Respon emosi keluarga dengan pendekatan terapeutik.

		4. Lakukan klarifikasi pemahaman keluarga.
8	Instruksi untuk penguji	INSTRUKSI PENILAIAN: 1. Menilai kemampuan mahasiswa dalam membuka komunikasi dan membangun hubungan terapeutik. 2. Menilai kejelasan dan struktur penyampaian kabar sulit. 3. Menilai penggunaan komunikasi empatik (verbal dan nonverbal). 4. Menilai kemampuan mahasiswa dalam merespon emosi keluarga. 5. Menilai kemampuan klarifikasi dan validasi pemahaman. 6. Menilai penutup komunikasi dan pemberian dukungan. 7. Menilai perilaku profesional. 8. Penguji tidak diperbolehkan interupsi.
9	Instruksi untuk klien standar	1. Berperan sebagai anak pasien (usia $\pm 30-40$ tahun). 2. Belum mengetahui kondisi pasien secara lengkap. 3. Tampak cemas dan khawatir. 4. Bila mahasiswa menyampaikan kabar buruk, respon: terkejut, sedih, dapat menangis. 5. Bila ditanya pemahaman: "Saya hanya tahu kondisi ayah saya masih dirawat di ICU." 6. Harapan: ingin kondisi ayah membaik. 7. Dapat bertanya: "Apakah masih ada harapan?"
10	Setting station	Ruang konsultasi/ruang ICU - Kursi keluarga - Kursi mahasiswa - Meja - Penguji
11	Peralatan yang dibutuhkan	1. Kursi dan meja 2. Handrub 3. Lembar penilaian 4. Alat tulis Peran laboran: menyiapkan ruangan dan memastikan kesiapan station

Lembar Penilaian OSCE

NO	ASPEK YANG DINILAI (TAHAPAN KERJA)	BOBOT	NILAI (1/2)	KETERANGAN PENILAIAN
Tahap Awal				
1	Mengucapkan salam, menyebut nama keluarga (jika diketahui), dan melakukan kontak mata	2		1: Tidak sopan/tidak kontak mata 2: Sopan, kontak mata, nada tenang
2	Memperkenalkan diri (nama dan peran sebagai mahasiswa keperawatan yang merawat pasien)	2		1: Tidak jelas 2: Jelas dan profesional
3	Menjelaskan tujuan pertemuan (akan menyampaikan kondisi pasien saat ini)	3		1: Tidak jelas/langsung ke inti 2: Tujuan jelas dan tidak mengancam
4	Menyampaikan estimasi waktu komunikasi (misal: "sekitar 10 menit")	2		1: Tidak dilakukan 2: Menyebutkan waktu
5	Menanyakan kesiapan keluarga untuk menerima informasi ("Apakah keluarga siap mendengarkan?")	2		1: Tidak dilakukan 2: Menanyakan kesiapan
Tahap Pelaksanaan				
6	Menanyakan pemahaman awal keluarga tentang kondisi pasien ("Sejauh ini yang keluarga ketahui?")	5		1: Tidak menggali 2: Menggunakan pertanyaan terbuka
7	Menanyakan harapan keluarga terhadap kondisi pasien ("Apa yang keluarga harapkan?")	4		1: Tidak dilakukan 2: Dilakukan dengan empatik
8	Memberikan <i>warning shot</i> sebelum kabar buruk ("Kondisi pasien saat ini cukup serius...")	5		1: Langsung ke kabar buruk 2: Ada pengantar bertahap

NO	ASPEK YANG DINILAI (TAHAPAN KERJA)	BOBOT	NILAI (1/2)	KETERANGAN PENILAIAN
9	Menyampaikan kondisi pasien secara bertahap, jelas, dan sistematis	5		1: Tidak terstruktur 2: Bertahap dan mudah dipahami
10	Menyampaikan prognosis buruk dengan kalimat hati-hati dan empatik	5		1: Kasar/tidak empatik 2: Empatik, tidak menyakitkan
11	Menggunakan bahasa sederhana (menghindari istilah medis tanpa penjelasan)	3		1: Banyak istilah medis 2: Bahasa awam
12	Menunjukkan komunikasi nonverbal empatik (kontak mata, posisi sejajar, nada suara lembut)	4		1: Kaku/tidak peduli 2: Empatik dan sesuai
13	Memberikan jeda (diam terapeutik) setelah penyampaian informasi penting	4		1: Tidak memberi waktu 2: Memberi jeda cukup
14	Mengamati respon emosional keluarga (menangis, diam, marah)	5		1: Tidak peka 2: Peka terhadap respon
15	Memvalidasi emosi keluarga ("Saya memahami ini berat bagi keluarga...")	5		1: Mengabaikan emosi 2: Mengakui & empatik
16	Memberikan kesempatan keluarga bertanya	3		1: Tidak memberi kesempatan 2: Memberi kesempatan aktif
17	Menjawab pertanyaan dengan jujur, jelas, dan tidak defensif	4		1: Tidak jelas/defensif 2: Jelas, jujur
Tahap Akhir				
18	Mengecek kembali pemahaman keluarga	3		1: Tidak mengecek 2: Klarifikasi dilakukan

NO	ASPEK YANG DINILAI (TAHAPAN KERJA)	BOBOT	NILAI (1/2)	KETERANGAN PENILAIAN
	("Apakah bisa disampaikan kembali...")			
19	Menjelaskan rencana tindak lanjut/perawatan (monitoring, terapi, dll)	3		1: Tidak menjelaskan 2: Jelas dan realistis
20	Memberikan dukungan emosional lanjutan ("Kami akan mendampingi keluarga...")	2		1: Tidak ada dukungan 2: Empatik dan suportif
21	Menutup komunikasi dengan salam, ucapan terima kasih, dan menjaga waktu	3		1: Tidak jelas/terburu 2: Sopan dan tepat
Penampilan selama tindakan				
22	Menunjukkan ketenangan, tidak tergesa, dan komunikasi lancar	3		1: Gugup/tidak lancar 2: Tenang dan terstruktur
23	Berpenampilan rapi, sopan, dan profesional	3		1: Tidak sesuai 2: Profesional

H. Rangkuman Materi

Komunikasi dalam situasi kedaruratan dan krisis merupakan kompetensi penting dalam praktik keperawatan karena berlangsung dalam kondisi yang kompleks, penuh ketidakpastian, tekanan waktu, serta respons emosional yang tinggi. Komunikasi yang efektif tidak hanya menuntut kejelasan dan ketepatan informasi, tetapi juga kemampuan perawat dalam menunjukkan empati, menjaga konsistensi pesan, melakukan validasi pemahaman, serta menyesuaikan pendekatan komunikasi dengan kondisi psikologis, budaya, spiritual, dan kebutuhan pasien maupun keluarga. Dalam situasi tersebut, perawat berperan sebagai komunikator profesional, fasilitator, pemberi dukungan emosional, advokat pasien, mediator, sekaligus penghubung antara pasien, keluarga, dan tim kesehatan.

Penyampaian kabar sulit, pengelolaan konflik, dan komunikasi eskalasi membutuhkan pendekatan yang terstruktur, empatik, serta berorientasi pada keselamatan pasien. Penyampaian kabar sulit perlu dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan respons emosional pasien atau keluarga, sedangkan konflik perlu dikelola melalui komunikasi yang jelas, mendengarkan aktif, klarifikasi, komunikasi asertif, regulasi emosi, de-eskalasi, kolaborasi, dan negosiasi. Pada kondisi pasien yang memburuk atau terdapat risiko keselamatan, perawat juga harus mampu melakukan eskalasi komunikasi secara tepat waktu dan sistematis, termasuk melalui penggunaan SBAR, sehingga informasi penting dapat segera diterima oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.

Keberhasilan komunikasi dalam situasi krisis juga dipengaruhi oleh kemampuan perawat memahami respons psikologis, mekanisme koping, stigma, faktor budaya, spiritual, dan nilai, serta mengelola beban psikologis yang dapat muncul pada tenaga kesehatan. Oleh karena itu, kompetensi komunikasi krisis perlu dikembangkan secara berkelanjutan melalui pendidikan, pelatihan berbasis simulasi, refleksi praktik, dan supervisi klinik. Penguasaan kompetensi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan perawat dalam mengambil keputusan, membangun hubungan terapeutik, mencegah dan mengelola konflik, melakukan eskalasi secara tepat, serta memberikan pelayanan yang aman, profesional, etis, empatik, dan berorientasi pada kebutuhan pasien dan keluarga.

I. Daftar Pustaka

- Amalia, E., Handayani, R., & Andriani, Y. (2019). Komunikasi Terapeutik Mempengaruhi Kepuasan Keluarga Pasien di RSUD Dr Adnaan WD Payakumbuh. *Jurnal Prosiding Seminar Kesehatan Perintis*, 2(1), 60–66.
- Barnes, N. K., Azoulay, E., Reignier, J., Cariou, A., Lafarge, A., Huet, O., Gargadennec, T., Renault, A., Souppart, V., Clavier, P., Dilosquer, F., Leroux, L., Légé, S., Renet, A., Brumback, L. C., Engelberg, R. A., Pochard, F., Rigon, M. R., & Curtis, J. R. (2024). ORIGINAL A randomised controlled trial of a nurse facilitator to promote communication for family members of critically ill patients. *Intensive Care Medicine*, 50(5), 712–724. <https://doi.org/10.1007/s00134-024-07390-y>
- Bscn, L. L., & Nurse, R. (2023). Interprofessional communication in emergencies during a pandemic. *Journal of Clinical Nursing Wiley*, September 2021, 2021–2023. <https://doi.org/10.1111/jocn.16049>
- Carpenter, C. R., Leggett, J., Bellolio, F., Betz, M., Pharmd, R. M. C., Carr, D., Doering, M., Chin, J., Rn, H., Isaacs, E. D., Jobe, D., Kelly, K., Msw, N. M., Prusaczyk, B., Savage, B., Suyama, J., Vann, A. S., Rising, K. L., Hwang, U., ... Gear, T. (2022). Emergency Department Communication in Persons Living With Dementia and Care Partners: A Scoping Review. *JAMDA*, 23. <https://doi.org/10.1016/j.jamda.2022.02.024>
- Chaaya, R., Sfeir, M., Khoury, S. El, Malhab, S. B., El, M., & Malhame, K. (2025). Adaptive versus maladaptive coping strategies : insight from Lebanese young adults navigating multiple crises. *BMC Public Health*. <https://doi.org/10.1186/s12889-025-22608-4>
- Conduah, A. K. (2025). Coping With Chronic Illness: A Systematic Review of Adaptive Strategies Across Cancer , COPD , Diabetes and Heart Disease. *Public Health Challanges*. <https://doi.org/10.1002/puh2.70129>
- Cortez, P. A., Magali, H., Náthalie, F., Rodrigues, F., Loriane, Q., & Frick, T. (2025). Brief Assessment of Adaptive and Maladaptive Coping. *Trends in Psychology*, 33(1), 325–339. <https://doi.org/10.1007/s43076-023-00274-y>
- Cruz, R. S., & Mariana, V. (2023). Therapeutic communication between the nurse and the family of the patient in critical care : a humanized approach. *Sapenza*, 4, 1–8.
- Cuidarte, R. (2024). Peplau ' s theory for telenursing with the family of patients with COVID-19 *Revista Cuidarte*. *Revista Cuidarte*, 15(1).
- Engel, M., & Ph, D. (2023). Effective communication in palliative care from the perspectives of patients and relatives: A systematic review. *Palliative and Supportive Care*, 1(1), 890–913.
- Forte, D. N., Stoltenberg, M., & Correa, S. (2024). The Hierarchy of Communication Needs: A Novel Communication Strategy for High Mistrust Settings

Developed in a Brazilian COVID-ICU. *Palliative Medicine Reports*, 5, 86–93.
<https://doi.org/10.1089/pmr.2023.0070>

- Girotti, M., Bulin, S. E., & Carreno, F. R. (2024). Neurobiology of Stress Effects of chronic stress on cognitive function – From neurobiology to intervention Wisconsin Card test. *Neurobiology of Stress*, 33(January), 100670.
<https://doi.org/10.1016/j.ynstr.2024.100670>
- Guo, S., Wang, X., Zhang, Z., Zhang, Q., Pan, X., Li, C., & Ke, D. (2024). The Mediating Effect of Nurses ' Emotional Intelligence in the Relationship between Moral Sensitivity and Communication Ability with Angry Patients. *Journal of Nursing Management*, 2024. <https://doi.org/10.1155/2024/6614034>
- Hanif, S., Farooq, A., Mahmood, K., Isoaho, J., & Zara, S. (2021). From information seeking to information avoidance: Understanding the health information behavior during a global health crisis. *Information Processing and Management*, 58(2), 102440. <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2020.102440>
- Hinata, S., Rohde, H., & Templeton, A. (2024). International Journal of Disaster Risk Reduction Communicating with the public in emergencies: A systematic review of communication approaches in emergency response. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 111(September 2023), 104719. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2024.104719>
- Hudson, E., & Marie-, C. C. (2024). Mental Health Crisis: An Evolutionary Concept Analysis. *International Journal of Mental Health Nursing*, 1908–1920. <https://doi.org/10.1111/inm.13412>
- Kwame, A., & Petrucka, P. M. (2021). A literature-based study of patient-centered care and communication in nurse-patient interactions: barriers, facilitators, and the way forward. *BMC Nursing*, 20, 1–10.
- Lee, H., Woodward-kron, R., Merry, A., & Weller, J. (2023). Emotions and team communication in the operating room: a scoping review. *Medical Education Online*, 28(1). <https://doi.org/10.1080/10872981.2023.2194508>
- Mercan, N., & Mersin, S. (2025). Heliyon Evaluating the therapeutic communication skills of nursing students in the clinical setting: The experiences of students, patients and patients ' relatives ☆. *Heliyon*, 11(November 2024). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2025.e41677>
- Setyawati, A., Yusuf, S., Jafar, N., & Wijayanti, R. (2024). Exploring herbal remedy utilization for wound healing: Patterns, patient preferences, and implications for nursing practice. *International Journal of Nursing Knowledge*, August 2023, 363–374. <https://doi.org/10.1111/2047-3095.12454>
- Staryo, N., Ridwan, E. S., Mariana, D., Ramadhan, K., Kafilawati, B. N., Yusuf, H., Sahabuddin, L., Agni, M. K., & Setiawan, S. (2024). Buku Ajar Manajemen Konflik. In *Yayasan Kita Menulis* (Vol. 2, Issue 2).

- Vaz, T. (2021). Annals of Medicine Nursing communication handover in emergency department. *Annals of Medicine* ISSN:, 3890. <https://doi.org/10.1080/07853890.2021.1896174>
- Wahyuni, S., Gautama, M. S. N., & Simamora, T. Y. (2023). A Literature Review of Nurses Challenges and Barriers in Assisting Patients and Families Facing Breaking Bad News. *Indian Journal of Palliative Car*, 29(3), 243–249.
- Yoo, H. J., Lim, O. B., Lan, J., & Id, S. (2020). Critical care nurses ' communication experiences with patients and families in an intensive care unit : A qualitative study. *PLoS ONE*, 5–7. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0235694>
- Yusri, A. Z. dan D. (2020). Buku Ajar Etika Keperawatan. In *Jurnal Ilmu Pendidikan* (Vol. 7, Issue 2).

PROFIL PENULIS



Prof. Dr. M. Hasinuddin, S.Kep., Ns., M.Kep. lahir di Sampang, 23 Mei 1981. Pendidikan tinggi diawali dengan menempuh Program Diploma III Keperawatan di Poltekkes Surabaya dan lulus pada tahun 2003. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners di STIKES Ngudi Waluyo Semarang dan menyelesaikannya pada tahun 2006. Pendidikan Magister Keperawatan ditempuh di Universitas Airlangga Surabaya dan lulus pada tahun 2010. Penulis kemudian menyelesaikan pendidikan Doktor (S3) Ilmu Kedokteran di Universitas Airlangga pada tahun 2015.

Riwayat pekerjaan dan pengabdian penulis di bidang organisasi profesi dan pendidikan cukup panjang. Penulis aktif sebagai akademisi, praktisi keperawatan, narasumber nasional, reviewer akademik, serta penggerak pengembangan pendidikan keperawatan di Indonesia. Dalam organisasi profesi, penulis pernah menjabat sebagai Ketua DPD PPNI Kabupaten Bangkalan periode 2010–2015 dan 2016–2021, Sekretaris II DPW PPNI Jawa Timur periode 2016–2021, Wakil Ketua Bidang Diklat DPW PPNI Jawa Timur, serta Bidang SIKI DPP PPNI Pusat periode 2021–2026. Penulis juga aktif dalam berbagai organisasi keilmuan dan sosial kemasyarakatan seperti IPANI Jawa Timur, Ikatan Alumni Keperawatan UNAIR, Komunitas Relawan Emergensi Kesehatan Indonesia, serta Tim P2KB Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Saat ini penulis aktif sebagai dosen dan akademisi di bidang keperawatan dengan fokus keilmuan pada keperawatan anak dan manajemen keperawatan. Penulis juga aktif mengampu berbagai mata kuliah di bidang keperawatan dan administrasi kesehatan, khususnya pada jenjang sarjana, profesi Ners, dan magister.

Dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, penulis aktif sebagai penulis buku ajar, book chapter, reviewer karya ilmiah, pembicara seminar nasional, trainer workshop keperawatan, serta publikasi ilmiah pada jurnal nasional dan internasional. Selain itu, penulis juga aktif melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan edukasi kesehatan, pelatihan kegawatdaruratan, pemberdayaan relawan kesehatan, serta penguatan mutu pendidikan tinggi keperawatan di Indonesia.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: hasin3333.nhm@gmail.com

Motto: "Mengabdikan dengan ilmu, menginspirasi dengan keteladanan."

PROFIL PENULIS



Aini Alifatin, S.Kp., M.Kep Lahir di Bojonegoro, 02 Desember 1970. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Diploma III Keperawatan, lulus tahun 1991, selanjutnya melanjutkan pada jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan, Universitas Indonesia lulus tahun 2000, dan pendidikan S2 Keperawatan pada Universitas Airlangga dan lulus tahun pada tahun 2011. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1991 sebagai perawat pelaksana di rumah sakit, dan kemudian beralih sebagai staff dosen Diploma III Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Malang sejak 1993 hingga sekarang menjadi Fakultas Ilmu Kesehatan yang terdiri atas program D3, S1, S2 dan profesi Keperawatan serta jurusan kesehatan lainnya diantaranya Farmasi dan Fisioterapi. Saat ini penulis mengampu mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan, Etik dan Hukum Keperawatan, komunikasi keperawatn dan Keperawatan Anak. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan aktif dalam kegiatan kajian-kajian parenting dan perlindungan perempuan dan anak di tingkat universitas serta Malang raya. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: alifatin@umm.ac.id.

Motto: "Mereka yang optimis melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. "

PROFIL PENULIS



Dr. Aemilianus Mau, S.Kep., Ns., M.Kep. lahir di Malaka pada 27 Mei 1972. Pendidikan tinggi yang ditempuh diawali di Akademi Keperawatan Kupang dan lulus pada tahun 1996. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan Sarjana Keperawatan (S.Kep.) dan Profesi Ners (Ns.) pada Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Airlangga, Surabaya, dan menyelesaikannya pada tahun 2003. Penulis kemudian meraih gelar Magister Keperawatan (M.Kep.) di Universitas Airlangga pada tahun 2010. Pendidikan formal tertinggi diselesaikan pada Program Doktor (S3) Ilmu Keperawatan di Universitas Indonesia dan memperoleh gelar Doktor (Dr.) pada tahun 2023.

Karier profesional penulis diawali sebagai perawat sekaligus dosen di Pendidikan Ahli Madya Kesehatan (PAM-KT) Dili, Timor Timur, pada periode 1996–1998. Sejak bergabung dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang, penulis mengabdikan diri sebagai dosen pada Jurusan Keperawatan dan saat ini dipercaya menjabat sebagai Ketua Program Studi Profesi Ners. Di samping aktivitas akademik, penulis aktif dalam organisasi profesi sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPW PPNI) Provinsi Nusa Tenggara Timur, anggota Kolegium Keperawatan Indonesia, serta anggota Bidang Pendidikan dan Pelatihan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI).

Dalam bidang pendidikan, penulis mengampu berbagai mata kuliah, antara lain Falsafah dan Teori Keperawatan, Komunikasi dalam Keperawatan, Manajemen dan Kepemimpinan dalam Keperawatan, Caring, Etika Keperawatan, Metodologi Penelitian, Evidence-Based Nursing, dan Keperawatan Jiwa. Penulis juga aktif membimbing mahasiswa pada penyusunan tugas akhir, karya ilmiah, dan penelitian di bidang keperawatan.

Sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, penulis aktif melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Berbagai karya ilmiah telah dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi. Selain itu, penulis telah menghasilkan sejumlah buku ajar dan *book chapter* di bidang keperawatan, menjadi narasumber dalam seminar, pelatihan, dan workshop ilmiah, serta berperan sebagai reviewer pada beberapa jurnal ilmiah nasional dan internasional. Bidang keilmuan yang menjadi fokus penulis meliputi pengembangan model praktik keperawatan berbasis caring, etik dan budaya, pendidikan keperawatan, pemberdayaan masyarakat, pengendalian tuberkulosis, mutu dan keselamatan pasien di RS.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: aemilianusmau58@gmail.com.

Motto: *"Terus Belajar agar Ilmunya Dapat Bermanfaat bagi orang lain"*

PROFIL PENULIS



Dr. Wahyu Endang Setyowati, SKM., M.Kep. Keperawatan Indonesia (AIPVIKI) pada tingkat regional dan nasional sebagai Pengurus AIPVIKI Pusat dengan peran sebagai Ketua Bidang Kerjasama Luar Negeri.

Kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah mencakup jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi Scopus. Topik penelitian meliputi keperawatan jiwa, komunikasi keperawatan, pemberdayaan keluarga, serta isu kesehatan psikososial seperti bullying dan kesehatan mental. Publikasi

ilmiah telah terindeks pada basis data internasional dan disertai dengan karya Hak Kekayaan Intelektual di bidang edukasi kesehatan. Penulis juga aktif sebagai Tim Trainer Service Excellent serta Konsultan Komunikasi Efektif dalam berbagai kegiatan pelatihan, dan aktif sebagai Konselor Bullying.

Kontribusi dalam Tridharma Perguruan Tinggi diwujudkan melalui keterlibatan dalam konferensi nasional dan internasional serta pelatihan profesional, termasuk sertifikasi komunikasi efektif. Penulis juga merupakan penulis buku dan modul bermain berbasis keyakinan atau *Health Belief Model*, serta pencipta dan inisiator permainan edukatif ular tangga anti bullying berbasis keyakinan pada anak usia sekolah.

Penulis dapat dihubungi melalui email: wahyu.endang@unissula.ac.id.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-1900-9836>

SINTA ID: 6662913

Scopus ID: 57222710265

Web of Science ID: PAU-7782-2025

Sinopsis

Buku Ajar Komunikasi Keperawatan membahas konsep dan penerapan komunikasi sebagai bagian fundamental dalam pelayanan keperawatan yang mendukung terbentuknya hubungan terapeutik antara perawat, pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan lainnya. Buku ini diawali dengan pembahasan mengenai komunikasi dalam situasi sulit, meliputi menghadapi pasien dengan kondisi marah, cemas, menolak tindakan, maupun mengalami agitasi. Pembahasan mencakup konsep dasar, tujuan, indikasi, kontraindikasi, persiapan, langkah komunikasi terapeutik, aspek keselamatan pasien (*patient safety*), evaluasi hasil, dokumentasi, serta pendekatan komunikasi berdasarkan tingkat pemahaman dan respons pasien. Materi juga dilengkapi dengan tabel *red flags* dan eskalasi untuk membantu mengenali kondisi yang membutuhkan perhatian lebih lanjut dalam proses komunikasi keperawatan.

Bab berikutnya membahas komunikasi pada populasi khusus, yaitu anak, lansia, individu dengan gangguan jiwa, dan penyandang disabilitas. Pembahasan mencakup landasan teoretik komunikasi, pendekatan komunikasi dalam asuhan keperawatan, serta proses asesmen untuk memahami kebutuhan dan karakteristik setiap kelompok pasien. Buku ini juga menguraikan komunikasi budaya dan spiritual transkultural yang menekankan pentingnya sensitivitas terhadap bahasa, nilai, keyakinan, dan latar belakang budaya pasien. Pendekatan komunikasi yang menghargai keberagaman menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan keperawatan yang inklusif, beretika, dan berpusat pada pasien.

Bagian akhir buku membahas komunikasi dalam kondisi kedaruratan dan krisis, termasuk penyampaian kabar sulit (*breaking bad news*), komunikasi konflik, komunikasi eskalasi (*escalation communication*), serta tantangan psikososial yang dihadapi perawat dalam situasi kritis. Materi dilengkapi dengan pendekatan etik, penguatan kemampuan komunikasi profesional, serta aktivitas penerapan konsep komunikasi dalam berbagai kondisi pelayanan. Dengan cakupan pembahasan yang luas dan sistematis, **Buku Ajar Komunikasi Keperawatan** diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa keperawatan, pendidik, perawat, dan tenaga kesehatan dalam mengembangkan kemampuan komunikasi terapeutik yang efektif, empatik, aman, serta sesuai dengan prinsip profesionalisme keperawatan.



Buku Ajar Komunikasi Keperawatan membahas konsep dan penerapan komunikasi sebagai kompetensi utama dalam praktik keperawatan untuk membangun hubungan terapeutik, meningkatkan kepercayaan pasien, serta mendukung pemberian asuhan yang aman dan berpusat pada kebutuhan individu. Buku ini diawali dengan pembahasan mengenai komunikasi dalam situasi sulit, meliputi menghadapi pasien dengan kondisi marah, cemas, menolak tindakan, dan agitasi. Materi mencakup konsep dasar, tujuan, indikasi, kontraindikasi, persiapan, langkah komunikasi terapeutik, aspek keselamatan pasien (patient safety), risiko komunikasi yang tidak tepat, evaluasi hasil, serta dokumentasi. Pembahasan ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya strategi komunikasi yang tepat dalam menghadapi berbagai respons emosional dan perilaku pasien.

Bagian selanjutnya menguraikan komunikasi pada populasi khusus, yaitu anak, lansia, individu dengan gangguan jiwa, dan penyandang disabilitas. Pembahasan meliputi landasan teoretik komunikasi, pendekatan komunikasi dalam asuhan keperawatan, serta prinsip penyesuaian komunikasi berdasarkan karakteristik, kebutuhan, dan kondisi pasien. Buku ini juga membahas komunikasi budaya dan spiritual transkultural yang menekankan pentingnya pemahaman terhadap keberagaman budaya, bahasa, nilai, serta keyakinan pasien dalam pelayanan kesehatan. Pendekatan komunikasi yang sensitif terhadap budaya dan spiritualitas menjadi bagian penting dalam menciptakan pelayanan keperawatan yang menghargai martabat pasien serta mendukung hubungan terapeutik yang efektif.

Pada bagian akhir, buku ini membahas komunikasi dalam kedaruratan dan krisis, meliputi landasan teori dan etik komunikasi krisis, penyampaian kabar sulit (breaking bad news), komunikasi konflik, komunikasi eskalasi (escalation communication), serta tantangan psikososial dalam situasi kegawatan. Materi dilengkapi dengan rangkuman dan referensi untuk memperkuat pemahaman mengenai penerapan komunikasi profesional dalam berbagai kondisi pelayanan. Dengan cakupan pembahasan yang sistematis dan aplikatif, Buku Ajar Komunikasi Keperawatan diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa keperawatan, pendidik, perawat, dan tenaga kesehatan dalam mengembangkan kemampuan komunikasi terapeutik yang efektif, empatik, aman, dan sesuai dengan prinsip profesionalisme keperawatan.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7927-11-8 (PDF)



9

786347

927118

